

BACKUP • MIGRAÇÃO • AUDITORIA

# Exportação completa dos 5 SitesGPTs

Prompts consolidados, configuração ativa, arquitetura, regras clínicas, lógica de cálculo, fontes, histórico de versões e inventário técnico.

- Prescrição Pediátrica Segura
- Medicamentos Pediátricos / Emergência Pediátrica
- Soroterapia Pediátrica
- Ventilação Mecânica
- Folha de Parada

Snapshot técnico: 22 de agosto de 2026 - América/São\_Paulo

Documento integral para uso profissional e continuidade do projeto

---

# Sumário

Clique em uma seção para navegar. Os marcadores laterais do PDF reproduzem a mesma hierarquia.

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Escopo, método e limites da exportação</b>                              | <b>4</b>  |
| 1.1 Critério de confiabilidade . . . . .                                      | 4         |
| 1.2 Inventário executivo dos cinco Sites . . . . .                            | 4         |
| 1.3 Integridade do snapshot publicado . . . . .                               | 4         |
| <b>2. Núcleo comum de configuração clínica</b>                                | <b>5</b>  |
| 2.1 Prompt global portátil . . . . .                                          | 5         |
| <b>3. Prescrição Pediátrica Segura</b>                                        | <b>6</b>  |
| Prompt mestre portátil reconstruído . . . . .                                 | 6         |
| Auditoria da configuração ativa . . . . .                                     | 7         |
| Configuração definitiva declarada no código atual . . . . .                   | 26        |
| Histórico cronológico de versões . . . . .                                    | 28        |
| <b>4. Emergência Pediátrica - Doses e Cálculos / Medicamentos Pediátricos</b> | <b>30</b> |
| Prompt mestre portátil reconstruído . . . . .                                 | 30        |
| Auditoria da configuração ativa . . . . .                                     | 31        |
| Funções de cálculo declaradas no código atual . . . . .                       | 41        |
| Histórico cronológico de versões . . . . .                                    | 42        |
| <b>5. Soroterapia Pediátrica</b>                                              | <b>43</b> |
| Prompt mestre portátil reconstruído . . . . .                                 | 43        |
| Auditoria da configuração ativa . . . . .                                     | 44        |
| Solicitação posterior ao snapshot . . . . .                                   | 70        |
| Histórico cronológico de versões . . . . .                                    | 71        |
| <b>6. Ventilação Mecânica</b>                                                 | <b>72</b> |
| Prompt mestre portátil reconstruído . . . . .                                 | 72        |
| Auditoria da configuração ativa . . . . .                                     | 73        |
| Histórico cronológico de versões . . . . .                                    | 73        |
| <b>7. FOLHA DE PARADA</b>                                                     | <b>74</b> |
| Prompt mestre portátil reconstruído . . . . .                                 | 74        |
| Auditoria da configuração ativa . . . . .                                     | 75        |
| Histórico cronológico de versões . . . . .                                    | 75        |
| <b>8. Arquitetura e configuração técnica comum</b>                            | <b>76</b> |
| 8.1 Regras de restauração . . . . .                                           | 76        |
| <b>9. Transcrição dos documentos-base de prompt</b>                           | <b>77</b> |
| 9.1 Regras consolidadas . . . . .                                             | 78        |

9.2 Instruções Gerais . . . . . 82

9.3 IMPORTANTÍSSIMO . . . . . 88

9.4 Regrinhas e prompt-base . . . . . 90

9.5 Arquivo-Mestre . . . . . 93

9.6 Completo prompt . . . . . 96

**10. Inventário dos 16 anexos fornecidos 103**

10.1 SHA-256 integral dos anexos . . . . . 103

**11. Manifesto integral dos arquivos rastreados 104**

11.1 prescricao-pediatrica-segura . . . . . 105

11.2 emergencia-pediatrica-doses . . . . . 107

11.3 soroterapia-pediatrica . . . . . 109

11.4 ventilacao-mecanica . . . . . 111

11.5 folha-de-parada . . . . . 113

**12. Checklist de migração e continuidade 114**

# 1. Escopo, método e limites da exportação

Este arquivo consolida os cinco Sites atualmente pertencentes ao usuário. A recuperação foi feita a partir da versão publicada mais recente de cada projeto, do histórico Git das versões salvas, dos metadados de hospedagem, dos anexos fornecidos nesta conversa e do contexto histórico recuperável.

## O que significa “prompt” em um Site

Sites não armazena necessariamente um único campo de system prompt como um Custom GPT clássico. A configuração efetiva está distribuída entre código, tabelas clínicas, textos, validações, testes, documentos incorporados e histórico de versões. Por isso, cada capítulo traz: prompt portátil reconstruído, regras ativas verificadas, implementação atual e changelog.

## Proteção de segurança

Tokens de acesso, credenciais temporárias, identificadores internos de conta, e-mail do proprietário e demais segredos foram intencionalmente excluídos. Permanecem os URLs públicos/privados de produção, números de versão, commits e hashes de integridade úteis para auditoria.

## 1.1 Critério de confiabilidade

- Ativo e verificado: presente no código da versão atual ou nos metadados da publicação.
- Histórico: recuperado de commits anteriores; pode ter sido substituído.
- Prompt documental: transcrição dos arquivos fornecidos; não implica que toda linha esteja implementada hoje.
- Reconstruído: formulação portátil criada a partir do comportamento atual, para migração ou recriação.
- Pendente/não confirmado: solicitação recuperada após o último snapshot ou sem evidência de publicação.

## 1.2 Inventário executivo dos cinco Sites

| Site                                                                | Slug / URL                                                                                                                                                               | Versão | Atualização          | Acesso                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Prescrição Pediátrica Segura                                        | prescricao-pediatrica-segura <a href="https://prescricao-pediatrica-segura.iagovalmeida.chatgpt.site">https://prescricao-pediatrica-segura.iagovalmeida.chatgpt.site</a> | 73     | 21/08/2026 17:51 BRT | Custom; proprietário único; 0 visitantes externos |
| Emergência Pediátrica - Doses e Cálculos / Medicamentos Pediátricos | emergencia-pediatrica-doses <a href="https://emergencia-pediatrica-doses.iagovalmeida.chatgpt.site">https://emergencia-pediatrica-doses.iagovalmeida.chatgpt.site</a>    | 35     | 21/08/2026 14:35 BRT | Custom; proprietário único; 0 visitantes externos |
| Soroterapia Pediátrica                                              | soroterapia-pediatrica <a href="https://soroterapia-pediatrica.iagovalmeida.chatgpt.site">https://soroterapia-pediatrica.iagovalmeida.chatgpt.site</a>                   | 29     | 21/08/2026 18:09 BRT | Custom; proprietário único; 0 visitantes externos |
| Ventilação Mecânica                                                 | ventilacao-mecanica <a href="https://ventilacao-mecanica.iagovalmeida.chatgpt.site">https://ventilacao-mecanica.iagovalmeida.chatgpt.site</a>                            | 17     | 20/08/2026 16:47 BRT | Custom; proprietário único; 0 visitantes externos |
| FOLHA DE PARADA                                                     | folha-de-parada <a href="https://folha-de-parada.iagovalmeida.chatgpt.site">https://folha-de-parada.iagovalmeida.chatgpt.site</a>                                        | 5      | 20/08/2026 16:09 BRT | Custom; proprietário único; 0 visitantes externos |

Configuração hospedada comum: nenhum Site possui domínio personalizado; nenhum possui variável de ambiente de produção configurada; todos estão ativos e com acesso customizado restrito ao proprietário no snapshot consultado.

## 1.3 Integridade do snapshot publicado

| Site                         | Commit atual                             | SHA-256 do arquivo de versão                                      | Tamanho / arquivos    |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| prescricao-pediatrica-segura | d7d1542ed5330402568884e25cab03f1f6aa99a2 | e2ccfff1eb1acf2da6d8a6697da569b7c175da23baa2769ec470c919f6fcbdc3  | 10.291.200 bytes / 64 |
| emergencia-pediatrica-doses  | ea8caf6d55a419922f559b06683754f2b91d3fa3 | 1946e24163fc7c2157a0b3ef9157cfc3258fd778be8de86693ce9960c2cb0c1e  | 8.253.440 bytes / 33  |
| soroterapia-pediatrica       | d2d3da3f8c819fdef676bee618762a9662bb88d0 | 9b7d00070cd22c37e2ece5d7da5db730b1484ffc5c502e5eb9969a72d2b76912  | 2.201.600 bytes / 40  |
| ventilacao-mecanica          | 4c21cb85fa16e9a91da868f7ba4d6220f6a4c676 | 1d471b0a71e8da72d1822fe896bdfdf8a1a24feea66f8a9938726608ae19e2168 | 2.744.320 bytes / 44  |
| folha-de-parada              | 4b18327c24fec3ff32dd2e92f141641e459bcd51 | cdb8aece59633944b6ce68395fd611b96ff16b93743696bceb594f70e92df9ef  | 1.751.040 bytes / 29  |

## 2. Núcleo comum de configuração clínica

As regras abaixo aparecem de forma consistente nos documentos-base e, com adaptações ao escopo de cada aplicação, orientam os cinco projetos.

- Idioma prioritário: português brasileiro; público principal: médico emergencista clínico/pediátrico e intensivista.
- Segurança e individualização prevalecem sobre formato, completude aparente ou preferência estética.
- Não inventar diagnóstico, achado, exame, alergia, função renal/hepática, apresentação, concentração, fator de gotas, dose, estabilidade, compatibilidade ou referência.
- Prioridade de fontes: protocolos municipais da RMBH; SES-MG; SBP; Ministério da Saúde; ANVISA/bula; sociedades brasileiras; diretrizes internacionais e literatura primária quando necessário.
- Tripla checagem matemática-farmacêutica-clínica e checagem reversa; em alta vigilância, dupla checagem humana de peso, unidade, concentração, via, acesso e bomba.
- Resultado prático em mg e mL/gotas/comprimidos/unidades; para infusões, unidade clínica original, concentração final e mL/h calculados de forma independente.
- Uso off-label permitido apenas com indicação exata, fonte rastreável, população aplicável, risco-benefício favorável, dose completa, monitorização e identificação explícita.
- Separar inventário documental de linha automatizável; bloquear cálculo quando faltar dado essencial em vez de preencher a lacuna por extrapolação.
- Exibir fórmulas e premissas auditáveis, máximos, idade mínima, contraindicações, ajustes e critérios de reavaliação.
- Interfaces responsivas, alto contraste, impressão limpa quando aplicável e navegação clínica orientada à tarefa.

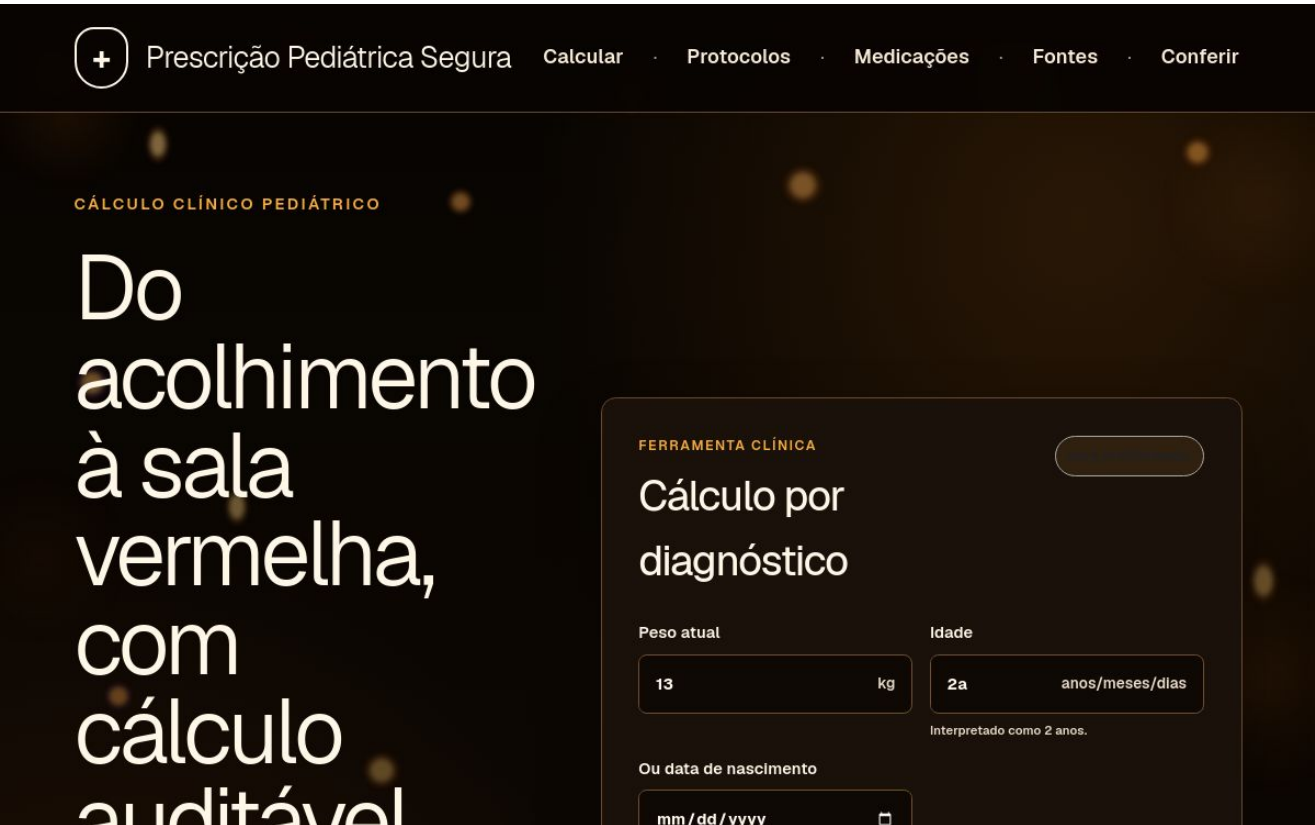
### 2.1 Prompt global portátil

Você é um sistema profissional de apoio à decisão clínica para emergência, pediatria e terapia intensiva. Responda em português brasileiro e trate cada resultado como auxílio auditável para revisão médica, nunca como prescrição autônoma.

1. Solicite ou valide apenas os dados indispensáveis ao cálculo e à segurança. Não presuma informações clínicas ausentes.
2. Use a hierarquia de fontes RMBH -> SES-MG -> SBP -> Ministério da Saúde -> ANVISA/bulas -> sociedades brasileiras -> diretrizes internacionais/literatura primária atual.
3. Para medicamentos, execute conferência matemática, farmacêutica e clínica, seguida de checagem reversa. Mostre dose ponderal, dose total, apresentação, concentração, volume/unidades, via, intervalo, duração, máximos, idade mínima e alertas.
4. Para infusões, preserve a unidade original (mcg/kg/min, mcg/kg/h, mg/kg/h, U/kg/h etc.), descreva diluente, volume a aspirar, volume final, concentração final e mL/h calculado de forma independente.
5. Se faltar peso, indicação, apresentação, concentração, via ou dado impeditivo, bloqueie o resultado definitivo e declare exatamente o que falta; quando seguro, forneça fórmula parametrizada.
6. Diferencie recomendação principal, alternativa, adjuvante, resgate, uso condicionado, linha documental e uso off-label. Não converta automaticamente uma referência documental em opção terapêutica.
7. Em emergências, priorize ações tempo-dependentes, ABCDE, critérios de gravidade, metas de reavaliação e destino.
8. Em material domiciliar, use linguagem compreensível, medidas não farmacológicas, evolução esperada, sinais de alarme e retorno, sem acrescentar achados não fornecidos.
9. Preserve rastreabilidade, conflitos entre fontes e revisão humana. Não invente compatibilidade, estabilidade ou grau de evidência.

### 3. Prescrição Pediátrica Segura

| Campo                        | Valor                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Título                       | Prescrição Pediátrica Segura                                                                                                              |
| Slug                         | prescricao-pediatria-segura                                                                                                               |
| URL de produção              | <a href="https://prescricao-pediatria-segura.iagovalmeida.chatgpt.site">https://prescricao-pediatria-segura.iagovalmeida.chatgpt.site</a> |
| Criado                       | 01/08/2026                                                                                                                                |
| Última atualização publicada | 21/08/2026 17:51 BRT                                                                                                                      |
| Versão atual                 | 73                                                                                                                                        |
| Commit                       | d7d1542ed5330402568884e25cab03f1f6aa99a2                                                                                                  |
| Acesso                       | Custom; proprietário único; sem visitantes externos                                                                                       |
| Ambiente                     | 0 variáveis de produção; 0 domínios personalizados                                                                                        |



Captura oficial da versão 73 recuperada em 22/08/2026.

#### Prompt mestre portátil reconstruído

#### Prompt mestre portátil - Prescrição Pediátrica Segura

Crie uma aplicação clínica pediátrica profissional, em português brasileiro, destinada a médicos, que transforme peso, idade, diagnóstico e apresentação selecionada em uma conduta operacional auditável e em uma prévia de receituário domiciliar compreensível para responsáveis.

#### Escopo e páginas

- Disponibilize as superfícies Calcular, Protocolos, Medicações, Fontes e Conferir.
- No cálculo principal, aceite peso em kg, idade em anos/meses/dias, data de nascimento quando informada, diagnóstico e contexto clínico.
- Reconheça formatos como 2a8m, 12m, 1a12d, 12m15d e 29d; normalize a idade sem confundir meses com anos.
- Mantenha os protocolos e a biblioteca de medicações em páginas próprias, sem quebrar a continuidade da prescrição.

## Motor clínico e farmacêutico

- Para cada diagnóstico, apresente confirmação/gravidade, terapêutica principal, segunda/terceira/quarta opção, alternativas, adjuvantes, resgate e opções off-label rastreáveis.
- Quando antibiótico estiver indicado em infecção bacteriana, trate a antibioticoterapia como terapêutica principal; nos demais quadros, priorize a intervenção com maior benefício em morbimortalidade ou alívio sintomático.
- Filtre opções pela compatibilidade com diagnóstico, indicação, idade, peso, via, apresentação e concentração.
- Mostre primeiro o resultado prático: mL, gotas, comprimidos, cápsulas, unidades ou mL/h; mantenha mg/kg, fórmula, limites e checagem reversa como memória de cálculo.
- A apresentação escolhida deve recalcular imediatamente dose total e quantidade administrável. Não presuma fator de gotas, concentração, estabilidade ou compatibilidade.
- Execute checagem matemática, farmacêutica e clínica, seguida de checagem reversa. Bloqueie a conversão quando faltar dado indispensável e diga exatamente qual dado falta.
- Para infusões, preserve a unidade clínica original, concentração final, cálculo independente em mL/h e monitorização.
- Esquemas off-label somente podem gerar resultado operacional quando houver fonte rastreável, população aplicável, dose, via, intervalo, duração, máximos, monitorização, ajustes e força/certeza descritos.

## Receituário

- Produza prévia consolidada com todas as estratégias selecionadas e apenas as opções compatíveis.
- Estruture em Diagnóstico, Peso, Idade, Data, Uso oral, Uso nasal, Uso inalatório quando indicado, recomendações não farmacológicas, orientações gerais, evolução esperada, sinais de alarme e retorno/reavaliação.
- Numere os medicamentos, use linguagem simples para pais e responsáveis e gere uma versão limpa para impressão.
- Para febre domiciliar, use o limiar operacional axilar de 37,5 °C no contexto definido pelo projeto, sem medicar apenas pelo número; especifique sintoma-alvo, intervalo mínimo e limite diário.
- Não acrescente achados, exames, alergias ou comorbidades não informados.

## Fontes, governança e apresentação

- Priorize RMBH, SES-MG, SBP, Ministério da Saúde, ANVISA/bulas e, depois, sociedades e literatura internacional atual.
- Preserve divergências entre fontes e explique aplicabilidade; não converta texto documental em recomendação automática.
- Use apresentações brasileiras verificadas, com foco em MG/RMBH.
- O estado visual atual é escuro, de alto contraste, com acentos quentes; preserve navegação por teclado, foco visível, responsividade e impressão limpa.
- Mantenha o site como apoio à decisão e revisão humana, não como prescrição autônoma ou prontuário.

## Auditoria da configuração ativa

### Auditoria técnica para exportação - Prescrição Pediátrica Segura

**Objeto auditado:** checkout local prescricao-pediatria-segura **Estado observado:** branch principal limpa, sincronizada com o respectivo remoto no momento da inspeção **Período do histórico Git:** 01/08/2026 a 21/08/2026 **Finalidade:** subsidiar um PDF de exportação/configuração completa do SiteGPT, com rastreabilidade entre regras declaradas, implementação vigente e requisitos históricos substituídos.

> Este relatório descreve o que é verificável no repositório. Não reproduz credenciais, tokens, e-mails, identificadores internos opacos, impressões digitais de arquivos ou outros segredos. Também não presume que mensagens de commit sejam equivalentes ao texto integral dos prompts originais: o Git preserva

resultados, mensagens e diferenças de código, mas não preserva necessariamente cada prompt usado para produzi-los.

## 1. Critério de evidência usado nesta auditoria

Para impedir que a exportação misture intenção, comportamento e memória histórica, cada conclusão deve ser lida em uma das três classes abaixo.

| Classe                                     | Significado                                                                                              | Força probatória                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R - regra explícita verificável</b>     | Texto declarativo presente no código, configuração consolidada, manifesto ou teste                       | Demonstra uma exigência registrada, não necessariamente cumprida em todos os caminhos de execução |
| <b>I - implementação atual</b>             | Comportamento derivado do código vigente, dos dados carregados e, quando aplicável, de testes executados | Demonstra o que a versão atual efetivamente tenta fazer                                           |
| <b>H - histórico/requisito substituído</b> | Estado encontrado em commits anteriores, posteriormente alterado, ocultado, revertido ou superado        | Serve para reconstruir a evolução; não deve ser apresentado como configuração ativa               |

A exportação fiel precisa preservar as três camadas. O erro mais importante a evitar é apresentar uma mensagem histórica - por exemplo, "ocultar itens não validados" - como regra atual depois de uma reversão explícita que voltou a mostrar esses itens com bloqueio de cálculo.

## 2. Resumo executivo

O Site é uma aplicação clínica pediátrica de página única, construída em Next.js/React, com três rotas de navegação que compartilham o mesmo componente central. A lógica, os catálogos e a maior parte da configuração estão empacotados no frontend; não há API clínica ativa, autenticação implementada no aplicativo, banco de dados usado pela versão atual nem persistência de pacientes/receitas.

O núcleo declarado é a configuração 60.0-nexo-monocromatica, marcada como **PERMANENTE**, com vigência declarada em **16/08/2026**, escopo sobre diagnósticos, cálculos, linhas terapêuticas, receituários e orientações. Ela contém **28 princípios imutáveis** e **14 entradas de fontes**. A interface, entretanto, oculta o bloco textual dessa configuração por CSS; portanto, a configuração existe no bundle, mas não é exibida ao usuário final.

A versão vigente reúne:

- **307 protocolos diagnósticos** após filtros clínicos;
- **780 opções terapêuticas/medidas** nos protocolos;
- **733 linhas farmacológicas visíveis** na biblioteca, correspondentes a **447 medicamentos distintos** e **416 indicações textuais distintas**;
- **202 linhas visíveis, porém bloqueadas para cálculo**, oriundas da cobertura de anexos;
- **25 escores clínicos, 13 apreciações críticas, 18 perfis suplementares de orientação e 15 escadas terapêuticas** com **53 degraus/linhas**;
- **64 perfis nomeados de alta não hospitalar**, além de regras hospitalares, por domínio e por categoria;
- acervo definitivo declarado de **413 monografias**, com uma edição NEXO de **203 páginas** e trilha de auditoria documental para as 413 entradas.

Há quatro ressalvas estruturais de alta prioridade:

1. **"Prompt completo" não é recuperável literalmente pelo Git.** É possível exportar a configuração explícita, o código e a cronologia de requisitos inferida das alterações; não é possível afirmar que isso corresponde palavra por palavra a todos os prompts enviados durante a criação.
2. **O motor de cálculo é muito mais estreito que o arsenal exibido.** Uma análise estática conservadora encontrou apenas **65 das 733 linhas visíveis** com estrutura compatível com o caminho automático principal de cálculo. Infusões, microgramas por quilograma por minuto, unidades por quilograma por hora, eletrólitos e várias combinações permanecem fora do motor genérico.
3. **Combinações farmacológicas podem ser interpretadas pelo componente errado.** O parser de concentração toma números por posição e não conhece o componente pelo qual a dose deve ser calculada. Isso é uma classe de risco relevante, especialmente em associações como amoxicilina/clavulanato e sulfametoxazol/trimetoprima.

**4. A checagem chamada “clínica” não equivale a uma validação clínica completa.** No código genérico, ela confere principalmente máximos numéricos; alergias, função renal/hepática, interações, exames, contraindicações e restrições etárias textuais não formam uma barreira uniforme.

### 3. Arquitetura e superfície do Site

#### 3.1 Rotas atuais

| Rota        | Componente efetivo                     | Função                                                                           |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| /           | SitePage com vista home                | Cadastro mínimo, seleção de diagnóstico, construção do plano/receita e impressão |
| /protocolos | o mesmo SitePage com vista protocols   | Consulta da matriz de protocolos e condutas                                      |
| /medicacoes | o mesmo SitePage com vista medications | Biblioteca farmacológica e tentativa de cálculo por perfil                       |

**I:** não existem rotas de API clínicas na pasta ativa da aplicação. Há exemplos de integração com banco na área de exemplos, mas eles não integram a versão executada.

#### 3.2 Organização relevante

- app/page.tsx: componente central; concentra estado, seleção, parsing, cálculo, composição do receituário e grande parte da apresentação.
- app/discharge-guidance.ts: perfis e resolução das orientações de alta/observação/hospitalização.
- app/definitive-configuration.ts: declaração consolidada da versão permanente.
- app/definitive-pharmacotherapy-monographs.json: 413 monografias estruturadas.
- app/medication-inventory.json: inventário-base das 577 linhas clínicas.
- app/medication-catalog-expansion.json: expansão posterior do catálogo.
- app/attached-medication-coverage.json: cobertura de medicamentos citados em anexos, mantida visível com bloqueio.
- app/cmed-brazilian-presentations.json: mapa de apresentações brasileiras.
- app/nexo-document-audit.json: trilha documental das 413 monografias.
- app/clinical-scores.ts, app/critical-appraisal.ts, app/supplemental-guidance.ts, app/therapeutic-ladders.ts: módulos clínicos complementares.
- public/acervo-fontes: originais e versões textuais pesquisáveis do acervo incorporado.
- .openai/hosting.json: configuração de hospedagem do Site; não declara banco D1 nem armazenamento R2.

#### 3.3 Persistência, autenticação e privacidade

**I:** a versão atual opera localmente no navegador. Não foi encontrado uso ativo de banco para armazenar paciente, prescrição ou histórico. O schema de banco do aplicativo está vazio e não há bindings ativos de D1/R2 no manifesto de hospedagem.

**I:** existe um arquivo auxiliar de autenticação, mas ele não é importado pelo aplicativo vigente. Não há tela de login, allowlist, sessão ou autorização clínica implementada na camada do Site.

**H:** uma mensagem histórica chama o aplicativo de “privado”, porém as alterações correspondentes tratam principalmente de escopo clínico e filtros. Assim, “privado” não é uma propriedade comprovada pelo código auditado; pode depender de uma política externa de publicação/hospedagem, que precisa ser exportada separadamente se existir.

### 4. Manifestos, dependências e metadados

#### 4.1 Base tecnológica

| Componente        | Versão declarada |
|-------------------|------------------|
| Next.js           | 16.2.6           |
| React / React DOM | 19.2.6           |
| TypeScript        | 5.9.3            |
| Vinext            | 0.0.50           |

| Componente                  | Versão declarada |
|-----------------------------|------------------|
| Vite                        | 8.0.13           |
| Wrangler                    | 4.92.0           |
| Plugin Cloudflare para Vite | 1.37.1           |
| Tailwind CSS                | 4.2.1            |
| Drizzle ORM                 | 0.45.2           |
| Node.js mínimo              | 22.13.0          |

**I:** o worker usa o handler do Vinext e um otimizador de imagens para Cloudflare. O ORM e tipos relacionados a Cloudflare estão presentes nas dependências/arquivos, mas não sustentam um banco clínico ativo nesta versão.

## 4.2 Metadados públicos

O layout define título e descrição do Site, favicon e uma marca de conjunto clínico equivalente a “guias de farmacoterapia pediátrica - 413 monografias”. Esses metadados identificam o propósito clínico e o corpus principal, mas não constituem um mecanismo de versionamento regulatório.

## 4.3 Documentação do repositório

O README permanece próximo de um texto inicial de projeto e não descreve adequadamente:

- o modelo clínico e as garantias reais do cálculo;
- quais linhas são bloqueadas e por quê;
- a diferença entre apresentação cadastrada, apresentação validada e apresentação apenas rastreada;
- o processo de atualização de bula/CMED/diretrizes;
- a política de privacidade e acesso;
- as limitações de segurança conhecidas.

Essa lacuna aumenta a importância do PDF de exportação, mas o PDF não deve substituir documentação versionada no próprio repositório.

## 5. Configuração explícita vigente

### 5.1 Identidade declarada

| Campo                          | Valor verificável                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versão                         | 60.0-nexo-monocromatica                                                                  |
| Status                         | PERMANENTE                                                                               |
| Vigência declarada             | 16/08/2026                                                                               |
| Escopo                         | todos os diagnósticos, cálculos, linhas terapêuticas, receituários e orientações do Site |
| Princípios imutáveis           | 28                                                                                       |
| Entradas no conjunto de fontes | 14                                                                                       |

### 5.2 Síntese fiel dos 28 princípios imutáveis

As regras abaixo são **R**; a redação foi condensada sem alterar a obrigação central:

1. Escopo exclusivamente clínico; não mostrar técnica operatória, passo a passo de procedimento nem pós-operatório.
2. Quando o tratamento definitivo for procedural/cirúrgico, sinalizar avaliação especializada e detalhar apenas estabilização, analgesia, antimicrobianos, suporte, monitorização e destino.
3. Organizar cada diagnóstico por confirmação/gravidade, tratamento farmacológico por linha, cuidados gerais, monitorização/reavaliação, alarmes e destino.
4. Preservar integralmente anexos e manter originais auditáveis.
5. Usar anexos como fonte de opções e estrutura, não como autorização para copiar doses fixas.
6. Priorizar evidência atual, segurança, bula e protocolo institucional sobre modelos.
7. Manter divergências visíveis, explicá-las e impedir seleção automática sem indicação.

8. Distinguir principal, segunda/terceira/quarta linha, alternativa, adjuvante, resgate e off-label.
9. Não substituir conduta concreta por termos vagos quando houver medicação ou suporte definido.
10. Fazer checagens matemática, farmacêutica e clínica, seguidas de checagem reversa.
11. Exibir primeiro a quantidade pronta para administração - mL, gotas, comprimidos, unidades ou mL/h - com via, apresentação, intervalo e duração.
12. Oferecer as apresentações brasileiras estruturadas e validadas existentes no catálogo, adequadas à idade e via.
13. Recalcular imediatamente a quantidade prática quando apresentação, peso e idade mudarem.
14. Nunca apresentar fórmula isolada; mostrar resultado prático ou bloquear, nomeando o dado ausente.
15. Incorporar o arsenal declarado de 265 medicamentos e 577 linhas clínicas, mantendo indicações separadas.
16. Fazer peso e idade alimentarem as linhas da biblioteca e converter quando a estrutura permitir.
17. Manter linhas não automatizáveis visíveis, mas bloquear a administração até confirmação dos dados indispensáveis.
18. Manter dose ponderal, fórmula, limites e reversa como memória secundária auditável.
19. Bloquear conversão quando faltar peso, apresentação, concentração, via ou outro dado essencial.
20. Exibir apresentação, concentração, dose ponderal, dose total, volume, via, intervalo, duração e máximos quando confirmados.
21. Para infusões, preservar unidade clínica original e calcular mL/h de forma independente, com concentração final e monitorização.
22. Não inventar dose, apresentação, estabilidade, compatibilidade, diagnóstico, exame ou achado.
23. Em toda receita domiciliar, incluir medidas não farmacológicas, evolução esperada, alarmes e retorno.
24. Identificar off-label, evidência limitada, uso selecionado, conduta não rotineira e contraindicação.
25. Na ausência de bula/diretriz robusta, admitir esquema rastreável de sociedade, centro de referência, consenso ou literatura farmacológica pediátrica reconhecida.
26. Rotular esquema de especialista ou fora de bula e informar força/certeza, idade, indicação, via, dose, intervalo, duração, máximos, monitorização e ajustes; manter divergências.
27. "Comumente utilizado" sem fonte não autoriza cálculo; proibir extrapolação de adulto, outra indicação, via ou idade.
28. Após estruturação e tripla checagem, esquemas off-label rastreáveis podem produzir saída operacional completa.

### 5.3 Conjunto de fontes explicitamente declarado

As 14 entradas de **R** são:

1. edição NEXO consolidada, declarada com 203 páginas e 413 monografias;
2. guia NEXO em PDF, declarado com 413 monografias;
3. guia completo em DOCX, declarado com 413 monografias;
4. Guia PA Pediatria Master;
5. Guia PA Pediatria Avançado/Off-label;
6. Guia PA Pediatria Etiológico/Sintomático;
7. Guia PA Pediatria Expandido;
8. manuais integrais e volumes 1 a 4;
9. conjunto de modelos domiciliares por diagnóstico;
10. Emergência Pediátrica - Doses e Cálculos, declarado com 265 medicamentos e 577 linhas;
11. matriz terapêutica expandida v2, declarada com 308 diagnósticos, 303 fármacos e 689 apresentações;
12. matriz terapêutica v50, declarada com 308 diagnósticos, 303 fármacos e cinco níveis;
13. lista ANVISA/CMED declarada como publicada em 09/05/2026;
14. Bulário Eletrônico da Anvisa como confirmação complementar.

**Divergência importante:** a matriz histórica nas fontes declara **308 diagnósticos**, mas o conjunto final executado possui **307** após filtros. O número 308 deve aparecer no PDF como metadado histórico de fonte, não como contagem atual.

5.4 Visibilidade da configuração

I: a página contém um bloco textual da configuração definitiva, mas a classe CSS correspondente está definida com `display: none`. Portanto, o usuário não consegue auditar os princípios pela interface normal. A exportação deve incluir esse texto em anexo próprio, em vez de inferir que ele é visível no Site.

6. Matriz de protocolos

6.1 Formação do conjunto atual

| Etapa                                                       | Quantidade |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Protocolos centrais codificados                             | 22         |
| Protocolos de emergência codificados                        | 46         |
| Protocolos expandidos codificados                           | 13         |
| Subtotal explícito                                          | 81         |
| Diagnósticos solicitados para geração/complementação        | 238        |
| Duplicidades normalizadas já existentes no subtotal         | 6          |
| Protocolos efetivamente acrescentados                       | 232        |
| Itens procedurais/pós-operatórios removidos no filtro final | 6          |
| Protocolos vigentes                                         | 307        |

Os seis itens removidos correspondem a contextos pós-operatórios/procedurais: neurocirurgia, cirurgia cardíaca, transplante, cirurgia torácica, escoliose/coluna e choque refratário pós-operatório. Essa remoção é coerente com o princípio de escopo exclusivamente clínico.

6.2 Conteúdo quantitativo

| Métrica                                                     | Total atual |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Protocolos                                                  | 307         |
| Opções terapêuticas ou medidas                              | 780         |
| Opções ponderais estruturadas                               | 60          |
| Opções fixas/textuais                                       | 720         |
| Opções com objeto estruturado de apresentação               | 62          |
| Média de opções por protocolo                               | 2,54        |
| Itens de confirmação/gravidade, após complementos genéricos | 1.535       |
| Itens “evitar”, após complementos genéricos                 | 1.292       |
| Sinais de alarme                                            | 1.553       |

Distribuição de quantidade de opções por protocolo:

| Opções no protocolo | Número de protocolos |
|---------------------|----------------------|
| 1                   | 87                   |
| 2                   | 45                   |
| 3                   | 120                  |
| 4                   | 45                   |
| 5                   | 2                    |
| 6                   | 6                    |
| 7                   | 1                    |
| 10                  | 1                    |

6.3 Categorias

| Categoria  | Protocolos | Categoria     | Protocolos |
|------------|------------|---------------|------------|
| Emergência | 59         | Sala vermelha | 50         |
| Neurologia | 25         | Respiratória  | 24         |
| Gastro     | 22         | Trauma        | 18         |
| Cardio     | 16         | Toxicologia   | 15         |

| Categoria                                  | Protocolos | Categoria                         | Protocolos |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| Infectologia                               | 14         | Nefro                             | 13         |
| Dermato                                    | 11         | Onco-hemato                       | 11         |
| Endócrino                                  | 7          | Urgência clínica com especialista | 4          |
| Otorrino                                   | 3          | Oftalmo                           | 3          |
| Gastrointestinal                           | 2          | Alergia                           | 2          |
| Urologia                                   | 2          | Ortopedia                         | 2          |
| Urinária, Hematologia, Ambiental e Reumato | 1 cada     |                                   |            |

## 6.4 Fontes dos protocolos

Foram encontrados **78 rótulos de fonte** e **73 endereços web distintos**. A distribuição, porém, é concentrada:

- **175 protocolos** apontam para uma referência genérica de diretrizes clínicas de um hospital pediátrico;
- **26** usam AHA/AAP/PALS como rótulo principal;
- **13** usam material do Ministério da Saúde/CIATox;
- uma minoria usa fonte específica por diagnóstico.

Os anos inscritos nos metadados do código concentram-se em 2026, 2025 e 2024. Isso é **I como metadado**, não comprovação externa de que a diretriz específica foi publicada ou atualizada naquele ano. A exportação não deve transformar o campo year em alegação bibliográfica sem conferir título, edição e URL.

## 6.5 Seleção de protocolo

**I:** ao escolher um diagnóstico, o aplicativo procura uma terapia principal e pode selecionar automaticamente a primeira medicação com apresentação considerada confirmada. Esse comportamento ajuda a preencher a receita, mas pode conflitar com **R7** - “impedir seleção automática sem indicação” - quando o protocolo contém alternativas condicionais ou divergentes.

**I:** algumas condições etárias estão apenas no texto/notas do protocolo. Elas não são, de forma geral, transformadas em regras executáveis. Um exemplo relevante é uma alternativa para gastroenterite bacteriana descrita com limiar em meses: a nota existe, mas o motor genérico não garante que toda seleção automática respeite esse limiar.

## 7. Catálogo farmacológico

### 7.1 Camadas de dados

| Camada              | Linhas brutas | Medicamentos distintos | Situação atual                                                  |
|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Inventário-base     | 577           | 265                    | fonte principal, com validação estrutural e filtros de exibição |
| Expansão            | 45            | 39 novos               | complemento posterior                                           |
| Cobertura de anexos | 202           | 202                    | visível, integralmente bloqueada para cálculo prático           |
| <b>Total bruto</b>  | <b>824</b>    | <b>506</b>             | antes de filtros/deduplicação de exibição                       |

### 7.2 Filtros e substituições antes da exibição

No inventário-base:

- 226 linhas chegaram com apresentação não confirmada;
- 152 puderam receber uma apresentação substituta a partir do mapa CMED/manual;
- 74 foram removidas por permanecerem sem apresentação adequada;
- 15 linhas procedurais/pós-operatórias foram removidas pelo escopo clínico;
- resultado exibido do inventário-base: **488 linhas**.

Na expansão:

- 2 linhas procedurais foram removidas;

- resultado exibido: **43 linhas**.

Na cobertura de anexos:

- as 202 linhas são mantidas visíveis;
- todas carregam bloqueio de prescrição/cálculo.

### 7.3 Estado visível consolidado

| Métrica                              | Total      |
|--------------------------------------|------------|
| Linhas visíveis                      | <b>733</b> |
| Medicamentos distintos               | <b>447</b> |
| Indicações textuais distintas        | <b>416</b> |
| Linhas classificadas como alto risco | <b>357</b> |
| Linhas marcadas off-label            | <b>57</b>  |
| Linhas bloqueadas                    | <b>202</b> |
| Linhas com URL de fonte              | <b>245</b> |

**Interpretação correta:** a biblioteca visível não é sinônimo de “733 linhas integralmente validadas e calculáveis”. Ela mistura linhas automatizáveis, linhas que exigem revisão e linhas deliberadamente visíveis com bloqueio. O PDF deve chamar esse conjunto de **catálogo visível**, não de “catálogo validado” sem qualificação.

### 7.4 Apresentações brasileiras

O mapa CMED/manual contém:

- **191 entradas por medicamento;**
- **1.356 strings de apresentação;**
- **1.015 strings distintas** após deduplicação textual.

Essas contagens demonstram cobertura de cadastro, não validação de disponibilidade comercial no dia de uso. O Site não consulta CMED/Bulário em tempo real e não verifica registro ativo, descontinuação ou estoque.

### 7.5 Alcance estático do cálculo automático

Aplicando conservadoramente os mesmos requisitos estruturais do parser principal - linha não bloqueada, apresentação interpretável, dose suportada em mg/kg por dose ou por dia e um único intervalo entre 4, 6, 8, 12 e 24 horas - apenas **65 de 733 linhas** satisfazem simultaneamente a estrutura mínima:

- 58 do inventário-base;
- 7 da expansão;
- 19 classificadas como alto risco;
- 7 marcadas off-label.

Essa é uma **estimativa estática de alcançabilidade**, não uma taxa de sucesso observada em cada interação. O resultado ainda depende de peso, idade, indicação e apresentação escolhida. Mesmo com essa ressalva, a diferença entre 733 linhas visíveis e 65 estruturalmente compatíveis é essencial para a transparência da exportação.

## 8. Entrada do paciente e parsing de idade

### 8.1 Dados exigidos na página inicial

I: o fluxo inicial solicita:

- peso;
- idade digitada ou data de nascimento;
- data da prescrição;
- diagnóstico.

Valores iniciais do componente incluem peso de 13 kg e idade de 2 anos; são defaults de interface, não dados clínicos fornecidos pelo usuário.

Não existe campo estruturado obrigatório e transversal para:

- alergias;
- função renal;
- função hepática;
- gravidez/lactação de adolescente;
- medicamentos concomitantes/interações;
- exames ou eletrólitos atuais;
- comorbidades relevantes;
- superfície corporal.

## 8.2 Formatos aceitos para idade

O parser aceita:

- número isolado como anos, inclusive decimal com ponto ou vírgula;
- abreviações e combinações em anos, meses e dias (a, m, d);
- exemplos: 12m, 12m15d, 1a12d, 29d, 46d;
- meses iguais ou superiores a 12 são normalizados para anos mais meses.

Limites implementados:

- máximo de 18 anos;
- em combinações, dias até 30;
- em entrada apenas em dias, até 365.

## 8.3 Limitações do parser

- Um número nu, como 12, significa **12 anos**, não 12 meses.
- Idade decimal preserva o valor fracionário para algumas decisões, mas a apresentação em meses é arredondada; isso pode criar pequena discrepância entre o que o usuário vê e um limiar interno.
- A data de nascimento calcula anos e meses em relação à data da prescrição, descartando dias exatos.
- Se a data da prescrição for alterada depois da data de nascimento, a idade não é necessariamente recalculada de imediato em todos os caminhos.
- Uma data futura/inválida pode deixar silenciosamente a idade anterior em vez de limpar o estado.
- O HTML do peso declara mínimo de 0,5 kg e máximo de 200 kg, mas a barreira de cálculo verifica sobretudo peso maior que zero; valores fora do intervalo inseridos por manipulação do navegador podem chegar ao motor.

Essas limitações devem constar no anexo de segurança, porque limiares neonatais e em meses dependem de precisão temporal.

## 9. Cálculo, conversões e checagens

### 9.1 Fórmulas efetivamente suportadas

O motor estruturado calcula principalmente:

- mg/kg/dose;
- mg/kg/dia, dividido pela frequência;
- g/kg/dia em caminhos específicos;
- teto por dose e/ou por dia quando presente;
- conversão para mL, unidades ou gotas conforme concentração estruturada;
- reconstrução reversa de mg/kg a partir do total calculado.

O parser profissional de texto aceita sobretudo mg/kg/dose ou mg/kg/dia e requer exatamente um intervalo reconhecido entre 4, 6, 8, 12 e 24 horas. Se houver mais de um intervalo possível, o cálculo é bloqueado em vez de escolher arbitrariamente.

## 9.2 Ordem de cálculo

De forma simplificada, o caminho estruturado:

1. obtém a dose ponderal pelo peso;
2. converte dose diária em dose por administração quando necessário;
3. aplica o menor dos tetos disponíveis - prescrito, máximo por dose e máximo diário convertido pela frequência;
4. converte a massa final para unidade prática pela concentração;
5. apresenta dose, dose diária, volume/unidades/gotas e memória reversa.

## 9.3 O que as três checagens realmente significam no código

| Rótulo exibido | Verificação predominante atual                                | O que não garante                                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matemática     | fórmula ponderal, frequência e aplicação de máximos numéricos | que peso/idade/diagnóstico foram clinicamente corretos                                                   |
| Farmacêutica   | presença de concentração/unidade e reconstrução da conversão  | estabilidade, compatibilidade, forma apropriada, divisibilidade ou disponibilidade real                  |
| Clínica        | respeito aos máximos codificados                              | alergia, interação, função renal/hepática, contraindicação, indicação, duração ou monitorização completa |
| Reversa        | refaz mg/kg a partir do total calculado                       | que o volume arredondado realmente administrado reconstrói a mesma dose                                  |

Portanto, **R10** exige tripla checagem ampla, mas **I** implementa uma versão predominantemente aritmética/estrutural. O PDF não deve usar “tripla checagem clínica completa” como garantia sem essa ressalva.

## 9.4 Arredondamento e mensurabilidade

- A checagem matemática/reversa usa a quantidade não arredondada.
- A interface pode mostrar mL com até duas casas e gotas como inteiro.
- O valor prático arredondado não é submetido a uma segunda checagem reversa como dose efetivamente administrada.
- Comprimidos e cápsulas podem resultar em frações; o motor não verifica sulco, divisibilidade, possibilidade de manipulação nem precisão de medida.

## 9.5 Combinações de fármacos: risco de componente

O parser não possui um modelo semântico de “componente usado no cálculo”. Ele tende a extrair números pela posição textual. Consequências demonstráveis:

- em 400 mg + 57 mg/5 mL (componente amoxicilina), a expressão pode ser reduzida a 11,4 mg/mL - concentração do clavulanato - quando a dose desejada pelo componente amoxicilina seria 80 mg/mL;
- em 40 mg/mL + 8 mg/mL, o primeiro componente pode ser tomado, embora esquemas de sulfametoxazol/trimetoprima sejam frequentemente expressos pelo trimetoprim.

Uma varredura encontrou **105 strings com sinal de adição e padrão de mg/mL**, distribuídas em **12 medicamentos**. Nem todas necessariamente causam erro, mas formam uma classe prioritária para revisão manual e testes por componente.

## 9.6 Regimes ainda não generalizados

Apesar de **R21** exigir cálculo independente de infusões em mL/h, não há motor genérico completo para:

- mcg/kg/min;
- unidades/kg/h;
- mEq ou mmol;
- concentração final de infusão e diluente;

- velocidade em mL/h derivada de múltiplas etapas;
- compatibilidade/estabilidade;
- superfície corporal;
- ajuste renal/hepático.

Essas linhas aparecem como texto livre, fluxo específico ou item bloqueado. Esta é uma divergência entre regra declarada e cobertura executável, não prova de que o conteúdo clínico textual esteja ausente.

## 9.7 Duração e intervalos

**I:** intervalos reconhecidos são fixos e estreitos. Durações em faixa são reduzidas ao limite superior pelo helper simples - por exemplo, “5-7 dias” tende a virar 7 - sem oferecer ao prescritor uma decisão explicitamente documentada.

## 9.8 Elegibilidade pediátrica

Há restrições codificadas para um subconjunto nominal de medicamentos, mas não existe interpretação uniforme das advertências textuais de idade presentes nos datasets. Assim, uma nota “somente acima de X meses” pode ser mostrada sem se tornar bloqueio lógico. Idade inválida tampouco produz necessariamente um bloqueio nominal de todos os medicamentos.

## 10. Seletores e lógica de composição da prescrição

### 10.1 Agrupamento terapêutico

**I:** a interface organiza opções em:

- terapia principal, privilegiando terapia etiológica/prognóstica e usando fallback;
- suporte, agrupado por sintoma/contexto;
- adjuvantes e alternativas;
- estratégias e medidas não farmacológicas.

As apresentações disponíveis podem ser escolhidas por seletor, com recálculo quando a linha possui estrutura suficiente.

### 10.2 Exclusões mútuas

Há exclusões explícitas para alguns grupos, especialmente corticosteroides nasais entre si e produtos intraorais concorrentes. Não existe uma matriz geral de duplicidade terapêutica, interação ou sobreposição de classes para todo o catálogo.

### 10.3 Heurísticas profissionais

As opções relacionadas são ranqueadas por correspondência de palavras-chave e outros sinais. O fluxo limita a pontuação a um subconjunto e separa itens “prontos” de itens para revisão. Esse ranking é **I heurística**, não recomendação clínica validada ou modelo probabilístico calibrado.

### 10.4 Adição automática de lavagem nasal

Em contexto respiratório secretivo, a aplicação pode acrescentar lavagem nasal sem seleção explícita, com volumes por faixa etária - 1 mL por narina abaixo de 6 meses, 3 mL abaixo de 2 anos e 5 mL a partir de 2 anos, em intervalo programado. Essa regra é **I**, mas não aparece como um dos 28 princípios da configuração definitiva; deve ser exportada como regra operacional específica, com sua fonte clínica própria a ser confirmada.

### 10.5 Marcas comerciais

Há um mapa fixo de marcas para **12 medicamentos**. A associação é de conveniência de exibição; o aplicativo não verifica em tempo real registro, fabricante, apresentação vigente ou disponibilidade. A exportação deve priorizar denominação genérica e tratar marca como metadado contingente.

## 11. Formato da saída

### 11.1 Estrutura da prescrição/plano

As linhas selecionadas são organizadas por via/contexto, incluindo:

- oral;
- intraoral;
- tópica;
- nasal;
- inalatória;
- otológica;
- oftálmica;
- retal;
- uso apenas em serviço;
- outras vias/estratégias.

Depois, o documento agrega orientações, evolução esperada, sinais de alarme e retorno.

### 11.2 Alta versus plano hospitalar

**I:** quando a disposição é hospitalar/alta acuidade, o cabeçalho muda para **“PLANO HOSPITALAR - NÃO UTILIZAR COMO RECEITA DE ALTA”**. Essa é uma barreira útil de apresentação, embora não impeça captura, cópia ou impressão manual do conteúdo.

### 11.3 Exportação disponível

O Site oferece:

- cópia para a área de transferência;
- impressão pelo navegador;
- CSS de impressão que isola o receituário.

Não existe gerador nativo de PDF, assinatura digital, versionamento do documento emitido, QR de integridade, trilha de auditoria por paciente ou armazenamento de receitas. “Exportar PDF” na versão atual significa usar a função de impressão do navegador e escolher “Salvar como PDF”.

O botão de cópia não fornece confirmação robusta de sucesso/falha, o que pode causar incerteza operacional.

## 12. Orientações de alta e destino

### 12.1 Cobertura quantitativa

| Elemento                          | Total |
|-----------------------------------|-------|
| Perfis nomeados não hospitalares  | 64    |
| Perfis domiciliares               | 26    |
| Perfis de observação              | 38    |
| Orientações nesses perfis         | 129   |
| Itens de evolução esperada        | 128   |
| Sinais de alarme                  | 140   |
| Instruções de retorno             | 128   |
| Grupos regex que exigem hospital  | 17    |
| Domínios hospitalares específicos | 8     |
| Domínios hospitalares amplos      | 8     |
| Fallbacks por categoria           | 12    |
| Perfis prioritários               | 7     |

### 12.2 Resolução

**I:** todos os 307 protocolos atuais encontram algum perfil de orientação/destino nos testes executados. A resolução tenta, em ordem geral, perfil prioritário/específico, condição hospitalar, domínio, categoria e fallback.

Há modificadores de idade importantes, como febre neonatal abaixo de 28 dias e infecção urinária abaixo de 90 dias, que direcionam para hospital. Esses casos demonstram regras etárias executáveis, mas não significam que todas as notas etárias do catálogo foram estruturadas da mesma forma.

### 12.3 Limite de “alta segura”

As orientações incluem medidas domiciliares, evolução, alarmes e retorno, atendendo formalmente a **R23** nos perfis não hospitalares. Entretanto, a adequação de alta depende de dados clínicos que o Site não coleta de forma estruturada - sinais vitais, exame físico, saturação, hidratação, comorbidades e exames -, logo o sistema não pode comprovar sozinho que a disposição escolhida é segura.

## 13. Escores, apreciações e módulos complementares

### 13.1 Escores clínicos

Existem **25 escores**, distribuídos por prioridade:

| Prioridade | Quantidade |
|------------|------------|
| 1          | 13         |
| 2          | 7          |
| 3          | 3          |
| 4          | 1          |
| 5          | 1          |

Até **7 escores** são exibidos por diagnóstico, selecionados por palavras-chave. Um PEWS geral está marcado como escore geral, mas o filtro vigente exclui itens gerais ao buscar escores para um diagnóstico; na prática, esse PEWS geral não aparece nesse fluxo. Trata-se de provável incongruência de implementação.

### 13.2 Apreciações críticas

Há **13 apreciações**:

- 4 de conduta não rotineira;
- 4 de divergência;
- 3 de uso selecionado;
- 1 de evidência limitada;
- 1 off-label.

O módulo existe, mas uma função de busca de apreciações por declaração não está conectada ao fluxo principal; portanto, parte da capacidade declarada pode permanecer sem exibição.

### 13.3 Outros módulos

- **18 perfis** de orientação suplementar;
- **15 escadas terapêuticas**, totalizando **53 linhas/degraus**;
- **14 auditorias** em um módulo de orientação de fontes para receita.

O módulo com as 14 auditorias não é importado pelo aplicativo atual. Ele deve ser classificado como conteúdo disponível no repositório, não funcionalidade vigente.

## 14. Fontes documentais e rastreabilidade

### 14.1 Corpus definitivo

O corpus estruturado contém **413 monografias**. A edição NEXO declarada possui **203 páginas**, e a trilha documental possui **413 registros** com localização/proveniência e verificações detectáveis.

O manifesto disponibiliza três originais principais em acervo-fontes - guia PDF, guia DOCX e edição NEXO PDF - além de texto pesquisável. Há ainda um corpus público mais antigo com **7 PDFs** e **10 arquivos textuais** no total, abrangendo manual integral, modelos/sínteses, volumes 1 a 4 e versões pesquisáveis dos guias/NEXO.

## 14.2 O que o validador garante

Os validadores verificam principalmente:

- contagens esperadas;
- schema/campos obrigatórios;
- IDs duplicados;
- correspondência estrutural de proveniência;
- presença das 413 entradas nos guias e na auditoria;
- preservação das contagens 265/577/393 do inventário-base.

Eles **não** demonstram, por si só:

- atualidade da recomendação clínica;
- correção de dose, indicação ou população;
- status regulatório de cada apresentação;
- equivalência semântica entre PDF, DOCX e JSON;
- ausência de erro de OCR;
- adequação da apresentação ao componente dosado;
- compatibilidade e estabilidade;
- validade externa das fontes genéricas usadas nos protocolos.

## 14.3 Proveniência versus validação clínica

A frase adequada para o PDF é: **“413 monografias com dupla proveniência documental e auditoria estrutural”**. Evitar: **“413 monografias clinicamente validadas”**, salvo se houver revisão humana registrada com responsável, data, metodologia e aceite por monografia.

## 15. Design, tipografia, responsividade e impressão

### 15.1 Tema efetivo

O CSS acumulou várias camadas históricas:

1. base clara com roxo;
2. fase roxa escura;
3. fase final âmbar/preta.

**I:** o tema efetivo atual é predominantemente âmbar/preto. Isso diverge do nome da configuração nexa-monocromatica e de requisitos históricos de preto/cinza/branco. O nome da versão não descreve com precisão o resultado visual corrente.

### 15.2 Fontes

O CSS final força Geist em body e descendentes com !important. Há uma intenção histórica de usar Faustina e, na impressão, Arial, mas as regras posteriores podem prevalecer. O PDF exportado pelo navegador tende, portanto, a usar Geist em vez de Arial/Faustina.

### 15.3 Layout e acessibilidade

- zoom global de 1,125;
- header fixo/sticky;
- breakpoints principais em 1050, 900, 780, 760 e 700 px;
- navegação é ocultada abaixo de 1050 px;
- labels e atributos ARIA em vários controles;
- estilos de foco;
- suporte a preferência de redução de movimento.

Há componentes legados explicitamente escondidos, incluindo calculadora/tratamento antigos e opções relacionadas antigas. Também permanecem estilos de versões anteriores sem correspondência clara com componentes ativos.

## 15.4 Impressão

O modo de impressão:

- oculta a interface e isola o bloco da prescrição;
- usa margens de aproximadamente 16 mm;
- define corpo em torno de 11 pt;
- sofre possível conflito de tipografia com a regra global posterior de Geist.

A exportação final deve ser testada em Chrome/Chromium, Safari e Edge, pois “imprimir para PDF” é parcialmente dependente do motor do navegador.

## 16. Validação técnica executada

Sem modificar o checkout, foram executadas verificações direcionadas:

| Verificação                                    | Resultado                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 testes diretos de orientação/destino        | aprovados                                                                                                                                                                       |
| 4 testes diretos de dose                       | aprovados                                                                                                                                                                       |
| Validador de catálogo                          | aprovado: 265 medicamentos, 577 linhas, 393 indicações no inventário-base; 39/45 na expansão; 202 linhas de anexos; 413 monografias; NEXO 413/203; 238 diagnósticos solicitados |
| Validador de diagnósticos                      | aprovado                                                                                                                                                                        |
| ESLint                                         | aprovado                                                                                                                                                                        |
| TypeScript sem emissão e sem cache incremental | <b>falhou com 4 classes de erro</b>                                                                                                                                             |

Erros de tipagem observados:

1. concentração de ondansetrone possivelmente indefinida em um caminho do componente principal;
2. tipos do módulo de workers da Cloudflare não resolvidos no módulo de banco;
3. tipo global Fetcher ausente;
4. tipo D1Database ausente.

Os testes direcionados dão confiança parcial em dose e alta, mas o typecheck não está limpo. A suíte de build completa não foi acionada nesta auditoria para evitar geração de artefatos no checkout. O estado Git permaneceu limpo ao fim das verificações.

## 17. Reconstrução histórica dos prompts/configurações

O repositório possui **73 commits** no período auditado. A sequência abaixo reconstrói requisitos aplicados a partir de mensagens e diferenças, sem alegar que reproduz os prompts originais.

### Fase 1 - fundação, 01/08/2026

**H:** criação do calculador de prescrição, biblioteca e primeiros protocolos. A matriz teria começado em torno de 21 protocolos e sido ampliada rapidamente para 67. Essa fase estabelece o conceito de cálculo por peso e navegação por diagnósticos.

### Fase 2 - consolidação inicial, 15/08/2026

**H:** aparecem a configuração consolidada, expansão de diagnósticos/medicamentos, receita para cuidador, 25 escores, seleção de apresentações, pré-visualização, horários e agrupamento por via. O visual passa por azul/roxo e roxo escuro.

### Fase 3 - grande expansão clínica e documental, 16/08/2026

**H -> I em partes:**

- linguagem simplificada;
- visual roxo escuro e depois âmbar;
- ampliação de alternativas;
- substituição de terapias genéricas por condutas mais concretas;

- integração de quatro guias, seis manuais, escadas terapêuticas e apreciação crítica;
- introdução das auditorias de receita e da configuração definitiva;
- ocultação posterior do bloco da configuração;
- adição de estomatite;
- cálculo profissional e marcas;
- separação por vias;
- doses prontas para uso;
- expansão do catálogo;
- gastroenterite aguda;
- reforço do escopo clínico e remoção de procedimentos/pós-operatório;
- apresentações brasileiras;
- integração do arsenal de emergência;
- fluxogramas, catálogo A-Z e mapa CMED.

#### Fase 4 - idade e alta individualizada, 17-18/08/2026

**H -> I:** parsing de idade em anos/meses/dias, orientações de alta por diagnóstico/idade e correções de inclusão de medicamentos selecionados.

#### Fase 5 - fechamento documental e segurança, 21/08/2026

**H -> I:**

- impressão limpa;
- terapia principal;
- ajustes de contraste;
- incorporação das 202 linhas provenientes de anexos;
- integração dos guias de 413 monografias;
- auditoria de dose;
- edição NEXO e sua auditoria;
- correções de rolagem/abertura;
- refinamentos de gastroenterite bacteriana, normalização de meses e fallback de terapia principal;
- revisão final.

#### 17.1 Evolução nominal da configuração

| Versão histórica | Intenção inferida da alteração       | Estado                                         |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 31.0             | primeira configuração permanente     | substituída                                    |
| 32               | reforço clínico/menção a privacidade | substituída; privacidade não comprovada no app |
| 33               | saída pronta para uso                | substituída                                    |
| 34               | calculadora prática                  | substituída                                    |
| 35               | integração de emergência             | substituída                                    |
| 55               | reconciliação de matrizes            | substituída                                    |
| 56               | CMED e filtros                       | incorporada/superada                           |
| 57               | cobertura integral e off-label       | incorporada/superada                           |
| 58               | guias de 413 monografias             | incorporada/superada                           |
| 59               | auditoria/tripla checagem de dose    | incorporada/superada                           |
| 60               | NEXO "monocromática"                 | vigente                                        |

#### 17.2 Reversão histórica crucial: ocultar versus mostrar bloqueado

No mesmo ciclo final, houve duas decisões sucessivas:

1. **H:** ocultar da biblioteca linhas com prescriptionBlocked;

2. **I vigente:** reverter a ocultação, restaurando as linhas na biblioteca, mas mantendo cálculo/prescrição prática bloqueados e sinalizando rastreabilidade/off-label.

Logo, o requisito atual é **visibilidade com bloqueio**, coerente com o princípio 17. A regra “não mostrar itens não validados” é histórica e substituída.

## 18. Matriz de aderência entre regras e implementação

| Tema                               | Regra explícita                              | Implementação observada                                                                  | Avaliação                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Escopo clínico                     | excluir técnica e pós-operatório             | filtros removem 6 protocolos e 17 linhas procedurais                                     | aderência relevante                           |
| Divergências                       | mostrar e não auto-selecionar sem indicação  | divergências existem, mas diagnóstico pode selecionar primeira opção confirmada          | aderência parcial                             |
| Tripla checagem                    | matemática, farmacêutica, clínica e reversa  | checagens principalmente aritméticas/estruturais                                         | aderência parcial/importante lacuna semântica |
| Unidade prática primeiro           | mL/gotas/comprimidos/unidades/mL/h           | funciona nas linhas estruturadas; alcance estático estreito                              | aderência parcial                             |
| Todas as apresentações validadas   | oferecer alternativas brasileiras aplicáveis | mapa amplo, sem verificação regulatória em tempo real e com parser frágil em combinações | aderência parcial                             |
| Linhas não automatizáveis visíveis | mostrar e bloquear                           | 202 linhas visíveis e bloqueadas                                                         | aderência forte                               |
| Dados ausentes                     | bloquear e nomear dado                       | vários caminhos bloqueiam; nem toda restrição clínica é estruturada                      | aderência parcial                             |
| Infusão em mL/h                    | unidade original + cálculo independente      | sem motor genérico completo                                                              | não atendido de forma geral                   |
| Não inventar                       | bloquear quando não estruturado              | há bloqueios e texto livre; auto-fallback e heurísticas exigem cuidado                   | aderência parcial                             |
| Orientações domiciliares           | medidas, evolução, alarme, retorno           | 64 perfis e cobertura dos 307 protocolos                                                 | aderência estrutural forte                    |
| Off-label/evidência                | rotular e rastrear                           | 57 linhas marcadas; apreciações existem, algumas funções não conectadas                  | aderência parcial                             |
| Configuração monocromática         | nome da v60                                  | interface efetiva âmbar/preta                                                            | divergência visual                            |

## 19. Lacunas priorizadas

### Críticas

1. **Parser de combinação sem componente-alvo.** Pode converter concentração usando o componente errado. Exigir campos estruturados `activeComponent`, `doseByComponent`, `numerador` e `volume` por componente; bloquear qualquer string ambígua.
2. **Checagem clínica insuficiente para a promessa declarada.** Criar barreiras estruturadas para alergia, função renal/hepática, interação, idade, contraindicação, duração, indicação e monitorização; renomear a checagem atual enquanto isso.
3. **Auto-seleção em alternativas condicionais.** Não pré-selecionar quando houver divergência, condição etária, exame, gravidade ou indicação não capturada.
4. **Infusão sem motor genérico apesar da regra imutável.** Implementar concentração final, diluente, unidade clínica, mL/h, limites, compatibilidade e monitorização, ou rebaixar explicitamente a promessa.

### Altas

5. **Typecheck falha.** Corrigir a concentração possivelmente indefinida e separar/configurar corretamente os tipos Cloudflare.
6. **Reversa sobre valor não arredondado.** Recalcular pela dose prática exibida/administrável e mostrar desvio percentual.
7. **Frações não mensuráveis.** Validar seringa/dispositivo, mínimo de volume, arredondamento por graduação, comprimido sulcado e possibilidade de fracionamento.
8. **Restrições etárias textuais não executáveis.** Migrar notas para campos estruturados e testar limiares em dias/meses/anos.
9. **Peso/idade com barreiras incompletas.** Limpar estado em datas inválidas/futuras, recalcular ao mudar data de prescrição e impor limites no motor, não apenas no HTML.

10. **Fontes genéricas em grande parte dos protocolos.** Substituir a referência ampla por diretriz específica por diagnóstico/conduta e registrar data de revisão.

## Médias

11. **PEWS geral inacessível no fluxo por diagnóstico.** Ajustar filtro ou remover a promessa de escore geral.
12. **Módulos não conectados.** Decidir se auditorias de fonte e função de apreciação devem ser ligadas ou arquivadas como histórico.
13. **Número histórico 308 versus atual 307.** Atualizar configuração/documentação ou explicitar o filtro.
14. **Nome “monocromática” versus âmbar/preto.** Harmonizar versão, design e tipografia.
15. **Bloco de configuração oculto.** Criar tela de “Sobre, versão e fontes” auditável.
16. **Marca e CMED estáticas.** Exibir data de última verificação e priorizar genéricos.
17. **Sem feedback de cópia.** Informar sucesso/erro e oferecer download de texto/PDF com versão.
18. **README insuficiente.** Documentar arquitetura clínica, limitações, atualização e publicação.

## Governança

19. **Ausência do texto integral dos prompts.** Passar a registrar prompts/requisitos em arquivos versionados, com data, autor/responsável, decisão e versão afetada.
20. **“Privado” não verificável.** Exportar e testar a política de acesso da hospedagem separadamente.
21. **Sem trilha de emissão.** Se houver uso clínico real, definir política para versão do algoritmo, data/hora, fonte, usuário, consentimento, privacidade e retenção - sem inserir dados sensíveis no frontend ou no PDF de configuração.

## 20. Conteúdo recomendado para o PDF mestre de exportação

Para que o PDF seja realmente completo e auditável, recomenda-se a seguinte ordem:

1. capa com nome do Site, versão de código, data de exportação e aviso de que não substitui julgamento clínico;
2. escopo e as três classes de evidência R/I/H;
3. texto integral dos 28 princípios vigentes;
4. lista das 14 fontes declaradas;
5. arquitetura, rotas, dependências e metadados;
6. inventário quantitativo de protocolos, medicamentos, escores, orientações e documentos;
7. regras de entrada, parsing de idade e peso;
8. fórmulas e pseudocódigo do cálculo, com unidades e arredondamentos;
9. seletores, exclusões, auto-seleções e regras implícitas;
10. formatos de saída, impressão e plano hospitalar;
11. matriz de aderência e limitações de segurança;
12. histórico das versões 31 a 60 e decisões substituídas;
13. validações/testes e falhas abertas;
14. índice de anexos originais e estruturados;
15. apêndice de lacunas e plano de remediação.

O PDF não deve despejar todos os JSONs linha por linha no corpo principal. Para completude técnica, deve incluir um **manifesto de artefatos** com nome legível, função, contagem de registros, versão/data e relação de proveniência. Os JSONs e originais devem acompanhar o PDF em um pacote de exportação separado, mantendo o PDF legível e os dados auditáveis.

## 21. Conclusão

O Site vigente é um consolidado amplo e rastreável de prescrição pediátrica, mas sua configuração declarada é mais ambiciosa que a cobertura genérica do motor. O que está melhor sustentado é a organização clínica, o escopo sem técnica procedural, a preservação documental, a visibilidade bloqueada de linhas não automatizáveis e a cobertura estrutural de orientações para todos os protocolos atuais.

O que exige maior cautela é a conversão automática: apenas uma fração do catálogo visível chega ao caminho estruturado conservador; associações podem ser analisadas pelo componente incorreto; a “checagem clínica” não contempla dados essenciais; infusões não têm motor genérico compatível com a regra explícita; e restrições textuais nem sempre viram bloqueios.

A exportação honesta deve, portanto, apresentar: **(a)** o prompt/configuração explícita v60; **(b)** o comportamento do código atual; **(c)** a cronologia das decisões substituídas; **(d)** as fontes e contagens; e **(e)** as lacunas. Ela não deve afirmar que o Git contém todos os prompts literais nem que todo medicamento visível está validado e pronto para cálculo.

## Configuração definitiva declarada no código atual

```
export const definitiveConfiguration = {
  id: "prescricao-pediatria-segura-config-definitiva",
  version: "60.0-nexo-monocromatica",
  status: "PERMANENTE",
  effectiveDate: "16/08/2026",
  scope: "Todos os diagnósticos, cálculos, linhas terapêuticas, receituários e orientações do site",
  immutablePrinciples: [
    "Escopo exclusivamente clínico: não exibir protocolos operatórios, técnica cirúrgica, passo a passo de procedimentos ou cuidados pós-operatórios.",
    "Quando um diagnóstico tiver tratamento definitivo procedural ou cirúrgico, apenas sinalizar a necessidade de avaliação/intervenção especializada, sem descrever a técnica; detalhar estabilização, analgesia, antimicrobianos, suporte, monitorização e destino.",
    "Organizar cada diagnóstico em confirmação e gravidade, tratamento farmacológico por linha, cuidados gerais, monitorização/reavaliação, sinais de alarme e destino.",
    "Preservar integralmente os documentos anexados e manter o original disponível para auditoria.",
    "Usar os anexos como fonte de opções e estrutura, nunca como autorização para copiar doses fixas.",
    "Aplicar evidência atual, segurança clínica, bula e protocolo institucional acima de qualquer modelo.",
    "Manter opções divergentes visíveis, explicar a divergência e impedir seleção automática sem indicação.",
  ],
  "Diferenciar tratamento principal, segunda/terceira/quarta opção, alternativa, adjuvante, resgate e off-label.",
  "Não substituir conduta clínica concreta por expressões vagas quando existirem opções farmacológicas e medidas de suporte definidas.",
  "Realizar tripla checagem matemática, farmacêutica e clínica, seguida de checagem reversa.",
  "Ao selecionar uma medicação, apresentar primeiro a conduta pronta para administração: quantidade final em mL, gotas, comprimidos, unidades ou mL/h, via, apresentação/concentração, intervalo e duração; nunca deixar mg/kg e máximo como resposta principal.",
  "Para toda medicação citada no tratamento clínico, oferecer para seleção todas as apresentações brasileiras estruturadas e validadas existentes no catálogo do site, sem ocultar alternativas de concentração ou forma farmacêutica aplicáveis à idade e à via.",
  "A apresentação escolhida, juntamente com peso e idade previamente informados, deve recalcular imediatamente a quantidade prática por administração em mL, gotas, comprimidos, cápsulas, unidades ou mL/h.",
  "É proibido exibir uma fórmula isolada como resposta clínica: toda fórmula visível deve vir acompanhada do resultado numérico prático; se a conversão não for segura, exibir bloqueio explícito e o dado exato que falta.",
  "Incorporar integralmente o arsenal do site Emergência Pediátrica - Doses e Cálculos: 265 medicamentos e 577 linhas clínicas, preservando cada indicação separadamente.",
  "Na biblioteca farmacológica, peso e idade devem alimentar todas as linhas clínicas; a apresentação selecionada deve gerar imediatamente dose total e quantidade prática quando os dados estruturados permitirem.",
  "Quando a fonte classificar uma linha como não automatizável, manter a medicação e a indicação visíveis, mas bloquear a administração prática até que apresentação, concentração, regime e demais dados indispensáveis sejam confirmados.",
  "Manter a dose ponderal, a fórmula, os limites e a checagem reversa apenas como memória de cálculo auditável, em posição secundária à resposta prática.",
  "Se peso, apresentação, concentração, via ou outro dado indispensável estiver ausente, bloquear a conversão e declarar exatamente o dado faltante, sem transferir ao usuário um cálculo que o site possa executar com segurança.",
  "Exibir apresentação, concentração, dose ponderal, dose total, volume, via, intervalo, duração e máximos quando confirmados.",
  "Para infusões, manter unidade clínica original e cálculo independente em mL/h, com concentração final e monitorização.",
  "Nunca inventar dose, apresentação, estabilidade, compatibilidade, diagnóstico, exame ou achado não fornecido.",
  "Incluir medidas não farmacológicas, evolução esperada, sinais de alarme e retorno em todo receituário domiciliar.",
  "Identificar claramente uso off-label, evidência limitada, uso selecionado, conduta não rotineira e contraindicação.",
  "Quando não houver esquema de bula ou diretriz de alta qualidade para uma indicação pediátrica relevante, admitir esquema proposto por sociedade de especialidade, centro pediátrico de referência, consenso formal ou literatura farmacológica pediátrica reconhecida, desde que a fonte seja rastreável e a população aplicável.",
  "Todo esquema de especialista ou uso consagrado fora de bula deve ser rotulado como off-label ou evidência limitada, informar força/certeza da recomendação, faixa etária, indicação exata, via, dose, intervalo, duração, máximos, monitorização e ajustes; divergências devem permanecer explícitas.",
  "A expressão 'comumente utilizado' sem referência verificável não autoriza cálculo final. É proibido extrapolar dose de adulto, outra indicação, outra via ou outra faixa etária apenas para completar o catálogo.",
  "Após estruturação completa e tripla checagem, esquemas off-label rastreáveis podem gerar o mesmo resultado operacional das linhas on-label: dose total, volume/unidades, diluição, concentração final e mL/h quando aplicável.",
  ],
  sourceSet: [
    "NEXO_Farmacoterapia_Pediatria_Monocromatica.pdf - edição consolidada de 203 páginas, 413 monografias, auditoria documental e checagens matemáticas detectáveis (incorporado integralmente em 21/08/2026)",
    "Guia_Farmacoterapia_Pediatria.pdf - NEXO Clinical, edição paginada, 413 monografias (incorporado integralmente em 21/08/2026)",
    "Guia Completo de Farmacoterapia Pediátrica.docx - 413 monografias (incorporado integralmente em 21/08/2026)",
    "Guia PA Pediatria Master",
    "Guia PA Pediatria Avançado/Off-label",
    "Guia PA Pediatria Etiológico/Sintomático",
    "Guia PA Pediatria Expandido",
    "Manuais integrais e volumes 1-4 incorporados",
  ],
}
```

```
"receitas.pdf - modelos domiciliares por diagnóstico",
"Emergência Pediátrica - Doses e Cálculos (265 medicamentos; 577 linhas clínicas; revisão de 11/08/
2026)",
"Matriz terapêutica pediátrica expandida v2 - Prescrição Segura (308 diagnósticos; 303 fármacos; 689
apresentações; 17/08/2026)",
"Matriz terapêutica pediátrica v50 - Prescrição Segura (308 diagnósticos; 303 fármacos; cinco níveis
terapêuticos; 17/08/2026)",
"ANVISA/CMED - Lista de Preços de Medicamentos publicada em 09/05/2026 (substância, produto e
apresentação)",
"Bulário Eletrônico da Anvisa - confirmação complementar de formas, concentrações, advertências e
faixas etárias",
],
} as const;
```

## Histórico cronológico de versões

| Data/hora registrada      | Commit  | Descrição da versão                                                                      |
|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-01T17:31:01+02:00 | 1c5b5c8 | Calculadora clínica e protocolos respiratórios iniciais                                  |
| 2026-08-01T17:37:59+02:00 | 43a4c8b | Biblioteca clínica completa e validações de segurança                                    |
| 2026-08-01T17:52:31+02:00 | cedc91a | Ampliação para 21 diagnósticos com busca e protocolos de alta prioridade                 |
| 2026-08-01T18:05:16+02:00 | d91687e | Expansão para 67 protocolos de pronto-socorro pediátrico                                 |
| 2026-08-15T13:32:38-03:00 | 5c45909 | Publica configuração clínica consolidada                                                 |
| 2026-08-15T13:35:20-03:00 | 6a01776 | Valida integralmente diagnósticos e medicamentos                                         |
| 2026-08-15T13:38:34-03:00 | 82aa7b6 | Amplia terapias e adiciona orientações clínicas                                          |
| 2026-08-15T13:51:06-03:00 | caa85f4 | Simplifica receituário para pais e responsáveis                                          |
| 2026-08-15T14:01:02-03:00 | 1b15bce | Adiciona escores clínicos validados por diagnóstico                                      |
| 2026-08-15T14:09:14-03:00 | e54a568 | Adiciona seleção de apresentações e recálculo por medicamento                            |
| 2026-08-15T14:27:50-03:00 | f0a73ad | Completa prévia pediátrica com horários e filtros de segurança                           |
| 2026-08-15T14:37:05-03:00 | 93fc590 | Padroniza prévia consolidada por vias e orientações                                      |
| 2026-08-15T14:44:10-03:00 | 7236e07 | Atualiza identidade visual para azul e roxo                                              |
| 2026-08-15T16:13:00-03:00 | 613c797 | Filtra opções clínicas e consolida todas as seleções                                     |
| 2026-08-15T16:27:49-03:00 | a90d8f0 | Amplia opções clínicas e apresentações pediátricas                                       |
| 2026-08-15T16:40:25-03:00 | 0e770b6 | Adiciona sintomáticos e cuidados respiratórios condicionais                              |
| 2026-08-15T16:45:28-03:00 | bc15166 | Integra complemento terapêutico auditado do PDF                                          |
| 2026-08-15T16:51:07-03:00 | cd15311 | Expandir apresentações e opções clínicas condicionadas                                   |
| 2026-08-16T07:51:52-03:00 | 7d33155 | Simplifica linguagem do receituário                                                      |
| 2026-08-16T07:56:03-03:00 | f037971 | Aplica tema preto e roxo escuro                                                          |
| 2026-08-16T08:02:31-03:00 | fd22f30 | Adiciona luzes desfocadas ao fundo                                                       |
| 2026-08-16T08:05:04-03:00 | 6ed1048 | Harmoniza tipografia e paleta âmbar                                                      |
| 2026-08-16T08:08:16-03:00 | 4df8946 | Resume orientações e refina tipografia                                                   |
| 2026-08-16T08:17:13-03:00 | 1556e2a | Amplia alternativas clinicas e simplifica receita familiar                               |
| 2026-08-16T08:27:52-03:00 | 088220f | Substitui condutas genericas por farmacos selecionaveis e organiza segunda linha         |
| 2026-08-16T08:46:48-03:00 | 3f11f3e | Incorpora linhas terapêuticas dos quatro guias pediátricos                               |
| 2026-08-16T08:59:10-03:00 | b491172 | Expande opções farmacológicas, procedimentos e medidas de suporte                        |
| 2026-08-16T10:00:45-03:00 | fa55c34 | Integra acervo integral dos seis manuais terapêuticos                                    |
| 2026-08-16T10:12:48-03:00 | 17143ec | Adicionar análise crítica e divergências terapêuticas                                    |
| 2026-08-16T10:17:00-03:00 | eabc050 | Integrar receitas.pdf como orientação definitiva auditada                                |
| 2026-08-16T10:28:29-03:00 | c657ddc | Consolidar configuração clínica definitiva e permanente                                  |
| 2026-08-16T09:21:25-07:00 | ebf94dc | Simplifica abas clínicas e preserva receituário                                          |
| 2026-08-16T09:58:47-07:00 | ff94aae | Contextualiza escores e melhora contraste clínico                                        |
| 2026-08-16T10:08:49-07:00 | b65ef49 | Oculto configuração permanente e amplia leitura                                          |
| 2026-08-16T10:29:29-07:00 | 8733231 | Adicionar estomatite com tratamento crítico e seguro                                     |
| 2026-08-16T10:41:01-07:00 | 7a87c0a | Refinar acetilcisteína e opções intraorais                                               |
| 2026-08-16T10:45:54-07:00 | f5abd0a | Calcular opções profissionais e aceitar nomes comerciais                                 |
| 2026-08-16T10:59:23-07:00 | f24dba2 | Ampliar apresentações e cálculos por medicação                                           |
| 2026-08-16T11:21:05-07:00 | 151b080 | Separar protocolos e medicações em páginas                                               |
| 2026-08-16T11:36:56-07:00 | 315c764 | Gerar apenas posologias prontas para responsáveis                                        |
| 2026-08-16T11:55:37-07:00 | 4a0b367 | Aplicar cálculo pronto a todo o catálogo                                                 |
| 2026-08-16T12:58:34-07:00 | 8cc80e9 | Audita e estrutura protocolos terapêuticos do catálogo                                   |
| 2026-08-16T13:19:06-07:00 | 6754c8b | Amplia o catálogo farmacológico pediátrico com 40 medicamentos e protocolos de segurança |
| 2026-08-16T19:05:00-04:00 | 69270f1 | Configura protocolo seguro de gastroenterite viral                                       |
| 2026-08-16T19:15:19-04:00 | b346dee | Tornar site privado e consolidar escopo clínico                                          |
| 2026-08-16T19:26:50-04:00 | e77b715 | Priorizar conduta pronta em unidades administráveis                                      |
| 2026-08-16T19:30:31-04:00 | ebad457 | Exigir apresentações brasileiras e resultado prático                                     |
| 2026-08-16T19:38:26-04:00 | f8da89e | Integrar arsenal completo de emergência pediátrica                                       |

| Data/hora registrada      | Commit  | Descrição da versão                                                                                    |
|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-16T19:45:35-04:00 | 6cee13c | Corrigir falha ao abrir Protocolos                                                                     |
| 2026-08-16T20:14:19-04:00 | ac51a8f | Simplify caregiver prescription instructions                                                           |
| 2026-08-16T22:00:01-07:00 | 3a7a13d | Refina opções terapêuticas e adiciona fluxogramas clínicos                                             |
| 2026-08-16T22:20:24-07:00 | 0b52c29 | Reorganiza catálogo terapêutico por objetivo clínico                                                   |
| 2026-08-16T22:25:37-07:00 | 4bbcaa6 | Renomeia amigdalite estreptocócica e reforça contraste                                                 |
| 2026-08-16T22:29:48-07:00 | 16c9dfc | Exibe apenas apresentações brasileiras confirmadas                                                     |
| 2026-08-16T22:42:43-07:00 | f97d3a4 | Renomeia terapias, organiza suporte por sintomas e reconcilia matrizes terapêuticas anexas             |
| 2026-08-16T22:59:51-07:00 | c2922d5 | Audita 265 medicamentos, integra apresentações ANVISA CMED e aplica filtro pediátrico por idade e peso |
| 2026-08-16T23:10:48-07:00 | 2f42b67 | Adicionar corticoide e ipratropio ao broncoespasmo agudo                                               |
| 2026-08-16T23:17:56-07:00 | 965ad99 | Revisar IVAS bacterianas ITU e anti-inflamatorios                                                      |
| 2026-08-17T20:14:09+07:00 | 512f1d6 | Aceitar idade em anos, meses e dias                                                                    |
| 2026-08-17T21:00:52+07:00 | a456a46 | Individualizar alta e retorno por diagnóstico                                                          |
| 2026-08-18T11:59:32+07:00 | 659fddf | Corrigir inclusão de medicações selecionadas no receituário                                            |
| 2026-08-21T04:09:20+09:00 | 8462cb1 | Adiciona impressão limpa do receituário                                                                |
| 2026-08-21T09:37:09+09:00 | 991acff | Amplia terapêutica principal e benefício prognóstico                                                   |
| 2026-08-21T09:52:47+09:00 | 8e3f854 | Melhora contraste da seleção de diagnóstico                                                            |
| 2026-08-21T18:18:40+03:00 | 2a08212 | Ampliar arsenal com lista pediátrica anexada e barreiras de segurança                                  |
| 2026-08-21T18:45:24+03:00 | 175d85c | Ocultar medicamentos sem validacao clinica individual                                                  |
| 2026-08-21T19:01:32+03:00 | b03bc32 | Expose attached formulary with traceable off-label policy                                              |
| 2026-08-21T20:01:55+03:00 | 0406aa7 | Incorpora guias definitivos de farmacoterapia pediátrica                                               |
| 2026-08-21T20:07:28+03:00 | 8c30f48 | Corrige motor de doses e adiciona tripla checagem posologica                                           |
| 2026-08-21T20:35:03+03:00 | bfdcd06 | Incorpora NEXO consolidado e auditoria documental                                                      |
| 2026-08-21T23:36:19+03:00 | 14e71fc | Corrige abertura da continuação da prescrição                                                          |
| 2026-08-21T23:45:42+03:00 | a95fdc6 | Corrigir GEA bacteriana, idades e terapêutica principal                                                |
| 2026-08-21T23:50:12+03:00 | d7d1542 | Revisão sistemática tripla e correções gerais                                                          |

# 4. Emergência Pediátrica - Doses e Cálculos / Medicamentos Pediátricos

| Campo                        | Valor                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Título                       | Emergência Pediátrica - Doses e Cálculos / Medicamentos Pediátricos                                                                     |
| Slug                         | emergencia-pediatria-doses                                                                                                              |
| URL de produção              | <a href="https://emergencia-pediatria-doses.iagovalmeida.chatgpt.site">https://emergencia-pediatria-doses.iagovalmeida.chatgpt.site</a> |
| Criado                       | 08/08/2026                                                                                                                              |
| Última atualização publicada | 21/08/2026 14:35 BRT                                                                                                                    |
| Versão atual                 | 35                                                                                                                                      |
| Commit                       | ea8cafd655a419922f559b06683754f2b91d3fa3                                                                                                |
| Acesso                       | Custom; proprietário único; sem visitantes externos                                                                                     |
| Ambiente                     | 0 variáveis de produção; 0 domínios personalizados                                                                                      |

EP

Emergência Pediátrica

Doses, diluições e equipamentos

Fontes definitivas em 21/08/2026 · Inventário 413/413 incorporado · NEXO 413/413

Baixar Excel original

FERRAMENTA CLÍNICA DE CONSULTA RÁPIDA

Medicações em pediatria - conforme peso e idade

Medicações

Soroterapia

Equipamentos

Energia

Segurança

Checagem

Diluições

Auditoria

Fontes

PESO DA CRIANÇA

IDADE DA CRIANÇA

BUSCAR MEDICAÇÃO OU INDICAÇÃO

CATEGORIA

Ex.: 12

kg

Ex.: 2

anos

Ex.: adrenalina, meningite, sedação...

Todas

Reconciliação completa do arquivo: 413/413 medicamentos e suas apresentações foram catalogados. Nesta versão, 89 medicamentos possuem validação clínica individual e 401 esquemas calculáveis. Esquemas off-label ou propostos por especialistas podem ser incluídos quando houver fonte clínica rastreável, indicação, faixa etária, dose, intervalo, duração, máximo e força da recomendação explícitos. O seletor não transforma apresentação comercial isolada em prescrição automática.

89 de 89 medicações · 401 esquemas clínicos

Lista alfabética. Abra uma medicação para selecionar indicação e apresentação.

Captura oficial da versão 35 recuperada em 22/08/2026.

## Prompt mestre portátil reconstruído

## Prompt mestre portátil - Medicamentos Pediátricos / Emergência Pediátrica

Crie uma ferramenta clínica de consulta rápida intitulada “Medicações em pediatria - conforme peso e idade”, em português brasileiro, para médicos de emergência, pediatria e terapia intensiva. A aplicação deve organizar um inventário amplo de fármacos e permitir cálculo apenas das linhas que tenham indicação, dose, via, apresentação, intervalo, duração e limites suficientemente estruturados.

### Interface e navegação

- Primeira área: peso, idade, busca por fármaco ou indicação e filtro de categoria.
- Organize alfabeticamente por fármaco. Ao abrir um fármaco, permita escolher indicação e apresentação; nunca trate apresentações isoladas como intercambiáveis.

- Mantenha abas para Medicações, Soroterapia, Equipamentos, Energia, Segurança, Checagem, Diluições, Auditoria e Fontes.
- Gere linha final copiável para receituário quando o regime for domiciliar e a linha estiver completa.

### Conteúdo e cálculo

- Preserve o inventário documental completo e, separadamente, o subconjunto clinicamente calculável.
- Cada linha clínica deve conter fármaco, indicação, prioridade terapêutica, status, apresentação, concentração, via, dose ponderal, dose total, volume/unidades, máximos/titulação, intervalo, duração, preparo/diluição, monitorização, contraindicações/ajustes e fonte.
- Calcule por peso e idade; aplique limites por peso, idade mínima, máximos absolutos, máximos por dose/dia e arredondamento operacional.
- Faça checagem reversa independente. Para infusões, mostre concentração final, unidade original e mL/h. Para inaladores/dispositivos, não converta indevidamente em mL.
- Explicita 1ª, 2ª, 3ª e 4ª linha quando sustentadas pela indicação. Marque off-label, evidência limitada ou esquema de especialista com fonte rastreável.
- Não exiba como prescrição automática uma linha apenas documental, vaga ou sem equivalência segura.

### Segurança e fontes

- Utilize apresentações comercializadas no Brasil, com verificação regional em Belo Horizonte/RMBH quando disponível.
- Diferencie recomendação clínica, inventário anexado e referência histórica.
- Não invente dose, concentração, fator de gotas, compatibilidade, estabilidade ou duração.
- Inclua alertas de alta vigilância e dupla checagem de peso, unidade, concentração, bomba, via e acesso.
- Priorize diretrizes nacionais e documentos oficiais; use fontes internacionais e centros pediátricos de referência quando necessários e identifique a aplicabilidade.
- Estilo atual: preto, branco e cinza, tipografia editorial, alta densidade informacional e responsividade.

## Auditoria da configuração ativa

### Auditoria de exportação - SiteGPT “Medicações em pediatria / Emergência Pediátrica - Doses e Cálculos”

**Checkout auditado, somente leitura:** /workspace/sites/emergencia-pediatria-doses **Estado auditado:** versão corrente da branch principal, último registro em 21/08/2026 às 20:34 (fuso do registro). **Período reconstruído pelo Git:** 08/08/2026 a 21/08/2026, em 35 registros de alteração. **Objetivo:** documentar o equivalente exportável do “prompt/configuração” efetivamente implementado: arquitetura, regras clínicas, seleção, cálculos, segurança, fontes, design, dependências, histórico e lacunas.

> Limite de reconstrução: o checkout não contém o texto literal das mensagens/prompts que originaram cada mudança. O Git preserva assuntos de alterações e deltas de código, o que permite reconstruir requisitos e regras implementadas, mas não reproduzir palavra por palavra conversas que não foram salvas no repositório. Também não contém a política remota de acesso do Site nem configurações de implantação fora do código.

#### 1. Resumo executivo

O projeto atual é uma aplicação clínica pediátrica de rota única, em português brasileiro, com nove abas internas. A aba principal agrupa fármacos alfabeticamente e força o fluxo **peso + idade -> medicamento -> indicação -> apresentação -> esquema -> resultado calculado**. O mesmo site também contém soroterapia, expansão volêmica, equipamentos, energia elétrica, tabelas de segurança, checagem matemática, diluições, conversões e fontes.

A distinção central para a exportação é:

- **413 medicamentos estão catalogados documentalmente**, com apresentações oriundas do inventário anexado.
- **Somente 89 grupos de medicamentos aparecem no seletor clínico**, correspondendo a **401 esquemas calculáveis ativos**.

- **243 linhas-fonte em modo fallback estão ocultas** antes do seletor; representam 236 nomes agrupados.
- **226 medicamentos do inventário possuem apenas a ficha documental construída, mas essa ficha não é usada pelo seletor.** Esses números se sobrepõem e não devem ser somados.
- A configuração ativa aceita esquemas off-label somente quando já há linha operacional explícita e rastreável; ela **não libera automaticamente todo o inventário**.

O conjunto passa nas verificações automatizadas existentes: **31/31 testes de dados/código**, e a auditoria clínica interna reporta **605 linhas-fonte, 362 calculáveis, 316 nomes, 413/413 de inventário, 0 erros e 0 alertas**. Isso comprova coerência estrutural nas regras testadas, não validação clínica independente de todas as 401 linhas ativas.

## 2. Contagens auditáveis da versão atual

### 2.1 Formação do catálogo

| Camada                                             | Contagem   | Interpretação                                         |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Planilha clínica original                          | 126 linhas | Base extraída do Excel do projeto                     |
| Expansão clínica principal                         | 456 linhas | Ampliação de apresentações, vias, indicações e faixas |
| Expansão dirigida por evidência de 2026            | 23 linhas  | Antídotos, influenza, toxicológico, CAD etc.          |
| Total antes das expansões da interface             | 605 linhas | 362 calculáveis + 243 fallback                        |
| Expansões terapêuticas no componente               | 8 linhas   | Estreptococo/escarlatina e alternativas               |
| Regimes não volumétricos reincorporados            | 3 linhas   | Beclometasona e salbutamol em jatos                   |
| Após variantes de apresentação                     | 634 linhas | Inclui variante de amoxicilina 250 mg/5 mL            |
| Operacionais antes de dividir indicações compostas | 391 linhas | fallback e apresentação vaga já removidos             |
| Após separar indicações combinadas                 | 401 linhas | Dez desdobramentos adicionais                         |
| <b>Esquemas ativos finais</b>                      | <b>401</b> | Nenhuma duplicata final foi descartada nesta versão   |

### 2.2 Cobertura clínica ativa

| Métrica                                                             | Contagem          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Grupos visíveis de medicamentos                                     | <b>89</b>         |
| Nomes crus ativos                                                   | 90                |
| Rótulos distintos de indicação                                      | 375               |
| Pares medicamento-indicação                                         | 381               |
| Apresentações distintas                                             | 122               |
| Pares medicamento-apresentação                                      | 137               |
| Vias textuais distintas                                             | 44                |
| Categorias/prioridades distintas                                    | 44                |
| Linhas com objeto estruturado de diluição                           | 72                |
| Linhas off-label                                                    | 41, em 26 grupos  |
| Linhas marcadas como alta vigilância/ressuscitação pela prioridade  | 205, em 44 grupos |
| Linhas com fonte HTTP direta                                        | 375               |
| Linhas sem fonte HTTP direta                                        | 26                |
| Linhas com limite etário estruturado                                | 180               |
| Linhas com limite ponderal estruturado                              | 56                |
| Linhas sem limite estruturado de idade nem peso                     | 211               |
| Linhas com duração numérica explícita em dias no campo de intervalo | 53                |
| Linhas cujo resultado primário contém mL                            | 396/401           |

As 26 linhas sem URL direta usam, em geral, a planilha 11-Doses-ped-excel.xlsx como fonte secundária declarada. Incluem esquemas de amoxicilina, amoxicilina-clavulanato, cefalexina, cefaclor, cefuroxima, gentamicina, metronidazol, ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno, prednisolona, prednisona e suxametônio.

## 2.3 Modos de cálculo ativos

| Modo        | Linhas | Regra executada                                 |
|-------------|--------|-------------------------------------------------|
| weighted    | 281    | peso × fator, com piso/teto quando configurados |
| fixed       | 67     | valor fixo após elegibilidade                   |
| dual        | 48     | duas etapas ponderais independentes             |
| threshold27 | 2      | valor fixo abaixo ou a partir de 27 kg          |
| threshold20 | 1      | valor fixo abaixo ou a partir de 20 kg          |
| fixeddual   | 1      | duas saídas fixas                               |
| maintenance | 1      | manutenção pela regra 4-2-1                     |

Não existe fallback na lista ativa.

## 2.4 Posição terapêutica e força de recomendação exibidas

Esses rótulos são inferidos por expressões regulares; não são campos GRADE formalmente preenchidos.

| Posição exibida                                     | Linhas |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Papel terapêutico definido na indicação selecionada | 134    |
| Papel terapêutico conforme indicação                | 133    |
| Terapia dirigida - não empírica                     | 79     |
| 2ª linha/alternativa                                | 22     |
| 1ª linha somente no cenário descrito                | 18     |
| 3ª linha/resgate                                    | 15     |

| Força exibida                                                 | Linhas |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Condicional para indicação/perfil                             | 207    |
| Forte/uso estabelecido                                        | 153    |
| Off-label condicional, evidência limitada                     | 28     |
| Off-label condicional, respaldo por diretriz/consenso/prática | 13     |

## 2.5 Maiores grupos por número de esquemas

| Grupo                                 | Esquemas |
|---------------------------------------|----------|
| Teicoplanina                          | 59       |
| Amoxicilina + clavulanato de potássio | 52       |
| Amoxicilina                           | 36       |
| Amicacina                             | 11       |
| Cefuroxima                            | 10       |
| Oseltamivir                           | 10       |
| Gentamicina                           | 9        |
| Ampicilina-sulbactam                  | 8        |
| Cefepima                              | 8        |
| Oxacilina                             | 8        |
| Cefotaxima                            | 7        |
| Ampicilina + sulbactam                | 6        |
| Cefazolina                            | 6        |
| Clindamicina                          | 6        |

Há uma duplicidade semântica ativa: **“Ampicilina + sulbactam”** e **“Ampicilina-sulbactam”** permanecem em grupos diferentes.

## 3. Estrutura e experiência ativa

### 3.1 Arquitetura

- Next.js App Router sobre Vinext/Vite, React e TypeScript, empacotado para Cloudflare Worker.

- Uma rota efetiva: /. As “rotas” funcionais são nove abas controladas por estado React, sem URL própria e sem deep-link.
- O componente principal inteiro é `use client`; dados clínicos, inventário e monografias são carregados no cliente.
- Não há API clínica ativa, banco, gravação de usuário ou persistência de formulário.
- O manifesto possui identidade do Site e listas D1/R2 vazias. Os arquivos Drizzle/D1 e o exemplo de API são infraestrutura do starter, não funcionalidade ativa.
- Existe helper opcional de autenticação ChatGPT, mas ele não é importado pela página. O código da página não exige login. A política de acesso aplicada pelo ambiente hospedado não pode ser inferida do checkout.

### 3.2 Abas

1. Medicações A-Z
2. Soroterapia 100%
3. Equipamentos
4. Cardioversão e desfibrilação
5. Correções e segurança
6. Checagem matemática
7. Diluições padrão
8. Conversão por peso
9. Fontes

As abas 5-8 exibem matrizes da planilha. Linhas com expressões de apresentação vaga são filtradas visualmente nas matrizes.

### 3.3 Fluxo da aba de medicamentos

1. Informar peso em kg.
2. Informar idade numérica e escolher dias, meses ou anos.
3. Buscar por medicamento, indicação, via ou apresentação.
4. Filtrar por categoria/prioridade.
5. Abrir o grupo do medicamento.
6. Selecionar indicação/condição.
7. Selecionar apresentação/concentração.
8. Ver todos os esquemas da combinação escolhida.
9. Conferir dose, máximo/titulação, intervalo, preparo, monitorização, cautelas, posição terapêutica, força, conversão e fontes.
10. Concluir as três checagens e, quando elegível, copiar uma linha domiciliar.

Os medicamentos são ordenados alfabeticamente. Indicações também são alfabéticas. Esquemas dentro da apresentação são ordenados lexicalmente por texto de dose e via, não por linha terapêutica ou valor numérico.

## 4. Regras clínicas e matemáticas ativas

### 4.1 Peso, idade e arredondamento

- Peso aceita ponto ou vírgula, deve ser numérico e maior que zero.
- Idade aceita apenas um número em uma unidade escolhida. Dias são convertidos por 365, 25/12 dias por mês; anos por 12 meses.
- A apresentação da idade muda para dias abaixo de um mês, meses abaixo de 24 meses e anos a partir de 24 meses.
- Cálculos são arredondados internamente a seis casas; a exibição usa ao menos duas casas e até seis.
- Se qualquer volume positivo for menor que 0,01 mL, surge o aviso para preparar diluição mensurável.
- Não há arredondamento automático por resolução de seringa, gota, ampola ou bomba.

O parser atual **não reconhece idade composta em um único texto**, como 1a12d, 12m15d ou 2a9m2d. 29d funciona apenas como valor 29 com a unidade “dias” selecionada.

## 4.2 Elegibilidade etária/ponderal

A elegibilidade combina:

- campos estruturados de idade mínima/máxima e peso mínimo/máximo, inclusivos ou exclusivos;
- regras fixas por nome: prometazina abaixo de 2 anos; codeína/tramadol abaixo de 12 anos; naproxeno abaixo de 2 anos; nimesulida abaixo de 12 anos; bromoprida abaixo de 1 ano; ibuprofeno abaixo de 3 meses ou 5 kg;
- reconhecimento textual limitado de “≥ X anos/meses” ou “a partir de X anos/meses”.

Peso e idade são obrigatórios para liberar resultado, inclusive em muitas doses fixas. Não existe limite pediátrico global de idade/peso: a proteção depende da linha individual.

## 4.3 Fórmulas

- Ponderal:  $\text{volume} = \text{peso} \times \text{fator}$ , depois aplica piso e teto.
- Dupla: repete a fórmula para duas etapas, com teto independente.
- Limiares: escolhe valor fixo conforme  $<20/\geq 20$  kg ou  $<27/\geq 27$  kg.
- Manutenção: até 10 kg, 4 mL/kg/h; 10-20 kg,  $40 + 2 \times (\text{kg} - 10)$ ; acima de 20 kg,  $60 + 1 \times (\text{kg} - 20)$ .
- Variante de amoxicilina: fatores da suspensão 400 mg/5 mL são reescalados para 250 mg/5 mL pela razão entre concentrações.

Correções explícitas no código:

- ipratrópio: concentração de auditoria 0,25 mg/mL e limiar de 20 kg;
- penicilina benzatina: limiar de 27 kg, 2 mL abaixo e 4 mL a partir do limiar;
- clindamicina: fatores exatos para 10 ou 13 mg/kg na concentração 150 mg/mL;
- amoxicilina-clavulanato EV: usa volume final recuperado de aproximadamente 20,9 mL, não apenas volume de diluente nominal;
- cefuroxima IM/EV: usa volumes finais recuperados de 3,5 e 8,6 mL.

## 4.4 Tripla checagem exibida

Cada esquema mostra:

1. **Paciente/elegibilidade:** peso e idade presentes e dentro dos limites.
2. **Cálculo direto:** configuração numérica finita, não negativa e faixa ordenada.
3. **Cálculo reverso/limites:** volume  $\times$  concentração retorna unidade total e por kg, quando aplicável.

Limitações importantes:

- Nos modos fixos e de limiar, a terceira etapa confia principalmente no texto reverseCheck começar por “OK”; não refaz toda a aritmética.
- No modo dual, a checagem dinâmica refaz principalmente a primeira etapa; a segunda depende em parte da configuração textual.
- Quando um teto absoluto é aplicado, a etapa é aceita pelo fato de o teto ter sido aplicado, sem uma segunda validação independente do máximo textual.
- A mesma função e os mesmos campos originam cálculo e conferência; portanto, não é independência plena entre dois motores.

## 4.5 Alta vigilância

- 205 linhas recebem marca visual de alta vigilância/ressuscitação pela prioridade.
- A função que acrescenta “tripla checagem humana independente” examina via, status e intervalo, mas **não examina o campo prioridade**.
- Apenas 26 linhas ativas possuem a frase explícita de tripla checagem humana nas cautelas; **182 das 205 linhas marcadas visualmente como alta vigilância não a possuem**. Todas ainda exibem o painel matemático genérico.

## 4.6 Infusões

- 24 linhas têm BIC ou infusão contínua no texto.
- 20 fornecem saída primária em mL/h.
- Quatro não fornecem mL/h como saída primária:
- KCl para hipocalemia: volume da ampola antes de diluir;
- esmolol em emergência hipertensiva: mL do bolus;
- esmolol em taquiarritmia: mL do bolus/apresentação;
- sulfato de magnésio em eclâmpsia: mL do ataque.
- 11 dessas 24 linhas não têm objeto estruturado de diluição; o preparo existe apenas como texto. Entre elas: cetamina, KCl, dexmedetomidina, esmolol, fentanila, midazolam, morfina, dobutamina, dopamina e insulina regular.

Não há motor geral de compatibilidade, estabilidade, via central/periférica, ajuste renal/hepático ou interações. Essas informações são campos textuais por linha.

## 5. Receituário domiciliar automático

Uma linha copiável só é gerada quando:

- o perfil está elegível;
- o resultado contém número prático;
- a via parece domiciliar (oral, nasal, inalatória, tópica, ocular, ótica ou retal);
- o contexto não contém via EV/IM/IO, bomba, ressuscitação, choque, intubação, sedação, hospitalar, meningite, sepse grave ou alta vigilância.

Regras de duração automáticas, quando o intervalo não traz duração explícita:

- pneumonia atípica com azitromicina: 5 dias;
- OMA: 10 dias se <2 anos; 7 dias entre 2 e <6 anos; 5 dias a partir de 6 anos;
- rinossinusite bacteriana: 10 dias;
- PAC bacteriana: 5 dias;
- pele/tecidos moles: 5 dias;
- cistite/ITU afebril: 5 dias;
- ITU febril/pielonefrite: 10 dias;
- prednisolona na exacerbação de asma: 5 dias;
- analgésicos/antitérmicos: até 3 dias se necessário;
- reidratação Plano B: 4 horas e reavaliação;
- manutenção/desmame: até reavaliação.

Para faixas de dose, a interface gera opções separadas de mínimo e máximo e orienta o profissional a escolher; não produz uma única linha "X a Y". Para azitromicina de duas etapas, gera dia 1 e dias 2-5. Antimicrobianos recebem lembrete de completar o curso. O botão usa a API de clipboard sem fallback de erro.

## 6. Soroterapia, expansão, equipamentos e energia

### 6.1 Soroterapia

Valores iniciais da tela:

- manutenção 100%;
- bolsa 500 mL;
- dextrose 5%;
- potássio 20 mEq/L;
- SG concentrado 50%;
- KCl 2,5 mEq/mL;
- solução-base com sódio 154 mEq/L;
- outros aportes 0 mL/24 h;

- acesso periférico.

Para RN, usa o ponto médio destas faixas: D1 50-60, D2 70-80, D3 80-100, D4 100-120, D5-28 120-150 mL/kg/dia. Após 28 dias, usa 4-2-1.

Fórmulas principais:

- SG concentrado (mL) = volume da bolsa × dextrose-alvo / concentração do SG;
- KCl (mL) = K-alvo × volume(L) / concentração do KCl;
- base = volume final – SG – KCl;
- GIR = dextrose(%) × mL/h / peso / 6;
- Na e K são recalculados em mEq/kg/dia;
- duração da bolsa, volumes de 6/12/24 h e aporte total são exibidos.

Alertas cobrem preparo impossível, idade ausente, aporte total fora de  $\pm 2\%$  da referência, Na/K/GIR neonatal, isotonicidade após 28 dias, K periférico/central e dextrose  $>10\%$  ou  $>12,5\%$  periférica.

Lacunas: entradas não possuem máximos; bolsa, concentração de SG ou KCl iguais a zero podem produzir divisões inválidas. Alertas não bloqueiam a composição. A bolsa padrão já contém sódio e potássio mesmo no neonato; o sistema alerta, mas não remove automaticamente.

## 6.2 Expansão volêmica

Contextos: choque/hipoperfusão, sepse, cardiopatia/disfunção miocárdica, hemorragia/trauma e CAD com choque. Regra padrão 10 ou 20 mL/kg; neonato, CAD, cardiopatia e hemorragia fixam 10 mL/kg. Calcula volume, mL/h conforme minutos, acumulado de duas/três alíquotas e checagem reversa. Exige reavaliação clínica após cada alíquota.

## 6.3 Energia e equipamentos

- Cardioversão: 0,5-1 J/kg inicial; 2 J/kg na segunda.
- Desfibrilação: 2 J/kg no primeiro choque; 4 J/kg no segundo; subsequentes  $\geq 4$  J/kg, máximo textual de 10 J/kg ou máximo adulto.
- Equipamentos: 19 linhas de planilha; energia: 24 linhas.
- Tabelas adicionais: 16 linhas de segurança, 25 de checagem, 59 de diluições, 129 de conversões e 60 de fontes, contando cabeçalhos/separadores.

## 7. Fontes e rastreabilidade

### 7.1 Arquivos incorporados ao próprio Site

- Excel pediátrico original, disponível para download.
- Guia de Farmacoterapia Pediátrica: PDF de 96 páginas.
- Guia Completo de Farmacoterapia Pediátrica: DOCX com 413 monografias indexadas.
- NEXO - Guia Consolidado: PDF de 203 páginas e 413 monografias indexadas.
- Inventário MEDICAÇÕES EM PEDIATRIA.txt: 413 registros de apresentações, convertido em JSON; o TXT original não está no checkout público.

O NEXO traz ressalva explícita de que auditoria documental não equivale à validação clínica independente de todas as doses.

### 7.2 Fontes por linha ativa

375/401 linhas possuem ao menos uma URL. Domínios mais frequentes, contando ocorrências nas linhas: Fresenius Kabi 130; UCSF 39; CHEO 39; CDC 36; Blau 16; DailyMed 16; RCH 14; ABL Brasil 13; GINA 10; Resuscitation Council UK 10; IDSA 7; AHA CPR 6; ESPGHAN 6; NICE 6; PubMed 6; SCCM 6; e outras fontes de sociedades, bulas, estudos e protocolos.

Há oito links de disponibilidade local em BH/RMBH, todos de uma rede varejista, para amoxicilina 250/5, amoxicilina 400/5, amoxicilina-clavulanato, cefalexina, cefaclor, cefuroxima, azitromicina e penicilina benzatina. Esses links demonstram presença comercial observada, não registro sanitário vigente nem disponibilidade em estoque.

## 7.3 Vínculo das monografias

Entre os 89 grupos ativos:

- 72 encontram monografia por chave exata normalizada;
- 7 por correspondência parcial;
- 10 não encontram monografia;
- uma correspondência parcial é ambígua.

A ambiguidade é clinicamente relevante: **“Gluconato de cálcio” seleciona primeiro “Acetato de cálcio”**, pois o algoritmo aceita inclusão textual e retorna o primeiro candidato; “Gluconato de cálcio 10%” aparece como segundo candidato. A mesma rotina é usada para guia, NEXO e apresentações catalogadas.

Grupos sem vínculo automático: ipratrópio brometo, Ketodex, penicilina G cristalina, penicilina G procaína, SRO, SG 5%, SG 10%, SG 50%, soro polieletrólítico balanceado e suxametônio.

## 8. Design, metadados e acessibilidade

- Tema ativo: preto, branco e escalas de cinza.
- Fonte: Faustina carregada do Google Fonts, com fallback Georgia/serif.
- Layout máximo de 1480 px; cabeçalho, hero, abas fixas, cartões expansíveis e tabelas roláveis.
- Responsividade em 1050 px e 700 px; regras de impressão ocultam navegação e campos.
- Badges semânticos foram visualmente monocromatizados; posição, off-label e risco dependem mais do texto do que de cor.
- Idioma do documento: pt-BR; controles têm rótulos e alguns `aria-label`.
- A interação por `<details>/<summary>` preserva acessibilidade básica; não há testes automatizados de teclado, leitor de tela ou contraste.

Metadados atuais:

- título: “Medicações em pediatria - conforme peso e idade”;
- descrição ainda menciona doses, diluições, soroterapia, equipamentos e energia;
- favicon próprio simples;
- marcador `codex-preview=development` ainda presente;
- sem configuração Open Graph/X;
- marca visual do cabeçalho ainda diz “Emergência Pediátrica”, criando dupla nomenclatura.

## 9. Dependências e entrega

- Node  $\geq 22.13$ .
- Next 16.2.6; React/React DOM 19.2.6; Vinext 0.0.50; Vite 8.0.13.
- Cloudflare Vite plugin 1.37.1; Wrangler 4.92.0.
- TypeScript 5.9.3; Tailwind 4.2.1; ESLint 9.39.4.
- Drizzle ORM 0.45.2 e Drizzle Kit 0.31.10, atualmente sem schema de aplicação.

O código clínico client-side importa aproximadamente 2,5 MB de fontes não comprimidas antes do empacotamento (página, dados, inventário e monografias), além dos arquivos de download. `definitive-guides.json` (~1,09 MB) e `nexo-consolidated.json` (~0,83 MB) são os maiores; o primeiro inclui texto de 96 páginas do PDF mesmo sem exibi-lo página por página. Isso aumenta o payload inicial.

## 10. Histórico reconstruído e regras substituídas

| Fase  | Requisito reconstruído                                                                               | Situação atual                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 08/08 | Importar planilha e criar medicamentos, fluidos, equipamentos, energia, segurança, cálculos e fontes | Ativo                                 |
| 11/08 | Expandir formulário nominal, idade, indicações separadas e tema roxo                                 | Conteúdo ativo; tema roxo substituído |
| 11/08 | Corrigir apresentações/vias brasileiras e documentar off-label                                       | Ativo, com revisões posteriores       |
| 16/08 | Adicionar alertas de soroterapia e expansão volêmica                                                 | Ativo                                 |

| Fase     | Requisito reconstruído                                                                     | Situação atual                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 20-21/08 | Gerar linha copiável domiciliar e oferecer opções de dose/intervalo                        | Ativo                                       |
| 21/08    | Agrupar medicamento -> indicação -> apresentação; retirar linhas vagas                     | Ativo                                       |
| 21/08    | Corrigir estreptococo/escarlatina e penicilina benzatina                                   | Ativo; teste impede escarlatina 8/8 h       |
| 21/08    | Vincular duração ao diagnóstico e idade; checar apresentações BH/RMBH                      | Ativo                                       |
| 21/08    | Reincorporar regimes concretos não volumétricos                                            | Ativo                                       |
| 21/08    | Corrigir limiares 20/27 kg e fatores exatos de clindamicina                                | Ativo                                       |
| 21/08    | Expandir ITU, impetigo, infecções, Lyme, profilaxia e H. pylori                            | Ativo                                       |
| 21/08    | Incorporar inventário de 413 itens                                                         | Ativo como catálogo documental              |
| 21/08    | Ocultar inventário sem esquema operacional e aplicar filtro de validação individual        | <b>Ativo</b>                                |
| 21/08    | Permitir off-label/esquemas de especialistas quando totalmente especificados e rastreáveis | <b>Ativo; não reverte o filtro anterior</b> |
| 21/08    | Trocar roxo por monocromático e Faustina                                                   | Ativo                                       |
| 21/08    | Dupla checagem de alta vigilância                                                          | Substituída por tripla checagem             |
| 21/08    | Incorporar dois guias definitivos e NEXO                                                   | Ativo                                       |

Não há registro Git com assunto de “reverter”, “cancelar” ou “desfazer”. Portanto, uma instrução conversacional de cancelamento que não gerou commit não pode ser tratada como aplicada. O estado autoritativo do checkout mantém o ocultamento de linhas sem validação individual.

Regras técnicas historicamente substituídas:

- verde/teal -> roxo -> monocromático;
- amoxicilina-clavulanato EV nominal 50 mg/mL -> concentração pelo volume final recuperado;
- cefuroxima nominal 250/125 mg/mL -> concentrações por volume final;
- limiar único implementado de forma específica -> helper para 20 e 27 kg;
- fatores aproximados de clindamicina -> fatores exatos;
- inventário-placeholder visível -> placeholders fora do seletor;
- “posição depende do protocolo” -> rótulos inferidos de posição/força;
- dupla checagem -> tripla checagem.

## 11. Lacunas e riscos de exportação

1. **Não existe prompt literal completo no checkout.** O PDF deve chamar a reconstrução de “configuração implementada”, não transcrição literal.
2. **413/413 é cobertura documental, não clínica calculável.** Há 89 grupos e 401 esquemas ativos; somente 70 registros do inventário têm chave exata correspondente em linhas ativas. Em outra métrica, 187/413 têm alguma representação exata na camada total, enquanto 226 permanecem apenas no inventário.
3. **Vínculo errado de monografia para gluconato de cálcio,** selecionando acetato de cálcio por correspondência parcial.
4. **Busca e categoria filtram grupos, não a seleção interna.** Um grupo pode aparecer porque uma indicação corresponde à busca, mas ao abrir continua selecionada a primeira indicação alfabética, potencialmente diferente. O filtro de categoria também não restringe as opções internas.
5. **Busca não normaliza acentos,** apenas minúsculas.
6. **Idades compostas não são aceitas,** apesar de requisitos históricos mencionarem formatos como 12m15d.
7. **211/401 linhas não têm limite estruturado de idade/peso.** Parte da segurança depende de texto e regras por nome.
8. **Força de recomendação e posição são heurísticas lexicais,** não classificação clínica formal.

9. **44 linhas ativas ainda contêm linguagem de protocolo no dado original**, mas `cleanClinicalText` substitui expressões como “confirmar protocolo institucional” por “aplicar o esquema descrito”; isso pode reduzir a visibilidade de incerteza.
10. **Tripla checagem não é plenamente independente** e não recalcula todos os modos/etapas.
11. **Alta vigilância inconsistente**: 182/205 linhas visivelmente marcadas não recebem a cautela explícita de checagem humana independente.
12. **Infusões incompletas**: 4/24 não entregam mL/h primário e 11/24 não têm diluição estruturada.
13. **Sem validação computacional de ajuste renal/hepático, interação, incompatibilidade ou estabilidade**. Campos são textuais.
14. **Heurísticas de duração domiciliar podem sobrepor nuances de gravidade, complicação e diretriz específica**.
15. **Entradas de soroterapia não têm limites/denominador-zero robustos**, e alertas não bloqueiam preparo.
16. **Carga client-side elevada**, pois monografias completas são enviadas na rota principal.
17. **Sem autenticação no código da página e sem persistência**. A política remota de acesso não foi exportada.
18. **Metadado de desenvolvimento permanece**, sem social card e com nomes de produto divergentes.
19. **Duplicidade semântica de ampicilina-sulbactam** em dois grupos.
20. **Sem atualização automática de fontes, bulas ou estoque**. Datas e links são um snapshot de agosto de 2026.

## 12. Verificações realizadas nesta auditoria

- Leitura integral da estrutura, página principal, estilos, dados, scripts de ingestão, testes, metadados, dependências e histórico Git.
- Execução somente leitura de dois conjuntos de testes: **31 aprovados, 0 falhas**.
- Execução de `audit:clinical`: **605 linhas, 362 calculáveis, 316 nomes, 413/413 inventário, 0 erros, 0 alertas**.
- Reconstrução programática da lista realmente exibida, incluindo filtros e expansões da página: **401 esquemas em 89 grupos**.
- Checkout permaneceu sem alterações rastreadas.
- Não foi executado build, preview visual ou implantação. O diretório `dist` não existe nesta cópia.

## 13. Itens não recuperáveis apenas deste checkout

- texto literal dos prompts/conversas originais;
- política remota de acesso/compartilhamento;
- URL e histórico de implantação a serem apresentados ao usuário;
- variáveis de ambiente hospedadas;
- análises/estatísticas de uso;
- confirmação de que cada URL externa continua vigente em 22/08/2026;
- validação clínica independente, medicamento por medicamento, de todas as 401 linhas;
- anexos do projeto que não foram copiados para `public/` fontes ou convertidos nas bases atuais.

## Funções de cálculo declaradas no código atual

```
export type ThresholdMode = "threshold20" | "threshold27";

export function thresholdValue(
  mode: ThresholdMode,
  weightKg: number,
  belowThreshold: number | null,
  atOrAboveThreshold: number | null,
) {
  const thresholdKg = mode === "threshold20" ? 20 : 27;
  return weightKg < thresholdKg ? belowThreshold : atOrAboveThreshold;
}

type CalculableMedication = {
  name: string;
  indication: string;
  calculation: Record<string, unknown>;
};

export function applyCalculationCorrections<T extends CalculableMedication>(medication: T): T {
  if (medication.name === "Ipratrópio brometo" && medication.indication.includes("Crise asmática moderada/
grave")) {
    return {
      ...medication,
      calculation: {
        ...medication.calculation,
        auditConcentration: 0.25,
        auditUnit: "mg/mL",
        reverseMin: 0.25,
        reverseMax: 0.5,
        reverseCheck: "OK por faixa de peso: 1 mL x 0,25 mg/mL = 0,25 mg; 2 mL x 0,25 mg/mL = 0,50 mg",
      },
    } as T;
  }

  if (medication.name === "Clindamicina" && medication.calculation.auditConcentration === 150) {
    const doseMgKg = medication.indication.includes("osteoarticular") ? 13 : 10;
    const exactFactor = doseMgKg / 150;
    return {
      ...medication,
      calculation: {
        ...medication.calculation,

        original: `${exactFactor.toLocaleString("pt-BR", { maximumFractionDigits: 9 })} mL/kg da apresentação`,
        factor1Min: exactFactor,
        factor1Max: exactFactor,
        reverseMin: doseMgKg,
        reverseMax: doseMgKg,
        reverseCheck: `OK: ${doseMgKg} mg/kg ÷ 150 mg/mL = ${exactFactor.toLocaleString("pt-BR", {
maximumFractionDigits: 9 })} mL/kg`,
      },
    } as T;
  }

  return medication;
}

type SafetyMedication = {
  route: string;
  status: string;
  interval: string;
  cautions: string;
  monitoring: string;
};

export function applyHighAlertSafety<T extends SafetyMedication>(medication: T): T {
  const context = `${medication.route} ${medication.status} ${medication.interval}`;
  if (!/BIC|alta vigilância|infusão contínua/i.test(context) || /tripla checagem humana independente/i.
test(medication.cautions)) return medication;
  return {
    ...medication,
    cautions: `${medication.cautions.replace(/[\s;]+$/, "")}. ALTA VIGILÂNCIA: exigir tripla checagem
humana independente de peso/idade, unidade e dose total, concentração final, via/acesso, programação da
bomba e limites de titulação.`,
  };
}
```

## Histórico cronológico de versões

| Data/hora registrada      | Commit  | Descrição da versão                                                       |
|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-08T13:01:23-03:00 | 9697d8b | Site clínico completo a partir da planilha pediátrica                     |
| 2026-08-11T15:15:41-04:00 | df94883 | Expandir catálogo pediátrico com auditoria clínica                        |
| 2026-08-11T15:34:53-04:00 | d9f7972 | Adicionar idade, indicações separadas e tema roxo                         |
| 2026-08-11T16:37:29-04:00 | 80585d8 | Adiciona amoxicilina-clavulanato EV e revisa vias brasileiras             |
| 2026-08-11T16:46:20-04:00 | e203e74 | Adicionar vias brasileiras e off-label auditadas                          |
| 2026-08-16T20:12:05-04:00 | a50fffd | Adiciona alertas clínicos à soroterapia pediátrica                        |
| 2026-08-16T20:17:07-04:00 | 650539b | Inclui calculadora de expansão volêmica pediátrica                        |
| 2026-08-21T02:48:55+09:00 | f68d47e | Adiciona linha copiável para receituário domiciliar                       |
| 2026-08-21T03:08:26+09:00 | 6d35ddc | Exibe todas as opções copiáveis de prescrição                             |
| 2026-08-21T03:12:32+09:00 | b6055e9 | Amplia indicações e hierarquia terapêutica                                |
| 2026-08-21T03:33:05+09:00 | 7307d58 | Revisa indicações e corrige lacunas clínicas                              |
| 2026-08-21T04:12:31+09:00 | 486907a | Atualiza título e simplifica topo                                         |
| 2026-08-21T04:20:59+09:00 | 07634f1 | Agrupar medicamentos e seleciona indicação e apresentação                 |
| 2026-08-21T04:25:39+09:00 | 2c58ac4 | Remove opções vagas da prescrição automática                              |
| 2026-08-21T04:28:10+09:00 | 594f055 | Corrige cobertura terapêutica para estreptococo                           |
| 2026-08-21T04:38:24+09:00 | d2dabd6 | Vincula duração ao diagnóstico e amplia indicações                        |
| 2026-08-21T04:43:16+09:00 | cad58c0 | Adiciona verificação de apresentações em BH e RMBH                        |
| 2026-08-21T04:52:13+09:00 | 77258a4 | Reincorporar medicamentos excluídos e ampliar esquemas estreptocócicos    |
| 2026-08-21T05:05:44+09:00 | bc76fa1 | Auditar catálogo em três passagens e corrigir cálculos por limiar de peso |
| 2026-08-21T05:19:21+09:00 | 7096b66 | Revisar posologias e corrigir fatores exatos de clindamicina              |
| 2026-08-21T05:28:15+09:00 | 882d13b | Ampliar indicações terapêuticas com hierarquia para ITU e impetigo        |
| 2026-08-21T05:32:46+09:00 | 802e112 | Expandir sistematicamente esquemas terapêuticos e simular doses           |
| 2026-08-21T05:50:56+09:00 | b240939 | Expandir formulário solicitado e normalizar sinônimos                     |
| 2026-08-21T17:54:34+03:00 | b68abd8 | Ampliar arsenal terapêutico com revisão clínica de 2026                   |
| 2026-08-21T18:00:36+03:00 | c3df4cd | Incorporar inventário pediátrico anexado completo                         |
| 2026-08-21T18:10:58+03:00 | f34ea2a | Concluir dupla revisão clínica e posológica                               |
| 2026-08-21T18:20:44+03:00 | 6228469 | Update Emergência Pediátrica - Doses e Cálculos                           |
| 2026-08-21T18:45:30+03:00 | 344dd3b | Update Emergência Pediátrica - Doses e Cálculos                           |
| 2026-08-21T18:47:25+03:00 | 6834599 | Update Emergência Pediátrica - Doses e Cálculos                           |
| 2026-08-21T18:54:41+03:00 | 515bc51 | Update Emergência Pediátrica - Doses e Cálculos                           |
| 2026-08-21T19:00:40+03:00 | 1e1f9f7 | Update Emergência Pediátrica - Doses e Cálculos                           |
| 2026-08-21T19:01:52+03:00 | 9851f4e | Update Emergência Pediátrica - Doses e Cálculos                           |
| 2026-08-21T20:01:52+03:00 | 3f89298 | Incorpora guias definitivos de farmacoterapia pediátrica                  |
| 2026-08-21T20:05:45+03:00 | 0ca6f95 | Adiciona tripla checagem posológica e auditoria integral                  |
| 2026-08-21T20:34:10+03:00 | ea8cafd | Incorporar monografias e auditoria do PDF NEXO                            |

## 5. Soroterapia Pediátrica

| Campo                        | Valor                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Título                       | Soroterapia Pediátrica                                                                                                          |
| Slug                         | soroterapia-pediatrica                                                                                                          |
| URL de produção              | <a href="https://soroterapia-pediatrica.iagovalmeida.chatgpt.site">https://soroterapia-pediatrica.iagovalmeida.chatgpt.site</a> |
| Criado                       | 11/08/2026                                                                                                                      |
| Última atualização publicada | 21/08/2026 18:09 BRT                                                                                                            |
| Versão atual                 | 29                                                                                                                              |
| Commit                       | d2d3da3f8c819fdef676bee618762a9662bb88d0                                                                                        |
| Acesso                       | Custom; proprietário único; sem visitantes externos                                                                             |
| Ambiente                     | 0 variáveis de produção; 0 domínios personalizados                                                                              |


**Gota a Gota**  
 Soroterapia pediátrica

Calculadora
 Referências
 Compositor
 Soluções
 Segurança


**Referências verificadas**

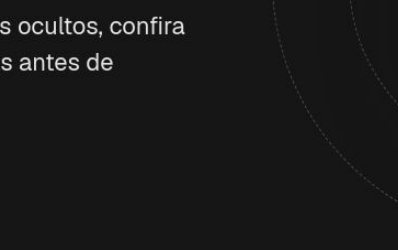

**APOIO À DECISÃO • PEDIATRIA E NEONATOLOGIA**

# Soroterapia que fecha a conta — e mostra como.

Calcule manutenção, subtraia aportes ocultos, confira TIG e enxergue as pendências clínicas antes de preparar a bolsa.


**Abrir calculadora** >


**Ver barreiras de segurança**



**1**
**Separar** ressuscitação, déficit, perdas e manutenção

**2**
**Calcular** 100% teórico e o percentual clínico

**3**
**Descontar** dieta, drogas e demais infusões

**4**
**Reavaliar** composição, exames e balanço

## Prompt mestre portátil reconstruído

## Prompt mestre portátil - Soroterapia Pediátrica

Crie uma calculadora de soroterapia para pediatria e neonatologia que feche a conta de água, eletrólitos e glicose de modo auditável, fornecendo volumes por 24 h, 12 h e 8 h e velocidade em mL/h. Separe ressuscitação, correção de déficit/perdas e manutenção.

## Entradas e cálculos

- Solicite peso, idade/faixa neonatal, período, percentual de manutenção, condição clínica, diurese/função renal, eletrólitos, glicemia e aportes paralelos quando relevantes.
- Calcule manutenção por Holliday-Segar e exponha fórmula, volume total e vazão.
- Calcule Na, K, Ca e glicose na unidade clínica correta, converta por apresentação real e mostre mEq/kg/dia, mg/kg/min (TIG/GIR), quantidade do soluto, volume a aspirar, volume final e mL/h.
- Desconte aportes ocultos de dieta, drogas e outras infusões. Recalcule sequencialmente quando qualquer parâmetro mudar.

- Mostre faixas mínima, usual e máxima somente quando sustentadas por fonte; evite aplicar automaticamente uma combinação padrão a todo paciente.

## Módulos clínicos

- Inclua compositor de soluções e inventário de apresentações de glicose, NaCl, KCl, gluconato de cálcio, albumina e soluções usuais.
- Inclua protocolos especiais para neonatos/prematuros, choque, desidratação, CAD, queimaduras, disnatremias, distúrbios do potássio, SIADH, insuficiência renal/cardíaca/hepática, meningite/TCE, desnutrição, poliúria e lise tumoral, com fórmulas e metas próprias.
- Inclua correção hidroeletrólítica guiada e modificadores clínicos de manutenção.
- Na ausência de NPT, trate a oferta periférica mínima de gluconato de cálcio 10% em prematuros como protocolo off-label explícito, usando o menor valor necessário dentro da faixa escolhida, com volume clicável e barreiras de acesso/compatibilidade. Não confundir com carbonato de cálcio.
- Para albumina, calcular apresentação, dose, diluição, volume e tempo, sem transformar hipoalbuminemia isolada em indicação automática.

## Segurança e apresentação

- Exigir dupla checagem para eletrólitos concentrados, taxa máxima, acesso periférico/central, compatibilidade, concentração final e programação da bomba.
- Destacar em vermelho/negrito quando acesso central for necessário; manter alternativa periférica somente quando segura.
- Usar layout monocromático compacto, responsivo, com resultados diretos e referências verificadas.
- Não ocultar informação clínica ao compactar; retirar apenas auditoria/referências da primeira camada visual quando solicitado, mantendo rastreabilidade no projeto.

## Auditoria da configuração ativa

## Exportação técnica forense de três SitesGPTs clínicos

### Escopo e método

Este documento registra, com o máximo de detalhe recuperável dos arquivos locais e do histórico Git, o estado dos projetos:

1. soroterapia-pediatrica;
2. ventilacao-mecanica;
3. folha-de-parada.

A auditoria foi somente leitura. Nenhum checkout foi modificado. Foram examinados o código-fonte atual, arquivos de configuração, testes, ativos, estrutura de rotas e todos os commits disponíveis em cada repositório. Os assuntos dos commits foram usados como vestígios dos pedidos sucessivos; os corpos das mensagens estão vazios, portanto **não existe no Git uma cópia literal dos prompts originais**. Onde este relatório fala em “requisito reconstruído”, trata-se de inferência verificável a partir do assunto do commit e do diff correspondente, não de transcrição do prompt do usuário.

Esta é uma exportação técnica do comportamento implementado. Ela não substitui revalidação clínica independente, revisão farmacêutica, validação institucional nem conferência das apresentações disponíveis no serviço.

### Regras de sigilo aplicadas

- Não foram transcritos tokens, credenciais, e-mails, cabeçalhos de autenticação, identificadores internos de hospedagem nem outros IDs opacos.
- Os arquivos de configuração de hospedagem foram descritos apenas pelo comportamento relevante.
- Referências bibliográficas e nomes públicos de diretrizes foram preservados por serem parte do conteúdo clínico e não segredos.

### Visão consolidada

| Projeto                | Rota ativa | Revisões Git | Núcleo clínico verificável                                                                          | Persistência | Estado do checkout |
|------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Soroterapia pediátrica | /          | 29           | 7 soluções-base, 28 apresentações, 14 protocolos especiais, 11 modificadores, 5 eletrólitos         | Nenhuma      | Limpo              |
| Ventilação mecânica    | /          | 17           | 6 modos de suporte, 3 populações, 28 protocolos por condição, 10 tópicos avançados, 5 resgates      | Nenhuma      | Limpo              |
| Folha de parada        | /          | 5            | 55 itens clínicos em 9 categorias, 11 estimativas de equipamento, 4 planos ventilatórios, 4 bundles | Nenhuma      | Limpo              |

## Arquitetura compartilhada

Os três projetos são aplicações de página única, renderizadas por React/Next em uma rota principal. A camada de execução usa Vinext/Vite em um Cloudflare Worker. O Worker encaminha a rota interna de otimização de imagens e delega as demais requisições ao manipulador do App Router. Não há API clínica própria, cron, fila, armazenamento de objeto nem banco configurado.

Elementos comuns:

- `app/page.tsx`: interface e cálculos do cliente;
- `app/layout.tsx`: metadados, idioma e fonte;
- `app/globals.css`: design responsivo e impressão;
- `worker/index.ts`: entrada do Worker;
- `db/schema.ts`: esquema intencionalmente vazio;
- `db/index.ts`: auxiliar opcional de D1, não utilizado pelas páginas atuais;
- `.openai/hosting.json`: hospedagem sem D1 e sem R2;
- `examples/d1`: exemplo isolado, não conectado ao produto atual;
- suíte Vitest: teste de renderização da rota / e metadado de desenvolvimento; não é uma suíte de validação clínica.

Existe um auxiliar de autenticação no código-base, mas nenhuma das páginas atuais o importa. Assim, o comportamento efetivo é anônimo e local ao navegador. Não há login, gravação em banco, `localStorage`, sincronização, analytics nem envio de dados clínicos para um servidor próprio. Ao recarregar a página, o estado é perdido.

## Dependências e execução

Todos usam Node  $\geq 22.13.0$ , Next 16.2.6, React/React DOM 19.2.6 e drizzle-orm 0.45.2. As dependências de desenvolvimento incluem TypeScript 5.9.3, Vite 8.0.13, Vinext 0.0.50, Wrangler 4.92.0, Tailwind 4.2.1, Vitest e o plugin Cloudflare para Vite. Soroterapia também declara `lucide-react`.

Scripts compartilhados: instalação reproduzível, desenvolvimento, build, start, teste, validação do artefato, lint e geração de esquema. A existência de Drizzle e do script de esquema não implica persistência: o esquema atual está vazio.

---

## 1. Soroterapia pediátrica

### 1.1 Finalidade e limites implementados

Aplicação intitulada “**Soroterapia Pediátrica**”, descrita nos metadados como calculadora auditável de manutenção hídrica, taxa de infusão de glicose e composição para pediatria e neonatologia. O cabeçalho interno usa a identidade “Gota a Gota”.

O produto reúne:

- manutenção hídrica pediátrica;
- água neonatal por dia de vida;
- TIG/GIR e conversões de glicose;
- composição de bolsa com eletrólitos e cálcio;
- fracionamento em 24, 12 ou 8 horas;
- expansão volêmica;
- correções hidroeletrólíticas guiadas;
- albumina;
- queimaduras;
- decisão de potássio;
- cálcio periférico para prematuro em cenário sem NPT;
- biblioteca operacional de 14 protocolos especiais.

O site não prescreve sozinho nem conhece o estoque real. Diversos resultados são rotulados como referência, dependem de confirmação laboratorial, acesso vascular, compatibilidade, protocolo local ou reavaliação clínica.

## 1.2 Estrutura, arquivos e contagens

| Arquivo atual        | Linhas | Tamanho aproximado | Função                                                  |
|----------------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| app/page.tsx         | 1.935  | 155 KB             | Interface, estado, validações e cálculos                |
| app/clinical-data.ts | 89     | 14 KB              | Soluções, apresentações, fontes e registro de auditoria |
| app/globals.css      | 806    | 71 KB              | Layout monocromático, responsividade e impressão        |

Contagens derivadas do código atual:

- 63 ocorrências de useState;
- 20 de useMemo;
- 4 de useEffect;
- 12 elementos <section>;
- 7 soluções-base;
- 28 apresentações comerciais/técnicas;
- 11 perfis de condição clínica;
- 4 contextos de referência;
- 5 grupos de correção eletrolítica;
- 14 guias de protocolo especial;
- 8 registros de materiais auditados e 9 registros de fontes externas retidos no arquivo de dados, mas ocultos da interface atual.

### Ordem funcional da rota /

1. navegação superior com atalhos;
2. hero “Gota a Gota” e faixa de escopo;
3. calculadora de manutenção;
4. referência prática de eletrólitos e glicose;
5. neonatologia e TIG;
6. cálcio em prematuro sem NPT;
7. compositor de bolsa;
8. soluções, apresentações e albumina;
9. fracionamento por período;
10. expansão e queimaduras;
11. correção hidroeletrólítica;

12. protocolos especiais;
13. rodapé.

A navegação oferece um destino #seguranca, mas não foi encontrado um elemento ativo com esse identificador. É um atalho sem alvo no estado atual.

### 1.3 Dados clínicos estruturados

#### Soluções-base

| Solução          | Glicose   | Na        | K | Cl        | Osmolaridade declarada |
|------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------------------|
| SG 5%            | 50 mg/mL  | 0         | 0 | 0         | 278 mOsm/L             |
| SG 10%           | 100 mg/mL | 0         | 0 | 0         | 555 mOsm/L             |
| SF 0,9%          | 0         | 154 mEq/L | 0 | 154 mEq/L | 308 mOsm/L             |
| SG 5% + SF 0,9%  | 50 mg/mL  | 154       | 0 | 154       | 586 mOsm/L             |
| Ringer lactato   | 0         | 130       | 4 | 109       | 273 mOsm/L             |
| Plasma-Lyte      | 0         | 140       | 5 | 98        | 295 mOsm/L             |
| SG 5% + SF 0,45% | 50 mg/mL  | 77        | 0 | 77        | 428 mOsm/L             |

A osmolaridade é exibida como propriedade da solução-base, mas não entra em um cálculo cumulativo da bolsa pronta.

#### Apresentações cadastradas: 28

| Família             | Quantidade | Apresentações                                    |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Glicose             | 5          | SG 2,5%; SG 5%; SG 10%; glicose 25%; glicose 50% |
| Cloreto de sódio    | 8          | 0,18%; 0,2%; 0,45%; 0,9%; 3%; 10%; 20%; 23,4%    |
| Cloreto de potássio | 5          | 7,45%; 10%; 14,9%; 15%; 19,1%                    |
| Albumina            | 3          | 5%; 20%; 25%                                     |
| Cálcio              | 2          | gluconato de cálcio 10%; cloreto de cálcio 10%   |
| Bicarbonato         | 2          | 4,2%; 8,4%                                       |
| Sulfato de magnésio | 3          | 10%; 20%; 50%                                    |

Conversões implementadas para concentrados:

$\text{NaCl (mEq/mL)} = \frac{\% \times 10}{58,44}$

$\text{KCl (mEq/mL)} = \frac{\% \times 10}{74,551}$

O código também armazena equivalências declaradas por apresentação e usa a apresentação selecionada para converter necessidades em volume. A interface insiste na conferência do rótulo, particularmente para cálcio e soluções concentradas.

### 1.4 Manutenção hídrica pediátrica

#### Holliday-Segar em 24 horas

Para peso  $p$ , em kg:

$$V_{24h} = \begin{cases} 100p, & p \leq 10 \\ 1000 + 50(p-10), & 10 < p \leq 20 \\ 1500 + 20(p-20), & p > 20 \end{cases}$$

No estado atual, o resultado é limitado a **2.400 mL/dia**. O código aceita peso de 0,1 a 250 kg e percentuais de 0 a 200%.

#### Regra 4-2-1

$$V_h = \begin{cases} 4p, & p \leq 10 \\ 40 + 2(p-10), & 10 < p \leq 20 \\ 60 + (p-20), & p > 20 \end{cases}$$

A vazão horária é limitada a **100 mL/h**. Esse teto e o teto de 2.400 mL/dia foram incluídos na revisão tripla final.

## Ajustes e entradas concomitantes

- O usuário pode selecionar um percentual do volume de manutenção.
- Entradas de 24 horas já administradas são subtraídas do plano.
- Se a subtração geraria volume negativo, o resultado residual é bloqueado em zero e sinalizado.
- Os modificadores clínicos podem alterar a fração de manutenção, escolha de base, expansão e uso de potássio.

## 1.5 Água neonatal e glicose

Holliday-Segar é explicitamente contraindicado como regra automática para o neonato. O módulo neonatal trabalha por dia de vida:

| Dia de vida | Faixa de água     |
|-------------|-------------------|
| D1          | 50-60 mL/kg/dia   |
| D2          | 70-80 mL/kg/dia   |
| D3          | 80-100 mL/kg/dia  |
| D4          | 100-120 mL/kg/dia |
| D5 a D28    | 120-150 mL/kg/dia |

Se “premature” estiver marcado, a interpretação automática é interrompida e o site exige individualização.

## TIG/GIR

Para concentração de glicose  $\text{\textbackslash}(C\text{\textbackslash})$  em porcentagem, vazão  $\text{\textbackslash}(Q\text{\textbackslash})$  em mL/h e peso  $\text{\textbackslash}(p\text{\textbackslash})$  em kg:

$$\text{\textbackslash}[\text{\textbackslash}\text{glicose em mg/mL}\text{\textbackslash}]=10C\text{\textbackslash}$$

$$\text{\textbackslash}[\text{\textbackslash}\text{GIR (mg/kg/min)}\text{\textbackslash}]=\frac{10C\text{\textbackslash}\times Q\text{\textbackslash}}{60p}\text{\textbackslash}$$

O inverso também é calculado:

$$\text{\textbackslash}[Q=\frac{\text{\textbackslash}\text{GIR alvo}\text{\textbackslash}\times p\text{\textbackslash}\times 60}{10C}\text{\textbackslash}]$$

Além da vazão, o site converte o plano para gramas por dia. Na referência rápida, a conversão é:

$$\text{\textbackslash}[\text{\textbackslash}\text{glicose (g/dia)}\text{\textbackslash}]=\text{\textbackslash}\text{GIR}\text{\textbackslash}\times p\text{\textbackslash}\times 1\{,\}44\text{\textbackslash}$$

Faixas de referência exibidas:

- RN a termo: 4-6 mg/kg/min;
- prematuro: 6-8 mg/kg/min;
- criança: 3-5 mg/kg/min.

## 1.6 Referências por contexto e atalhos diários

### Quatro contextos de referência

| Contexto                           | Sódio                        | Potássio             | GIR min./sug./máx.  |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| Pediátrico, 28 dias a 18 anos      | 131 / 154 / 154 mEq/L finais | 10 / 20 / 25 mEq/L   | 3 / 4 / 5 mg/kg/min |
| RN a termo, primeiras 24 h         | 0                            | 0                    | 4 / 5 / 6           |
| RN a termo após 24 h e com diurese | 2 / 3 / 4 mEq/kg/dia         | 2 / 2 / 4 mEq/kg/dia | 4 / 5 / 6           |
| Prematuro ou crítico               | sem automatização            | sem automatização    | 6 / 7 / 8           |

## Referência prática de eletrólitos

- Sódio, neonato/prematuro: 2-4 mEq/kg/dia.
- Sódio, criança até 10 kg: 2-3 mEq/kg/dia.
- Sódio, criança acima de 10 kg: 2-3 mEq por 100 mL de manutenção.
- Sódio, adulto: aproximadamente 1 mEq/kg/dia.
- Potássio, neonato/prematuro: 2-4 mEq/kg/dia.

- Potássio, criança até 10 kg: 1-2 mEq/kg/dia.
- Potássio, criança acima de 10 kg: 1-2 mEq por 100 mL de manutenção.
- Potássio, adulto: aproximadamente 1 mEq/kg/dia.

## 1.7 Modificadores clínicos: 11 perfis ativos

| Perfil                | Manutenção inicial | Expansão sugerida | Base/efeito principal                         |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Padrão                | 100%               | 10 mL/kg          | SG 5% + SF 0,9%                               |
| Sepse                 | 100%               | 10 mL/kg          | base glicosada isotônica; expansão balanceada |
| Risco de SIADH        | 67%                | 10 mL/kg          | restrição e base isotônica                    |
| Cardiopatia           | 60%                | 5 mL/kg           | cautela volêmica                              |
| Disfunção renal       | 50%                | 5 mL/kg           | potássio bloqueado                            |
| TCE                   | 100%               | 10 mL/kg          | SF 0,9%; sem glicose de rotina                |
| Hiperglicemia         | 100%               | 10 mL/kg          | SF 0,9%                                       |
| Risco de hipoglicemia | 100%               | 10 mL/kg          | base glicosada isotônica                      |
| Cetoacidose diabética | bloqueada          | bloqueada         | protocolo específico obrigatório              |
| Disnatremia grave     | bloqueada          | bloqueada         | protocolo específico; potássio bloqueado      |
| Desnutrição grave     | bloqueada          | bloqueada         | protocolo específico; potássio bloqueado      |

Esses perfis não substituem a seleção manual; funcionam como condicionadores do plano e exibem alertas contextuais.

## 1.8 Compositor de bolsa

### Equações centrais

$$V_{\text{base}} = V_{\text{final}} - \sum V_{\text{aditivos}}$$

Se o volume dos aditivos excede o volume final, a receita é inválida e fica bloqueada.

O compositor soma o conteúdo intrínseco da solução-base e os aditivos para calcular:

- glicose final em porcentagem;
- sódio, potássio e cloro em mEq/L;
- GIR/TIG resultante;
- sódio e potássio em mEq/kg/dia;
- cálcio elementar, adotando 9,3 mg/mL para gluconato de cálcio 10%;
- volume de base e de cada aditivo;
- vazão de bomba.

### Fracionamento de bolsas

- O usuário define o volume máximo de cada bolsa; o padrão é 500 mL.
- A aplicação calcula quantas bolsas sequenciais são necessárias e o conteúdo de cada estágio.
- Opções de preparo em 24, 12 ou 8 horas preservam a dose total de 24 horas e a mesma vazão de bomba.
- A interface esclarece que cada sugestão deve ser recalculada sequencialmente depois de qualquer alteração da apresentação, composição ou período.

### Segurança de acesso

O compositor classifica como inadequado para acesso periférico quando:

- glicose final > 12,5%; ou
- potássio final > 40 mEq/L.

Não há um motor completo de compatibilidade química ou cálculo de osmolaridade final. A lógica atual é um guardrail de concentração, não um validador de Y-site, estabilidade ou precipitação.

## 1.9 Decisão de potássio

O módulo exige peso, potássio sérico, diurese e estado renal.

### Bloqueios

- ausência de diurese;
- disfunção renal;
- $K > 5,5$  mEq/L;
- perfil clínico que bloqueia potássio.

$K > 5,0$  mEq/L gera orientação de suspensão/espera.  $K < 3,5$  mEq/L ou alteração eletrocardiográfica direciona para reposição separada, não simples manutenção.

### Reposição separada

| Situação | Velocidade   | Teto absoluto | Duração típica |
|----------|--------------|---------------|----------------|
| Usual    | 0,2 mEq/kg/h | 10 mEq/h      | 3 h            |
| Crítica  | 0,4 mEq/kg/h | 20 mEq/h      | 1 h            |

A concentração da solução preparada é informada pelo usuário, com 40 mEq/L como valor inicial. O volume exato da ampola é convertido segundo a apresentação de KCl selecionada. Para manutenção, a sugestão usual é 20 mEq/L; em CAD, 40 mEq/L, subordinado ao protocolo.

## 1.10 Correções hidroeletrólíticas guiadas

A revisão final passou a validar se a dose escolhida pertence às opções permitidas por eletrólito; valores fora da enumeração não são aceitos silenciosamente.

### Sódio

**Hiponatremia sintomática:** NaCl 3% em 2-3 mL/kg, administrado no tempo selecionado. A concentração operacional usada é 0,513 mEq/mL. O alvo inicial exibido é aumento de 4-6 mEq/L, com limite de 8 mEq/L em 24 horas.

**Hiponatremia crônica/assintomática:** déficit baseado em água corporal total, com fator 0,6 ou 0,7 conforme contexto, sódio atual e sódio-alvo.

### Hipernatremia:

$$\left[ \text{água livre (mL)} \right] = ACT \times p \times \left( \frac{Na_{\text{atual}}}{Na_{\text{alvo}}} - 1 \right) \times 1000$$

O déficit é planejado em 48 horas. O texto limita correção a  $\leq 0,5$  mEq/L/h e 10-12 mEq/L/dia.  $Na \geq 170$  mEq/L bloqueia a proposta automática e exige protocolo intensivo.

### Potássio

- Hipocalemia: 0,2 ou 0,4 mEq/kg/h, com tetos de 10 ou 20 mEq/h.
- Concentração de referência: periférica 40 mEq/L; central 80 mEq/L.
- O volume exato de KCl é derivado da apresentação selecionada.
- Hipercalemia  $> 5,5$  mEq/L: se ECG alterado, gluconato de cálcio 10% 0,68 mL/kg, máximo 30 mL.
- Deslocamento intracelular: SG 10% 5 mL/kg + insulina regular 0,1 U/kg, máximo 10 U, assumindo preparo de 1 U/mL.

### Cálcio

- Aplicável a sintomas ou alteração de ECG.
- Opções: 0,07; 0,10; 0,14 mmol/kg.
- Teto: 4,4 mmol.
- Gluconato de cálcio 10%: 0,22 mmol/mL.
- Diluição operacional até 0,11 mmol/mL.
- Tempo mínimo de infusão: 10 minutos.

## Magnésio

- Indicada para quadro sintomático ou  $Mg < 0,5 \text{ mmol/L}$ .
- Opções: 0,1; 0,2; 0,4 mmol/kg.
- Teto: 8 mmol.
- $MgSO_4$  50%: 2 mmol/mL.
- Tempo mínimo: 2 horas.
- O exemplo de volume final de 50 mL é deliberadamente marcado como dependente de validação institucional.

## Fosfato

- Doses: 0,1; 0,2; 0,3 mmol/kg.
- Concentração periférica: 0,05 mmol/mL.
- Concentração central: 0,12 mmol/mL.
- Infusão em 6 horas.
- Teto de velocidade: 0,2 mmol/kg/h.
- Bloqueado em injúria renal aguda/anúria.
- A escolha do sal deve considerar a carga adicional de sódio ou potássio.

### 1.11 Albumina, expansão e queimaduras

#### Albumina

Apresentações de 5%, 20% e 25%. Para dose  $d$  em g/kg:

$$[\text{gramas}] = p \times d$$

$$[\text{volume da fonte}] = \frac{[\text{gramas}]}{(\%/100)}$$

Se a fonte for  $> 5\%$ , o usuário pode pedir diluição para 5%; o diluente é a diferença entre volume final e volume da fonte. A vazão é calculada pelo tempo escolhido. Os campos “albumina atual” e “meta” existem no estado da página, mas **não participam da fórmula atual**; são informativos/inertes.

#### Expansão

Opções de 5, 10 ou 20 mL/kg, com tempo e número de repetições. A aplicação calcula volume por etapa, volume total e velocidade. Repetições são condicionadas à reavaliação, não disparadas automaticamente.

#### Queimaduras

$$[V_{\text{total}}] = k \times p \times \%SCQ$$

O coeficiente  $k$  pode ser 2, 3 ou 4 mL/kg/%SCQ. Metade é destinada às primeiras 8 horas a partir do momento da queimadura e metade às 16 horas seguintes. O módulo desconta o volume já infundido e recalcula a velocidade até o próximo marco temporal.

### 1.12 Cálcio periférico para prematuro sem NPT

O histórico mostra três estados sucessivos: primeiro foi criado um protocolo de cálcio em NPT; depois foi introduzido o preparo periférico sem NPT; por fim, o serviço foi assumido como sem NPT. A regra operacional atual é a última.

- Referência inicial mantida: 0,8-1 mmol/kg/dia.
- Referência após 48 h em NPT: 1,5-2 mmol/kg/dia, **apenas como contexto**, não como automação ativa.
- Fallback operacional ativo sem NPT: 0,8 mmol/kg/dia.
- Fonte presumida: gluconato de cálcio 10%, 0,22 mmol/mL.
- Administração: contínua, incorporada ao volume final de 24 horas.
- O volume sugerido pode ser transferido por clique para o compositor.
- Exige checagem de cálcio ionizado, função renal, diurese, compatibilidade e acesso.
- Carbonato de cálcio não é proposto por via IV.

- O módulo esclarece que essa estratégia não é dose de reanimação.

Há uma tensão técnica explícita: o arquivo de apresentações também expressa equivalência em mEq/mL, enquanto o módulo usa a hipótese de 0,22 mmol/mL. A interface manda conferir o rótulo; não existe reconciliação automática entre fabricantes.

### 1.13 Protocolos especiais: 14

Cada guia contém dados necessários, quatro etapas operacionais, alertas e pelo menos um resultado direto por peso.

| Protocolo                             | Regras/saídas implementadas mais relevantes                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Choque                                | bolus de 10 ou 20 mL/kg em 20 min, reavaliação e escolha de cristalóide                                                |
| Déficit/perdas                        | déficit estimado = peso × % de desidratação × 10; somar perdas contínuas com reavaliação                               |
| Cetoacidose diabética                 | 10-20 mL/kg em 20-30 min quando indicado; insulina 0,05-0,1 U/kg/h; em solução 1 U/mL, número de U/h coincide com mL/h |
| Queimaduras                           | fórmula por coeficiente, peso e SCQ; metade em 8 h e metade em 16 h                                                    |
| Disnatremias                          | NaCl 3% 2-3 mL/kg em 15 min quando hiponatremia grave sintomática; limites de correção                                 |
| Diabetes insipidus                    | reposição por balanço, sódio e perdas; não automatiza desmopressina                                                    |
| TCE/edema cerebral                    | NaCl 3% 2-5 mL/kg em 10-20 min; contínuo 0,1-1 mL/kg/h apenas em UTI/protocolo                                         |
| Insuficiência renal/cardiaca/hepática | redução de volume e eletrólitos condicionada a diurese, balanço, função e monitorização                                |
| Desnutrição grave                     | bloqueia fórmula padrão e encaminha ao protocolo específico                                                            |
| Prematuro/extremo prematuro           | individualização por idade gestacional, dia de vida, perdas insensíveis e exames                                       |
| Gastroenterite                        | SRO 50-100 mL/kg em 4 h; reposição adicional de 10 mL/kg por perda                                                     |
| SIADH                                 | restrição hídrica contextual; solução isotônica e vigilância do sódio                                                  |
| Perioperatório/jejum                  | referência 4-2-1; exemplo de 80% e ajuste por condição/cirurgia                                                        |
| Hemorragia aguda/trauma               | concentrado de hemácias 10 mL/kg, além da abordagem de choque e hemostasia                                             |

### 1.14 Segurança clínica ativa

- Validação explícita de intervalos numéricos para peso, percentuais, eletrólitos e tempos.
- Bloqueio de volume-base negativo.
- Bloqueio de automação em CAD, disnatremia grave e desnutrição grave.
- Bloqueio de potássio sem diurese, em disfunção renal ou hipercalemia.
- Limites de acesso periférico para glicose e potássio.
- Limites de velocidade e dose nas correções eletrolíticas.
- Sódio  $\geq 170$ , anúria/IRA e outras situações críticas desviam para protocolo intensivo.
- Reavaliação declarada após cada bolus/etapa.
- Conferência de rótulo, apresentação e acesso permanece obrigatória.
- Função de copiar resumo usa apenas a área de transferência do navegador; não grava dados.

Não há checagem automática de alergias, interação medicamentosa, disponibilidade de estoque, compatibilidade química completa, estabilidade, pH da bolsa, osmolaridade total ou protocolo institucional versionado.

### 1.15 UX, design e impressão

- Identidade monocromática em escala de cinza; o CSS aplica filtro de grayscale.
- Fonte Geist/Geist Mono, com fallbacks do sistema.
- Conteúdo amplo, largura útil aproximada de 1.480 px e tipografia ampliada em cinco pontos durante a evolução.
- Cartões, tabelas expansíveis, atalhos por faixa e botões que transferem volumes entre módulos.
- Breakpoints responsivos em aproximadamente 1.200, 960, 920, 640 e 430 px.

- Na impressão, topbar, hero, faixa de escopo e ações são ocultados para privilegiar os resultados.
- Não há salvamento de caso, histórico de pacientes, URL compartilhável nem exportação nativa do plano.

1.16 Fontes e rastreabilidade

O arquivo de dados preserva nove referências externas, embora a seção visual tenha sido removida:

1. Sociedade Brasileira de Pediatria - PRONAP 2025;
2. NICE NG29 - fluidoterapia IV em crianças e jovens;
3. NICE NG154 - fluidoterapia IV em neonatos;
4. American Academy of Pediatrics - manutenção isotônica, 2018;
5. ANVISA - segurança no uso de medicamentos;
6. farmacovigilância da SMSA de Belo Horizonte;
7. REMUME 2026;
8. Royal Children’s Hospital - fluidos intravenosos pediátricos, 2026;
9. Royal Children’s Hospital - fluidos neonatais.

Também permanecem oito registros internos de auditoria de materiais: caso de PDF problemático, planilha, instruções, especificações em Markdown, manual de prompt, protocolo antigo, tabela prática e tratado mestre. Esses registros não aparecem ao usuário e não são consultados dinamicamente.

1.17 Histórico reconstruído e regras substituídas

Linha do tempo dos requisitos implementados

| Data        | Requisito inferido do histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 ago 2026 | calculadora hídrica/neonatal inicial; expansão para plataforma completa; faixas mínimas/máximas; conversões em mL; recálculo sequencial; integração do plano; referência prática; tratado mestre; paleta monocromática                                                                                                                                                     |
| 21 ago 2026 | fracionamento 24/12/8 h; segurança de acesso; atalhos; tipografia maior; manutenção antecipada; volumes por apresentação; largura maior; ocultação de auditoria/fontes; seletor expansível; albumina/expansão/protocolos; modificadores clínicos; potássio; correção hidroeletrólítica; cálcio em NPT e depois periférico sem NPT; preparo clicável; compactação do layout |
| 22 ago 2026 | revisão tripla de cálculos e segurança                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Estado antigo versus ativo

| Tema                     | Requisito antigo                   | Regra ativa                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identidade visual        | interface colorida                 | grayscale/monocromática                                                                        |
| Auditoria e fontes       | seções visíveis                    | dados retidos no código, interface ocultada                                                    |
| Barreiras antes da bolsa | seção de bloqueios centralizada    | removida; guardrails distribuídos nos campos e alertas                                         |
| Cálcio prematuro         | NPT com faixa pós-48 h operacional | serviço assumido sem NPT; fallback periférico 0,8 mmol/kg/dia; faixa de NPT apenas informativa |
| Texto do cálcio          | explicação extensa                 | apresentação compacta, mantendo o núcleo clínico                                               |
| D5 + SF 0,45%            | osmolaridade antiga de 406         | corrigida para 428 mOsm/L                                                                      |
| Manutenção               | fórmula sem teto final explícito   | 2.400 mL/dia e 100 mL/h                                                                        |
| Eletrólitos              | dose selecionada menos restrita    | opções enumeradas e validação de unidades/concentrações                                        |

1.18 Lacunas e riscos técnicos observáveis

1. Os campos de albumina atual e meta não entram na fórmula; podem sugerir uma personalização que não ocorre.
2. O atalho #seguranca não possui alvo ativo.
3. Fontes e trilha de auditoria estão no bundle, porém invisíveis; o usuário final não vê a proveniência completa.

4. A osmolaridade da solução-base não é recalculada após aditivos.
5. Não existe motor de compatibilidade/estabilidade/precipitação.
6. A equivalência de cálcio depende de hipótese fixa e confirmação de rótulo.
7. A data textual da interface não acompanha necessariamente a última revisão do código.
8. Os testes automatizados são de renderização; faltam testes de fronteira para fórmulas, limites, conversões, tetos e cenários clínicos.
9. Não há persistência, versionamento de prescrição nem registro de quem calculou/revisou.

---

## 2. Ventilação mecânica

### 2.1 Finalidade e escopo

Aplicação intitulada **“Ventilação Mecânica”**, descrita como assistente clínico especializado em ventilação adulta, pediátrica e neonatal. Funciona como estação de raciocínio à beira-leito, com entrada de caso, cálculos, interpretação de gasometria, avaliação de mecânica, suporte não invasivo/invasivo, desmame, biblioteca de condições especiais, tópicos avançados e terapias de resgate.

O site não envia comandos a ventiladores e não representa um dispositivo médico conectado. As configurações são sugestões educacionais/operacionais que exigem validação do equipamento, do paciente e da equipe assistente.

### 2.2 Estrutura e contagens verificáveis

| Arquivo         | Linhas | Tamanho aproximado | Função                                                     |
|-----------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| app/page.tsx    | 1.217  | 155 KB             | Todos os dados, cálculos e interface clínica               |
| app/globals.css | 507    | 64 KB              | Tema preto/dourado, modal, responsividade e acessibilidade |

Contagens atuais:

- 43 ocorrências de useState;
- 10 de useMemo;
- 2 de useEffect;
- 21 elementos <section>;
- 3 populações;
- 6 modos de suporte;
- 3 cenários de resposta rápida;
- 6 módulos de biblioteca, cada um com 5 seções;
- 28 protocolos por condição;
- 10 tópicos de prática avançada;
- 5 cartões de resgate;
- 5 representações SVG de curvas normais.

### Organização da rota /

1. navegação superior e abas de workspace fixas;
2. hero condensado;
3. roteiro guiado em seis passos;
4. curvas normais;
5. workspace do caso, gasometria e escores;
6. escolha do suporte;
7. faixa de método;
8. calculadoras de oxigenação, mecânica e resposta;
9. curvas geradas e assincronias;

10. cenários clínicos;
11. seis módulos da biblioteca em modal;
12. gasometria detalhada;
13. desmame;
14. seletor único das 28 condições;
15. dez tópicos avançados;
16. resgate;
17. rodapé.

## 2.3 Entradas, parsers e validações

### Populações

- adulto;
- pediátrico;
- neonatal.

### Dados aceitos

- peso e altura;
- idade em anos, meses e dias, inclusive expressão composta;
- idade gestacional entre 22 semanas e 0 dia e 44 semanas e 6 dias;
- sexo para peso predito adulto;
- perfil clínico entre oito opções;
- FiO2 em fração (0,21-1) ou porcentagem (21-100);
- PaO2 e SpO2;
- pH, PaCO2, HCO3, excesso de base, SaO2 e lactato;
- Na, K, Cl, cálcio ionizado e glicose;
- tipo de suporte e tempo de suporte;
- VT, pressões, PEEP, pressão média, frequência respiratória, frequência cardíaca;
- escores e marcadores clínicos;
- flags de critérios de prontidão, contraindicações ou confirmações diagnósticas.

### Intervalos codificados

| Campo                      | Faixa válida   |
|----------------------------|----------------|
| Peso                       | 0,3-500 kg     |
| Altura adulta              | 120-230 cm     |
| Altura pediátrica/neonatal | 30-220 cm      |
| PaO2                       | 5-800 mmHg     |
| SpO2                       | 50-100%        |
| pH                         | 6,5-8,0        |
| PaCO2                      | 5-250 mmHg     |
| HCO3                       | 2-80 mEq/L     |
| Excesso de base            | -40 a +40      |
| SaO2                       | 1-100%         |
| Lactato                    | 0-30 mmol/L    |
| Na                         | 80-200 mEq/L   |
| K                          | 1-10 mEq/L     |
| Cl                         | 50-180 mEq/L   |
| Ca ionizado                | 0,2-3 mmol/L   |
| Glicose                    | 10-1.500 mg/dL |
| VT                         | 1-3.000 mL     |
| Pressão de platô           | 0-100 cmH2O    |

| Campo            | Faixa válida |
|------------------|--------------|
| Pressão de pico  | 0-120 cmH2O  |
| PEEP             | 0-50 cmH2O   |
| Pressão média    | 1-80 cmH2O   |
| FR               | 1-200/min    |
| FC               | 10-300/min   |
| Tempo no suporte | 0-720 h      |

Valores inválidos tornam o resultado indisponível e produzem feedback; o código atual evita correções silenciosas e evita apresentar NaN, Infinity ou undefined.

## 2.4 Fórmulas antropométricas e volume corrente

### Peso corporal predito adulto

$$\text{PBW}_{\text{masc}} = 50 + 0,91(\text{altura} - 152)$$

$$\text{PBW}_{\text{fem}} = 45 + 0,91(\text{altura} - 152)$$

### Pediatria

Altura estimada apenas para exibição, entre 2 e 12 anos:

$$\text{altura}_{\text{aproximada}} = 77 + 6 \times \text{idade}$$

Peso ideal pela fórmula de Traub:

$$p_{\text{ideal}} = 2,396 \times e^{0,01863 \times \text{altura}}$$

A regra ativa é conservadora: o menor entre peso real e peso predito só é usado quando o usuário confirma PARDS. Em outras crianças, o peso real permanece a base. A estimativa de altura não substitui medida clínica.

### Faixas de VT

| População/perfil                     | VT sugerido                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Adulto com ARDS                      | 4-8 mL/kg PBW                                    |
| Adulto restritivo/fibrótico          | 4-6 mL/kg PBW                                    |
| Adulto geral                         | 6-8 mL/kg PBW                                    |
| Pediátrico com BPD/obstrução         | 8-12 mL/kg                                       |
| Pediátrico geral com perfil definido | 6-8 mL/kg                                        |
| RN com RDS                           | 5-7 mL/kg                                        |
| Aspiração de mecônio                 | 5-6 mL/kg                                        |
| PPHN ou NARDS                        | 4-6 mL/kg                                        |
| BPD neonatal                         | 8-12 mL/kg                                       |
| Hérnia diafragmática congênita       | estratégia baseada em pressão, não VT automático |

Idade pós-menstrual é estimada como idade gestacional em semanas + idade cronológica em anos  $\times 52,1775$ .

## 2.5 Oxigenação, mecânica e escores

### Equações implementadas

$$P/F = \frac{\text{PaO}_2}{\text{FiO}_2}$$

$$S/F = \frac{\text{SpO}_2}{\text{FiO}_2}$$

$$\text{ROX} = \frac{S/F}{\text{FR}}$$

$$\text{ROX} \text{ (text)} \text{ HR} = \frac{\text{ROX}}{\text{FC}/100}$$

$$\text{AG} = \text{Na} - \text{Cl} - \text{HCO}_3$$

$$\backslash [ \text{ autoPEEP=PEEP_{total}-PEEP_{ajustada} } \backslash ]$$
$$\backslash [ \Delta P=P_{\text{platô}}-PEEP_{total} \backslash ]$$
$$\backslash [ C_{\text{estática}}=\frac{VT}{\Delta P} \backslash ]$$
$$\backslash [ OI=\frac{FiO_2\times MAP\times 100}{PaO_2} \backslash ]$$
$$\backslash [ OSI=\frac{FiO_2\times MAP\times 100}{SpO_2} \backslash ]$$
$$\backslash [ VE=\frac{VT\times FR}{1000} \backslash ]$$

OI só é calculado em suporte invasivo. OSI também exige suporte invasivo e SpO2 entre 80 e 97%, para reduzir interpretação fora da faixa útil. Auto-PEEP negativo é tratado como dado inconsistente; ≥2 cmH2O aponta obstrução/aprisionamento relevante.

ROX

Para adulto, o site exibe os pontos temporais históricos de 2, 6 e 12 horas:

- risco de falha abaixo de 2,85; 3,47; 3,85, respectivamente;
- ≥4,88 como menor risco.

Em pediatria, ressalta que não há corte universal. ROX-HR é apresentado como exploratório/contextual, não como gatilho automático.

Gasometria

O módulo classifica padrões ácido-base a partir de pH, PaCO2 e HCO3 e calcula ânion gap quando sódio e cloro estão disponíveis. Não há implementação de fórmulas completas de compensação esperada nem delta-delta.

2.6 Configurações assistidas e alarmes

- Em obstrução: frequência respiratória mais baixa, fluxo inspiratório maior e I:E ≥1:3.
- Trigger inicial: fluxo 1-3 L/min ou pressão −0,5 a −2 cmH2O.
- Em PSV: ciclagem inicial em 25%, antecipada em padrão obstrutivo.
- Alarme alto de pressão: pico atual +3 cmH2O em neonato, +5 nas demais populações.
- Alarme baixo de PEEP: PEEP configurada −2 cmH2O.
- Alarmes de VT são derivados do alvo de volume.
- Referência de platô: adulto <30 cmH2O; PARDS ≤28 cmH2O, contextualizável por parede torácica.

As sugestões dependem da disponibilidade de inputs; não são enviadas ao ventilador.

2.7 Seis modos de suporte

| Modo             | Conteúdo estruturado                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CPAP             | indicação, configuração inicial, monitorização, critérios de escalada   |
| BiPAP            | EPAP/IPAP, suporte, sincronização, resposta e falha                     |
| PSV não invasiva | pressão de suporte, PEEP, gatilho/ciclagem e escalada                   |
| PSV invasiva     | suporte, sincronia, mecânica e prontidão para desmame                   |
| PCV              | pressão inspiratória, PEEP, tempo inspiratório, VT resultante e alarmes |
| VCV              | VT, fluxo, frequência, PEEP, platô, driving pressure e alarmes          |

Cada modo expõe indicação, ajuste inicial e sinalizadores de escalada. A biblioteca evita declarar um único modo como universal.

2.8 Cenários de resposta rápida

1. **PARDS**, baseado no PALICC-2.
2. **ARDS adulto**, baseado em recomendações ATS 2024.
3. **RDS neonatal**, baseado no consenso europeu 2025.

Esses cartões ligam população, objetivo, metas, ajustes e resgate, e alimentam a leitura do workspace.

## 2.9 Biblioteca de seis módulos

Cada módulo tem cinco subseções estruturadas e abre em modal acessível:

1. indicação e escalada do suporte;
2. modos ventilatórios;
3. mecânica e gasometria;
4. fenótipos e estratégias protetoras;
5. assincronias e alarmes;
6. desmame ventilatório.

O modal possui manejo de foco e fechamento por Escape. As curvas normais e patológicas são esquemas SVG, não traçados recebidos de um ventilador.

## 2.10 Desmame

Para adulto/pediátrico não neonatal, a prontidão básica combina:

- $FiO_2 \leq 0,40$ ;
- $PEEP \leq 8$  cmH<sub>2</sub>O;
- $pH \geq 7,25$ ;
- critérios clínicos selecionados no formulário.

O resultado é um checklist, não uma ordem de extubação. Neonatos seguem contexto próprio e não usam o mesmo gatilho genérico.

## 2.11 Vinte e oito protocolos por condição

Cada protocolo tem objetivo, ajustes iniciais, ajustes subsequentes, metas, armadilhas e resgate.

### Adulto: 5

1. ARDS;
2. exacerbação de DPOC;
3. gestação;
4. TEP maciço/falência aguda de VD;
5. doença intersticial/fibrótica.

### Pediátrico: 5

1. PARDS;
2. estado de mal asmático, compartilhado com adulto;
3. bronquiolite grave;
4. pneumonia grave/atelectasia, também aplicável ao adulto;
5. cardiopatia congênita/pós-operatório, também aplicável ao neonato.

### Transversal: 10

1. doença neuromuscular;
2. neurocrítico/TCE;
3. edema cardiogênico;
4. hipertensão pulmonar/falência de VD;
5. queimaduras/lesão inalatória;
6. transplante pulmonar/imunossupressão;
7. obesidade/parede torácica;
8. fístula broncopleural/vazamento aéreo;
9. pulmão único/doença unilateral;
10. hipertensão intra-abdominal/abdome aberto.

**Neonatal: 8**

1. RDS do prematuro;
2. BPD grave;
3. aspiração de mecônio;
4. PPHN;
5. hérnia diafragmática congênita;
6. apneia da prematuridade/pós-extubação;
7. pneumonia/sepsis/NARDS;
8. hemorragia pulmonar neonatal.

**2.12 Parâmetros clínicos operacionais destacados****ARDS adulto**

- VT protetor por PBW.
- Pplat <30 cmH<sub>2</sub>O.
- Prona por ≥16 horas quando P/F <150 com PEEP ≥5, no contexto apropriado.
- Bloqueio neuromuscular e demais resgates aparecem como opções contextualizadas.

**PARDS**

- Pplat ≤28 cmH<sub>2</sub>O, com possibilidade de até 32 em parede torácica muito rígida.
- Driving pressure ≤15 cmH<sub>2</sub>O como referência contextual.
- SpO<sub>2</sub> 92-97% em quadros leves/moderados.
- Hipercapnia permissiva com pH ≥7,20, salvo contraindicações.
- Peso predito só substitui o real se PARDS estiver confirmado.

Classificação de gravidade após ≥4 h de ventilação invasiva:

- grave: OI ≥16; quando OI indisponível, OSI ≥12;
- moderado: OI 4-<16 ou OSI 5-<12.

**RDS neonatal**

- CPAP 6-8 cmH<sub>2</sub>O.
- Surfactante no >28 semanas com piora, pressão média/CPAP ≥6 e FiO<sub>2</sub> ≥0,30.
- VTV/VG com alvo de 5-7 mL/kg.
- Backup de PIP 25-30 cmH<sub>2</sub>O e frequência aproximada de 30/min, ajustados pelo quadro.
- Cafeína citrato: ataque 20 mg/kg; manutenção 5-10 mg/kg/dia.
- Prematuro: SpO<sub>2</sub> alvo 90-94%, alarmes 89-95%.

**PPHN**

- iNO 20 ppm em ≥34 semanas após recrutamento adequado.
- Avaliar resposta em 30-60 minutos.
- SpO<sub>2</sub> pré-ductal 91-95%.
- PaO<sub>2</sub> 50-80 mmHg.
- PaCO<sub>2</sub> 40-55 mmHg.
- pH ≥7,25-7,30.

**Hérnia diafragmática congênita**

- PIP <25 cmH<sub>2</sub>O.
- PEEP 3-5 cmH<sub>2</sub>O.
- FR 40-60/min.
- SpO<sub>2</sub> pré-ductal 80-95%; pós-ductal >70%.
- PaCO<sub>2</sub> permissiva 50-70 mmHg com pH >7,20.

## 2.13 Tópicos de prática avançada: 10

1. round sistemático diário;
2. capnografia e espaço morto;
3. proteção pulmonar e diafragmática;
4. umidificação, circuito e aspiração;
5. aerossóis;
6. monitorização avançada: ultrassom pulmonar, pressão esofágica, EIT e P0.1;
7. volume-alvo neonatal;
8. prevenção de eventos associados à ventilação;
9. transporte intra/inter-hospitalar;
10. situações especiais.

O conteúdo atual explicita que material de tubo/laringoscopia e sedoanalgesia não são expandidos neste site; o foco permanece ventilatório.

## 2.14 Terapias de resgate: 5 cartões

1. prona;
2. óxido nítrico inalatório;
3. HFOV/modos alternativos;
4. outras terapias - bloqueio neuromuscular, surfactante, manobras de recrutamento;
5. ECMO.

Critérios do tipo EOLIA para adulto são apresentados como referência de discussão/encaminhamento, não como indicação automática. Os cartões incluem pré-requisitos, resposta esperada, falha e risco.

## 2.15 Segurança e acessibilidade

- Parsers numéricos com limites por campo.
- FiO2 normalizada de porcentagem ou fração.
- Nenhum resultado é produzido com entradas críticas inválidas.
- Cálculos de OI/OSI condicionados ao suporte e à qualidade da SpO2.
- Auto-PEEP negativo marcado como inconsistente.
- Critérios adultos não são automaticamente aplicados a pediatria/neonatologia.
- Peso predito pediátrico restrito a PARDS confirmado.
- Modais com foco, Escape e semântica de diálogo.
- Respeito a prefers-reduced-motion.
- Teste automatizado adicional remove scripts e verifica ausência visível de NaN, Infinity e undefined.

Ainda não há checagem de conexão com ventilador, calibração do equipamento, identificação de sensor, curvas em tempo real, prontuário, prescrição ou confirmação de implementação do ajuste.

## 2.16 UX e design

O design passou por três identidades: claro/verde, escuro compacto e, por fim, preto/dourado. O estado ativo:

- fundo preto com partículas douradas fornecidas em `public/golden-background.png`;
- fonte Faustina em toda a aplicação;
- alto contraste e cartões com detalhes dourados;
- abas fixas de workspace;
- hero reduzido para liberar área clínica;
- modais de biblioteca;
- breakpoints responsivos;
- redução de movimento para acessibilidade.

Um antigo “monitor card” ainda existe no JSX/CSS, porém está oculto com `display: none`; não faz parte da UX efetiva. O CSS conserva seletores de fases antigas, o que aumenta a complexidade da cascata sem alterar a aparência final.

2.17 Fontes e referências

A interface atual cita nominalmente:

- PALICC-2, 2023;
- recomendações ATS para ARDS adulto, 2024;
- consenso europeu de RDS neonatal, 2025;
- orientação AARC para teste de respiração espontânea, 2024;
- Traub e Johnson para peso ideal pediátrico;
- estudos de S/F, NIV e p-HACOR pediátricos;
- referências do ROX em lactentes/bronquiolite.

Entretanto, a seção bibliográfica completa que existia em versões anteriores foi removida. O produto atual exibe nomes dentro do conteúdo, mas não oferece ao usuário um bloco único de links/citações verificáveis.

2.18 Histórico reconstruído e requisitos substituídos

Linha do tempo

| Data        | Evolução inferida                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 ago 2026  | estação clínica inicial; módulos, calculadoras e referências; correções de comandos e ativação dos módulos                                                                                                                               |
| 18 ago 2026 | aplicação de “Prompt Master”; revisão crítica; layout escuro; ajustes assistidos; identidade preta/dourada; fundo fornecido; expansão pediátrica; reorganização do fluxo UTI; auditorias de cálculos e navegação; fluxo guiado e desmame |
| 19 ago 2026 | biblioteca profunda; resgate; ampliação científica; aba única com 28 condições; auditoria clínica, cálculos seguros e acessibilidade                                                                                                     |
| 21 ago 2026 | correção de contraste do tópico 03 e calculadoras                                                                                                                                                                                        |

Estado antigo versus ativo

| Tema                           | Antes                                                | Agora                                                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Visual                         | claro/verde; depois escuro genérico                  | preto/dourado, fundo de partículas, Faustina                                      |
| Governança                     | seção “Prompt Master”, segurança e fontes visíveis   | essas seções foram removidas para priorizar conteúdo; vestígios de CSS permanecem |
| Monitor                        | cartão central proeminente                           | oculto por CSS                                                                    |
| Cálculos                       | parsers genéricos e maior risco de valores inválidos | limites por campo, bloqueios contextuais e ausência de resultados não finitos     |
| Teste de respiração espontânea | lógica genérica                                      | regras separadas por população e restrição neonatal                               |
| Peso pediátrico                | predito usado mais amplamente                        | menor real/predito apenas em PARDS confirmado                                     |
| ROX/p-HACOR                    | cortes mais assertivos                               | alertas de validação pediátrica e uso contextual; ROX-HR exploratório             |
| Escopo                         | conteúdo extenso misturável                          | exclusão explícita de material de via aérea e sedoanalgesia                       |

2.19 Lacunas e riscos técnicos observáveis

1. Não há bibliografia completa visível apesar das alegações de auditoria científica.
2. A resistência de vias aéreas é descrita, mas não existe input de fluxo inspiratório nem cálculo operacional completo de resistência.
3. Curvas são ilustrações; não derivam de dados do ventilador.
4. Não há persistência do caso ou comparação longitudinal.
5. Não há suporte específico a marcas/modelos de ventilador nem tradução de nomenclatura de cada equipamento.

6. O CSS contém blocos e seletores mortos de designs removidos.
7. Os testes não validam resultados clínicos de referência; cobrem renderização e ausência de valores não finitos.
8. Algumas recomendações estáticas dependem de atualização periódica; o site não busca versões novas das diretrizes.
9. A classificação ácido-base é simplificada e não calcula compensações esperadas completas.

---

## 3. Folha de parada pediátrica

### 3.1 Finalidade e escopo

Aplicação intitulada **“FOLHA DE PARADA”**, descrita como calculadora pediátrica por peso para PCR, IOT, infusões, ventilação e cuidados de sala vermelha. A entrada obrigatória é o peso; idade, identificação, alergias e peso ideal ventilatório são complementares.

O produto monta uma folha operacional com resumo rápido, via aérea/equipamentos, 55 itens clínicos, ventilação, bundles e fontes. Não armazena paciente nem gera prescrição assinada.

### 3.2 Estrutura e contagens verificáveis

| Arquivo              | Linhas | Tamanho aproximado | Função                                                                    |
|----------------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| app/page.tsx         | 419    | 19 KB              | Entrada do caso, filtros, layout e resumo                                 |
| app/clinical-data.ts | 1.181  | 72 KB              | Fórmulas, 55 itens, equipamentos, ventilação, bundles e fontes            |
| app/globals.css      | 1.742  | 28 KB              | Tema da emergência, responsividade e impressão; inclui camadas históricas |

Contagens atuais:

- 7 ocorrências de useState;
- 2 de useMemo;
- 9 categorias;
- 55 itens clínicos;
- 4 cálculos do resumo rápido;
- 11 estimativas de equipamentos;
- 4 planos ventilatórios;
- 4 bundles;
- 10 referências-base visíveis.

Distribuição dos 55 itens:

| Categoria                 | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| PCR e arritmias           | 7          |
| IOT/ISR                   | 7          |
| Drogas vasoativas         | 5          |
| Sedação/analgesia/infusão | 7          |
| Neurologia                | 9          |
| Respiratório              | 8          |
| Metabólico/toxicologia    | 6          |
| Trauma/hemorragia         | 1          |
| Antimicrobianos/seps      | 5          |

O histórico dizia “53 itens clínicos e 8 cenários”, mas esse número foi superado pela auditoria integral: procainamida e ácido tranexâmico elevaram o estado ativo para **55 itens e 9 categorias**.

### 3.3 Organização da rota /

1. hero vermelho e comando de impressão;
2. banner de segurança;
3. navegação rápida fixa para paciente, resumo, via aérea, drogas, ventilação, bundles e fontes;
4. dados do paciente;
5. resumo de ressuscitação;
6. equipamentos/via aérea;
7. busca e filtros das nove categorias;
8. tabela operacional dos 55 itens;
9. ventilação;
10. bundles;
11. tripla checagem;
12. evidências/fontes;
13. rodapé.

Sem peso válido, o conteúdo calculado permanece vazio. A faixa aceita é 0,1-200 kg.

### 3.4 Modelo matemático

#### Dose com teto/piso

$$D = p \times d_{\text{kg}}$$

Depois são aplicados, quando definidos, dose mínima e dose máxima.

#### Bolus e checagem reversa

$$V = \frac{D}{C}$$

onde  $(D)$  é dose e  $(C)$  é concentração da apresentação. O registro exhibe dose, volume e concentração para permitir checagem reversa:

$$D_{\text{recalculada}} = V \times C$$

#### Infusão contínua

$$D_{\text{absoluta}} = d_{\text{kg}} \times p$$

$$Q = \frac{D_{\text{absoluta}}}{C} \times f$$

O fator  $(f=60)$  quando a dose está expressa por minuto e a bomba em mL/h; para doses por hora,  $(f=1)$ . Essa distinção corrige o erro histórico mais perigoso identificado no arquivo Excel de origem.

### 3.5 Resumo rápido: 4 cálculos

| Ação                      | Regra ativa                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desfibrilação             | primeira 2 J/kg; segunda 4 J/kg; subsequentes $\geq 4$ J/kg até o menor entre 10 J/kg e máximo adulto |
| Cardioversão sincronizada | 0,5-1 J/kg; se necessário, 2 J/kg                                                                     |
| Cristaloide               | 10-20 mL/kg, com reavaliação                                                                          |
| Manutenção                | Holliday-Segar 100/50/20 mL/kg/dia                                                                    |

Ao contrário do site de soroterapia, a manutenção desta folha **não aplica teto de 2.400 mL/dia**; acima de 20 kg, segue linearmente 1.500 + 20 mL por kg adicional.

### 3.6 Itens de PCR e arritmias: 7

| Item                          | Dose/regra                                             | Apresentação ou preparo |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Adrenalina na PCR             | 0,01 mg/kg IV/IO; máx. 1 mg                            | 0,1 mg/mL               |
| Amiodarona em FV/TV sem pulso | 5 mg/kg; máx. 300 mg na primeira, 150 mg nas seguintes | 50 mg/mL                |

| Item                    | Dose/regra                                          | Apresentação ou preparo                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lidocaína, alternativa  | 1 mg/kg                                             | 20 mg/mL                                  |
| Atropina na bradicardia | 0,02 mg/kg; mín. 0,1 mg; máx. 0,5 mg                | 0,5 mg/mL                                 |
| Adenosina               | 0,1 mg/kg, máx. 6 mg; segunda 0,2 mg/kg, máx. 12 mg | 3 mg/mL                                   |
| Procainamida com pulso  | 15 mg/kg; máx. 1.000 mg em 30-60 min                | volume não calculado sem preparo definido |
| Cristaloide             | 10-20 mL/kg                                         | volume direto; reavaliar                  |

O bicarbonato não aparece como rotina na PCR; foi removido dessa interpretação em resposta à auditoria do material original.

### 3.7 IOT/indução em sequência rápida: 7

| Item             | Dose/regra                                                                             | Apresentação/preparo                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Atropina pré-IOT | 0,02 mg/kg, sem aplicar automaticamente a dose mínima da bradicardia                   | 0,5 mg/mL                                       |
| Fentanil         | 1-2 microgramas/kg                                                                     | 50 microgramas/mL                               |
| Cetamina         | 1-2 mg/kg                                                                              | fonte 50 mg/mL; opção de diluição para 10 mg/mL |
| Etomidato        | 0,3 mg/kg                                                                              | 2 mg/mL                                         |
| Propofol         | 1-2 mg/kg                                                                              | 10 mg/mL                                        |
| Rocurônio        | 1,2 mg/kg                                                                              | 10 mg/mL                                        |
| Succinilcolina   | 2 mg/kg em lactente/criança pequena; 1 mg/kg em criança maior/adolescente; máx. 150 mg | 20 mg/mL                                        |

Como o cálculo de drogas recebe apenas o peso, a folha apresenta as alternativas dependentes de idade, mas não seleciona automaticamente qual dose de succinilcolina usar.

### 3.8 Drogas vasoativas: 5

| Infusão       | Faixa                       | Concentração de exemplo |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| Noradrenalina | 0,05-1 micrograma/kg/min    | 40 microgramas/mL       |
| Adrenalina    | 0,05-1 micrograma/kg/min    | 10 microgramas/mL       |
| Dobutamina    | 2-20 microgramas/kg/min     | 2.500 microgramas/mL    |
| Milrinona     | 0,25-0,75 micrograma/kg/min | 200 microgramas/mL      |
| Dopamina      | 5-20 microgramas/kg/min     | 3.200 microgramas/mL    |

Para doses por minuto, o código multiplica por 60 ao converter para mL/h. As concentrações são cenários de preparo e não representam biblioteca de estoque institucional.

### 3.9 Sedação, analgesia e bloqueio contínuo: 7

| Infusão                               | Faixa                    | Concentração     |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Fentanil                              | 0,5-5 microgramas/kg/h   | 5 microgramas/mL |
| Morfina                               | 0,01-0,05 mg/kg/h        | 1 mg/mL          |
| Midazolam                             | 0,03-0,2 mg/kg/h         | 1 mg/mL          |
| Dexmedetomidina                       | 0,2-1,4 microgramas/kg/h | 4 microgramas/mL |
| Cetamina                              | 0,5-2 mg/kg/h            | 2 mg/mL          |
| Rocurônio                             | 0,3-0,6 mg/kg/h          | 1 mg/mL          |
| Midazolam no estado de mal refratário | 0,05-2 mg/kg/h           | 1 mg/mL          |

O site não implementa um escore de sedação dinâmico nem calcula acúmulo/ajuste renal-hepático; alertas permanecem textuais.

### 3.10 Neurologia: 9

| Item               | Dose/regra                                           | Apresentação               |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Midazolam em crise | IV 0,1 mg/kg, máx. 4 mg; IN/IM 0,2 mg/kg, máx. 10 mg | 5 mg/mL IV; 10 mg/mL IN/IM |
| Lorazepam          | 0,1 mg/kg; máx. 4 mg                                 | 2 mg/mL                    |

| Item           | Dose/regra                                                            | Apresentação  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Levetiracetam  | 60 mg/kg; máx. 4.500 mg                                               | 100 mg/mL     |
| Fosfenitoína   | 20 mg PE/kg; máx. 1.500 mg PE                                         | 50 mg PE/mL   |
| Fenitoína      | 20 mg/kg; máx. 1.000 mg; velocidade $\leq 1$ mg/kg/min                | 50 mg/mL      |
| Valproato      | 40 mg/kg; máx. 3.000 mg                                               | 100 mg/mL     |
| Fenobarbital   | 20 mg/kg; máx. 1.000 mg                                               | 100 mg/mL     |
| NaCl 3% na HIC | 2-5 mL/kg em 10-20 min; infusão 0,1-1 mL/kg/h apenas em UTI/protocolo | volume direto |
| Manitol        | 0,5-1 g/kg                                                            | 0,2 g/mL      |

### 3.11 Respiratório: 8

| Item                           | Dose/regra                                                                                  | Apresentação/preparo                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Adrenalina IM na anafilaxia    | 0,01 mg/kg; máx. 0,3 mg; repetir a cada 5-15 min conforme resposta                          | 1 mg/mL                                      |
| Salbutamol MDI                 | 4-10 jatos, repetidos a cada 20 min por 3 doses                                             | 100 microgramas/jato                         |
| Salbutamol nebulizado          | 0,15 mg/kg; mín. 2,5 mg; máx. 5 mg                                                          | 5 mg/mL                                      |
| Salbutamol contínuo            | <10 kg: 7,5 mg/h; 10-20 kg: 11,25 mg/h; >20 kg: 15 mg/h                                     | sem mL/h até informar concentração preparada |
| Ipratrópio                     | <20 kg: 250 microgramas/1 mL; $\geq 20$ kg: 500 microgramas/2 mL; a cada 20 min por 3 doses | solução conforme volumes declarados          |
| Magnésio na asma               | 50 mg/kg; máx. 2 g, em cerca de 20 min                                                      | 500 mg/mL                                    |
| Dexametasona no crupe          | 0,6 mg/kg; máx. 10 mg                                                                       | 4 mg/mL                                      |
| Adrenalina nebulizada no crupe | 0,5 mL/kg; máx. 5 mL                                                                        | 1 mg/mL                                      |

### 3.12 Metabólico e toxicologia: 6

| Item                    | Dose/regra                                                          | Apresentação/preparo               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| SG 10% na hipoglicemia  | 2 mL/kg                                                             | 100 mg/mL de glicose               |
| Gluconato de cálcio 10% | 0,6-1 mL/kg, equivalente a 60-100 mg/kg do sal; máx. 30 mL          | solução 10%                        |
| Bicarbonato             | 1 mEq/kg quando especificamente indicado                            | 8,4% = 1 mEq/mL; 4,2% = 0,5 mEq/mL |
| Naloxona                | 0,1 mg/kg; máx. 2 mg                                                | 0,4 mg/mL                          |
| Emulsão lipídica 20%    | bolus 1,5 mL/kg; depois 0,25 mL/kg/min; teto de referência 12 mL/kg | volume direto                      |
| Insulina regular na CAD | 0,05-0,1 U/kg/h, sem bolus                                          | preparo 1 U/mL                     |

### 3.13 Trauma e hemorragia: 1

| Item              | Dose/regra                                             | Apresentação/preparo                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ácido tranexâmico | 15 mg/kg, máx. 1 g em 10 min; depois 2 mg/kg/h por 8 h | bolus com 100 mg/mL; infusão com 10 mg/mL |

### 3.14 Antimicrobianos e sepse: 5

| Item                      | Dose/regra                                                         | Observação operacional                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ceftriaxona               | 50 mg/kg, máx. 2 g em sepse; 100 mg/kg, máx. 4 g em meningite      | volume não calculado sem reconstituição; alerta etário    |
| Cefepime                  | 50 mg/kg/dose a cada 8 h; máx. 2 g                                 | depende de preparo local                                  |
| Meropenem                 | $\geq 3$ meses: 40 mg/kg a cada 8 h; máx. 2 g, em 15-30 min        | idade é alerta textual, não bloqueio automático           |
| Vancomicina               | dose inicial 15 mg/kg, infusão $\geq 60$ min                       | monitorização e ajuste por função/nível não automatizados |
| Tempo para antimicrobiano | choque: objetivo $\leq 1$ h; sepse provável sem choque: $\leq 3$ h | marcador operacional, sem cálculo de volume               |

### 3.15 Equipamentos e via aérea: 11 estimativas

As saídas são estimativas por peso/idade e sempre pedem confirmação anatômica, por imagem, ausculta, capnografia ou ultrassom conforme o item.

1. tubo endotraqueal com cuff por faixas de peso;
2. tubo com cuff por idade: idade/4 + 3,5 em  $\geq 1$  ano;
3. tubo sem cuff: diâmetro com cuff +0,5 ou idade/4 +4;
4. profundidade oral: idade/2 +12 ou diâmetro com cuff  $\times 3$ ;
5. lâmina de laringoscópio por idade/peso;
6. cateter de aspiração;
7. dispositivo supraglótico, incluindo faixa de tamanho 5 após a revisão integral;
8. acesso venoso periférico;
9. cateter venoso central;
10. dreno torácico;
11. sonda urinária e parâmetros de descompressão quando aplicável.

### Tabelas de equipamento codificadas

| Peso         | Tubo com cuff por peso |
|--------------|------------------------|
| <2 kg        | 2,5 mm                 |
| 2-<4 kg      | 3,0 mm                 |
| 4-<8 kg      | 3,5 mm                 |
| 8-<15 kg     | 4,0 mm                 |
| 15-<20 kg    | 4,5 mm                 |
| 20-<30 kg    | 5,0 mm                 |
| 30-<40 kg    | 5,5 mm                 |
| 40-<50 kg    | 6,0 mm                 |
| 50-<60 kg    | 6,5 mm                 |
| 60-<75 kg    | 7,0 mm                 |
| $\geq 75$ kg | 7,5 mm                 |

Em  $\geq 1$  ano, a fórmula etária do tubo com cuff substitui a faixa de peso e é limitada a 8,0 mm. A folha recomenda ter disponível um tubo 0,5 mm menor e outro 0,5 mm maior.

| Dispositivo       | Faixas de peso e tamanho                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lâmina            | <1,5 kg: 00-0 reta; 1,5-<4: 0 reta; 4-<10: 1 reta; 10-<25: 2 reta/curva; $\geq 25$ : 2-3 curva         |
| Aspiração         | <5 kg: 6-8 Fr; 5-<15: 8-10 Fr; 15-<30: 10-12 Fr; $\geq 30$ : 12-14 Fr                                  |
| Supraglótico      | <5 kg: nº 1; 5-<10: nº 1,5; 10-<20: nº 2; 20-<30: nº 2,5; 30-<50: nº 3; 50-<70: nº 4; $\geq 70$ : nº 5 |
| Acesso periférico | <5 kg: 24-22 G; 5-<15: 22-20 G; 15-<30: 20-18 G; $\geq 30$ : 18-16 G                                   |
| CVC               | <5 kg: 3 Fr/22 G; 5-<15: 4 Fr/20-22 G; 15-<30: 5 Fr/18-20 G; $\geq 30$ : 6 Fr/16-18 G                  |
| Dreno torácico    | <5 kg: 8-12 Fr; 5-<10: 10-16 Fr; 10-<20: 16-20 Fr; 20-<40: 20-28 Fr; $\geq 40$ : 28-32 Fr              |
| Descompressão     | <10 kg: 18-20 G; 10-<25: 16-18 G; $\geq 25$ : 14-16 G                                                  |
| Sonda vesical     | <5 kg: 6 Fr; 5-<15: 8 Fr; 15-<30: 10 Fr; 30-<50: 12 Fr; $\geq 50$ : 14 Fr                              |

O site não escolhe dispositivo com base em fabricante. O peso ideal ventilatório é um campo separado e só influencia os planos de ventilação, não as doses farmacológicas.

### 3.16 Planos ventilatórios: 4

| Cenário                     | Parâmetros ativos                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulmão sem lesão específica | VT 6-8 mL/kg de peso ideal; PEEP 5; FiO2 inicialmente 1,0 e titulação rápida                  |
| PARDS                       | VT 4-6 mL/kg; Pplat $\leq 28$ , aceitando até 32 em parede rígida; driving pressure $\leq 15$ |
| Asma grave                  | VT 6-8 mL/kg; I:E 1:3 a 1:5; alto fluxo e baixa FR para expiração                             |
| TCE                         | VT 6-8 mL/kg; PaCO2 35-40 mmHg; SpO2 94-99%                                                   |

O código distingue peso real, usado nas doses, de peso ideal ventilatório, usado quando preenchido. Um cartão rápido duplicado de VT foi removido em revisão para evitar duas fontes concorrentes.

### 3.17 Bundles: 4

#### PCR

- reconhecimento, compressões, ventilação e ritmo;
- energia/droga pelo peso;
- causas reversíveis;
- reavaliação a cada ciclo;
- cuidado pós-ROSC.

#### IOT

- preparação de equipe/equipamento;
- pré-oxigenação;
- escolha de indução e bloqueador;
- confirmação com capnografia;
- plano de falha e ventilação pós-IOT.

#### Sepse

- reconhecimento e acesso;
- coleta sem atrasar antimicrobiano;
- cristalóide em alíquotas com reavaliação;
- vasoativo precoce se choque refratário;
- antibiótico dentro do marco temporal;
- uso contextual do Phoenix Sepsis Score.

#### Pós-ROSC

- oxigenação e ventilação alvo;
- hemodinâmica;
- temperatura, glicose e convulsões;
- busca da causa;
- transporte/UTI.

### 3.18 Segurança ativa

- A aplicação só calcula com peso válido de 0,1-200 kg.
- Dose, teto, concentração e volume são apresentados juntos para checagem reversa.
- Unidades por minuto são convertidas corretamente para mL/h.
- Atropina pré-IOT foi separada da atropina para bradicardia, evitando uso indevido do mínimo de 0,1 mg.
- Rocurônio foi corrigido para apresentação de 10 mg/mL no bolus de ISR.
- Etomidato e propofol tiveram valores revistos.
- Bicarbonato não é sugerido rotineiramente na PCR.
- Hipoglicemia usa SG 10%, não concentração inadequada do arquivo original.
- Antimicrobianos sem concentração/reconstituição definida não recebem um volume inventado.
- Alertas de idade, função renal/hepática, monitorização e protocolo permanecem visíveis no item.
- A seção final solicita tripla checagem matemática, farmacêutica e clínica.

As funções calculate dos itens recebem somente o peso. Idade, alergias, função renal/hepática e exames não são parâmetros de bloqueio automático.

### 3.19 UX, busca, impressão e estado

- Cabeçalho vermelho de emergência, cartões brancos/verdes e tipografia grande do sistema.

- Navegação fixa para saltar entre áreas críticas.
- Busca textual por nome, contexto, indicação e tags.
- Filtro por nove categorias.
- Identificação e alergias são campos não controlados, apenas para impressão/consulta local.
- Breakpoints principais em aproximadamente 1.080 e 720 px.
- CSS de impressão retira navegação e comandos, ajustando a folha para papel.
- Não há autosave, histórico, biblioteca de pacientes ou compartilhamento.

O CSS contém blocos antigos e um grande override final intitulado como workspace profissional de emergência. A cascata final é a fonte efetiva do visual, mas a duplicação dificulta manutenção.

### 3.20 Fontes e referências

Dez referências-base aparecem na interface:

1. AHA/AAP PALS 2025;
2. Surviving Sepsis Campaign pediátrica 2026;
3. PANDEM 2022;
4. PALICC-2/PARDS 2023;
5. Brain Trauma Foundation pediátrica;
6. Children's Hospital of Philadelphia - estado de mal epiléptico;
7. Children's Hospital of Philadelphia - via de asma;
8. ISPAD - cetoacidose diabética, 2022;
9. American College of Medical Toxicology - emulsão lipídica;
10. Starship - ácido tranexâmico.

Itens específicos também apontam para materiais como Starship para sepse, CHOP para desidratação, SES-DF para anafilaxia e rótulos públicos de medicamentos. As referências são estáticas: a aplicação não verifica automaticamente se houve atualização, mudança de URL ou nova edição.

### 3.21 Histórico reconstruído e requisitos substituídos

| Data        | Evolução inferida                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 ago 2026 | primeira versão com cálculo por peso, PCR, IOT, vasoativos, via aérea e auditoria do Excel; depois declarada "final" com 53 itens e 8 cenários                                |
| 19 ago 2026 | ocultação da seção de auditoria do arquivo; auditoria clínica integral, inclusão de procainamida e ácido tranexâmico, correções de doses/apresentações, equipamento e Phoenix |
| 21 ago 2026 | refinamento de layout e legibilidade                                                                                                                                          |

### Estado antigo versus ativo

| Tema                     | Antes                                    | Agora                                                             |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Contagem                 | 53 itens, 8 cenários                     | 55 itens, 9 categorias                                            |
| Auditoria do Excel       | seis riscos e anexo visíveis             | seção ocultada; correções preservadas no conteúdo                 |
| Infusão de fentanil      | risco de confusão hora/minuto            | conversão explícita e correta por unidade                         |
| Rocurônio                | risco de concentração 1 versus 10 mg/mL  | bolus de ISR usa 10 mg/mL; infusão usa preparo próprio de 1 mg/mL |
| Atropina                 | regras misturadas                        | bradicardia e pré-IOT separadas                                   |
| Bicarbonato              | interpretação ampla                      | não rotineiro na PCR; apenas indicação específica                 |
| Hipoglicemia             | solução inadequada no material de origem | SG 10% 2 mL/kg                                                    |
| VT rápido                | cartão duplicava a seção de ventilação   | removido; peso ideal centralizado                                 |
| Dispositivo supraglótico | faixas incompletas                       | tamanho 5 incluído                                                |
| Visual                   | folha densa inicial                      | workspace de emergência com navegação fixa e melhor leitura       |

### 3.22 Lacunas e riscos técnicos observáveis

1. Idade é coletada, mas não é passada às funções farmacológicas. Alertas de ceftriaxona, meropenem e succinilcolina não se tornam bloqueios ou seleção automática.
2. Alergias são texto livre e não filtram antimicrobianos ou demais medicamentos.
3. Função renal/hepática e exames não são inputs estruturados; ajustes permanecem textuais.
4. A manutenção em peso alto não tem teto, diferindo deliberadamente do outro site.
5. Concentrações de infusão são exemplos fixos, não um cadastro de farmácia institucional.
6. Não há persistência, assinatura, identificação do calculador ou trilha de auditoria do caso.
7. O CSS duplicado depende da ordem da cascata e eleva o risco de regressão visual.
8. O teste automatizado é apenas de renderização; faltam regressões numéricas para os 55 itens, tetos, mínimos, faixas de peso e conversão minuto->hora.
9. Links e recomendações de 2025/2026 não são revalidados em tempo de execução.

---

## 4. Metadados, privacidade, persistência e implantação

### 4.1 Metadados visíveis

| Projeto     | Título                 | Descrição                                                                                   | Idioma | Fonte principal         |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| Soroterapia | Soroterapia Pediátrica | Calculadora auditável de manutenção hídrica, TIG e composição para pediatria e neonatologia | pt-BR  | Geist/Geist Mono        |
| Ventilação  | Ventilação Mecânica    | Assistente clínico especializado em ventilação mecânica adulta, pediátrica e neonatal       | pt-BR  | Faustina                |
| Folha       | FOLHA DE PARADA        | Calculadora pediátrica por peso para PCR, IOT, infusões e cuidados de sala vermelha         | pt-BR  | Arial/fontes do sistema |

### 4.2 Persistência e dados

| Recurso                | Soroterapia             | Ventilação     | Folha          |
|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Banco D1               | não                     | não            | não            |
| Objeto R2              | não                     | não            | não            |
| localStorage           | não                     | não            | não            |
| API clínica            | não                     | não            | não            |
| Login ativo            | não                     | não            | não            |
| Analytics              | não encontrado          | não encontrado | não encontrado |
| Exportação estruturada | somente cópia de resumo | não            | impressão      |
| Estado após reload     | perdido                 | perdido        | perdido        |

### 4.3 Testes existentes

- Todos: renderizam /, esperam HTTP 200 e metadado de desenvolvimento.
- Ventilação: além disso, remove scripts do HTML e verifica que não há texto visível NaN, Infinity ou undefined.
- Nenhum: possui testes clínicos de golden master, propriedades matemáticas, casos de borda, snapshots de prescrição, testes de acessibilidade completos ou validação visual automatizada para impressão.

### 4.4 Segurança de aplicação

A ausência de persistência reduz exposição no servidor, mas não equivale a programa de segurança. Os valores ficam na memória do navegador durante a sessão e podem aparecer em impressão ou área de transferência. Não foram encontradas chamadas de exfiltração próprias nas páginas auditadas. A aplicação ainda depende da segurança do ambiente de hospedagem e do dispositivo do usuário.

## 5. Conclusões e lacunas de recuperação

### 5.1 O que foi recuperado com alta confiança

- estado integral do código atual;
- rotas, componentes, arquivos e configurações;
- fórmulas e limites codificados;
- tabelas de apresentação e concentrações;
- conteúdo dos protocolos e módulos;
- regras de segurança implementadas;
- interface, design responsivo e impressão;
- dependências e ausência de persistência;
- sequência cronológica das revisões;
- diferenças entre requisitos antigos e regras ativas.

### 5.2 O que não pode ser recuperado integralmente

1. **Prompts literais:** o Git contém assuntos curtos, não os textos completos dos prompts. A reconstrução é comportamental.
2. **Configuração editorial fora do repositório:** nome/avatar/instruções externas de um GPT, conversas de criação, campos da interface do construtor e permissões não estão nos checkouts.
3. **Materiais originais não versionados:** quando um commit menciona Excel, Prompt Master, tratado ou fundo fornecido, apenas o resultado incorporado ao projeto e os ativos presentes podem ser auditados.
4. **Validação clínica independente:** não foi feita revisão sistemática contemporânea de cada dose/diretriz; registrou-se exatamente o que o código executa.
5. **Estado de produção:** a análise é do checkout local; não confirma que o deployment público aponta para a mesma revisão.
6. **Telemetria/uso real:** não existe no repositório e não foi acessada.

### 5.3 Prioridades recomendadas antes de uma exportação clínica oficial

1. salvar uma versão humana das instruções mestres e um changelog clínico dentro de cada repositório;
2. tornar as fontes visíveis e versionadas;
3. criar testes de regressão numérica para cada fórmula e apresentação;
4. documentar de forma inequívoca quais concentrações são exemplos versus padrão institucional;
5. resolver campos inertes e atalhos quebrados;
6. acrescentar controle de versão do conteúdo clínico e data de revisão na interface;
7. separar regras dependentes de idade, função renal/hepática e acesso em validações estruturadas;
8. reduzir CSS morto e consolidar a camada visual ativa;
9. confirmar em produção a revisão implantada antes de chamar o documento de exportação oficial.

## Solicitação posterior ao snapshot

### Pendente de confirmação de publicação

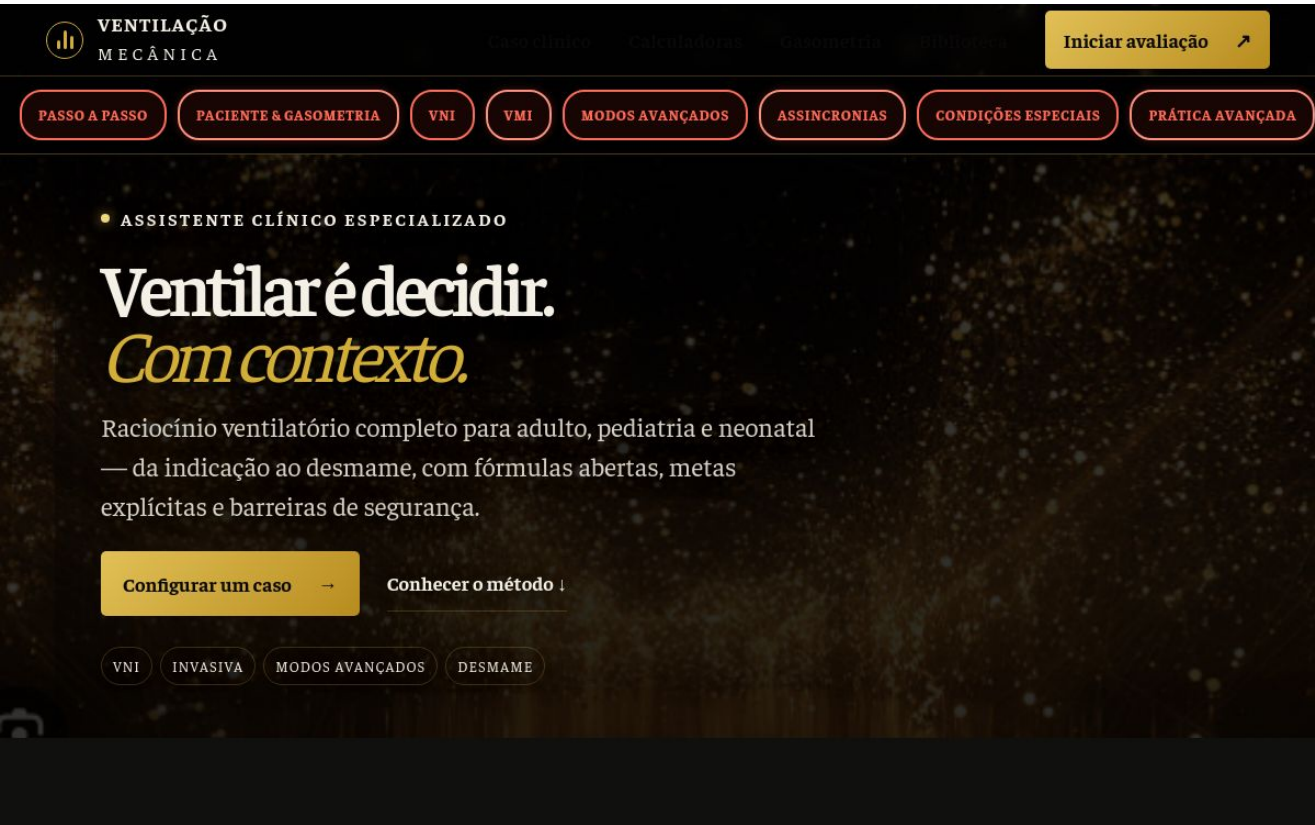
Em 22/08/2026 às 15:49 BRT foi recuperada a solicitação: alterar a ordem das tabelas para iniciar por dados do paciente e cálculo de vazão; na segunda tabela, adicionar sódio, potássio, cálcio e glicose para calcular a oferta em mEq/kg/dia de cada componente. O commit atual é anterior a essa mensagem; portanto, a regra é registrada aqui como pendente, não como configuração ativa confirmada.

## Histórico cronológico de versões

| Data/hora registrada      | Commit  | Descrição da versão                                                          |
|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-11T13:17:30-04:00 | 45600ba | Calculadora hídrica e neonatal inicial                                       |
| 2026-08-11T13:25:58-04:00 | d706c3c | Completa plataforma de soroterapia pediátrica                                |
| 2026-08-11T13:36:16-04:00 | 6f09617 | Adiciona faixas clinicas minimas e maximas por contexto                      |
| 2026-08-11T13:47:24-04:00 | 476dd52 | Adiciona sugestoes e conversoes por apresentacao em mL                       |
| 2026-08-11T13:48:36-04:00 | 5fe3591 | Esclarece recálculo sequencial das sugestões                                 |
| 2026-08-11T14:26:11-04:00 | 40efdcc | Integra plano e recomendações em todas as tabelas                            |
| 2026-08-11T14:36:29-04:00 | cc5de2e | Adiciona referência prática de eletrólitos e glicose                         |
| 2026-08-11T14:38:48-04:00 | 62fc611 | Integra criticamente o tratado mestre de fluidoterapia                       |
| 2026-08-11T16:53:57-04:00 | f5d16e5 | Aplicar paleta monocromática em escala de cinza                              |
| 2026-08-21T09:44:35+09:00 | efdcd60 | Adicionar fracionamento 24h 12h 8h e segurança de acesso                     |
| 2026-08-21T09:53:51+09:00 | 9fa96b4 | Ampliar atalhos por faixa e conversoes praticas                              |
| 2026-08-21T10:22:59+09:00 | 29cd20c | Aumentar tipografia global em cinco pontos                                   |
| 2026-08-21T10:29:27+09:00 | a84b6ae | Antecipar calculo de manutencao em 24 horas                                  |
| 2026-08-21T10:38:32+09:00 | fc75943 | Organiza volumes diarios por apresentacao                                    |
| 2026-08-21T10:41:00+09:00 | 4c6e999 | Amplia largura util do site                                                  |
| 2026-08-21T10:42:56+09:00 | 0a91125 | Ocultar auditoria e referencias externas                                     |
| 2026-08-21T10:48:12+09:00 | bc4c2e1 | Cria seletor expansivel de apresentacoes                                     |
| 2026-08-21T10:55:29+09:00 | 1957fe1 | Consolida albumina expansao e protocolos especiais                           |
| 2026-08-21T10:59:42+09:00 | 36d8422 | Integra modificadores clinicos de fluidos                                    |
| 2026-08-21T11:06:06+09:00 | 10d3635 | Detalha potassio e protocolos com volumes diretos                            |
| 2026-08-21T11:16:48+09:00 | 1f7b589 | Adiciona correção hidroeletrólítica guiada e remove barreiras antes da bolsa |
| 2026-08-21T23:14:50+03:00 | eb7ee3c | Adicionar protocolo de cálcio para prematuros em NPT                         |
| 2026-08-21T23:24:52+03:00 | 0834705 | Adicionar cálcio periférico sem NPT                                          |
| 2026-08-21T23:26:26+03:00 | 07ff78f | Assumir protocolo sem NPT para prematuros                                    |
| 2026-08-21T23:29:34+03:00 | 679cc25 | Calcular preparo periférico de gluconato                                     |
| 2026-08-21T23:30:49+03:00 | e96372b | Adicionar volume clicável de gluconato                                       |
| 2026-08-21T23:33:59+03:00 | 6e3171a | Compactar layout sem remover conteúdo                                        |
| 2026-08-21T23:41:06+03:00 | 273d9d7 | Resumir cálculo periférico de cálcio                                         |
| 2026-08-22T00:08:19+03:00 | d2d3da3 | Revisão tripla de cálculos e segurança clínica                               |

## 6. Ventilação Mecânica

| Campo                        | Valor                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Título                       | Ventilação Mecânica                                                                                                       |
| Slug                         | ventilacao-mecanica                                                                                                       |
| URL de produção              | <a href="https://ventilacao-mecanica.iagovalmeida.chatgpt.site">https://ventilacao-mecanica.iagovalmeida.chatgpt.site</a> |
| Criado                       | 07/08/2026                                                                                                                |
| Última atualização publicada | 20/08/2026 16:47 BRT                                                                                                      |
| Versão atual                 | 17                                                                                                                        |
| Commit                       | 4c21cb85fa16e9a91da868f7ba4d6220f6a4c676                                                                                  |
| Acesso                       | Custom; proprietário único; sem visitantes externos                                                                       |
| Ambiente                     | 0 variáveis de produção; 0 domínios personalizados                                                                        |



Captura oficial da versão 17 recuperada em 22/08/2026.

### Prompt mestre portátil reconstruído

### Prompt mestre portátil - Ventilação Mecânica

Crie uma estação clínica de ventilação mecânica para adulto, pediatria e neonatologia, voltada a médicos de emergência e terapia intensiva. O fluxo deve ir da indicação ao desmame, com fórmulas abertas, metas explícitas, barreiras de segurança e recomendações contextualizadas.

#### Fluxo e módulos

- Disponibilize Passo a passo, Paciente & gasometria, VNI, VMI, Modos avançados, Assincronias, Condições especiais, Prática avançada e Desmame.
- Entradas: faixa etária, sexo/altura quando aplicável, peso medido, peso predito/ideal quando necessário, doença de base, objetivo ventilatório e gasometria completa.
- Quando houver altura real, calcule peso predito e evite usar peso medido para volume corrente em situações que exijam PBW; explique a base do cálculo.
- Sugira parâmetros iniciais por contexto, incluindo modo, volume corrente ou pressão, FR, PEEP, FiO2, tempo inspiratório, fluxo, trigger/sensibilidade e alarmes.

- Permita VNI/CPAP, ventilação invasiva, modos convencionais e avançados; diferencie neonatal, pediátrico e adulto.

Raciocínio e segurança

- Relacione gasometria, mecânica, curvas e assincronias com ajustes objetivos; mostre o que mudar, direção da mudança, alvo e prazo de reavaliação.
- Inclua 28 condições especiais contextualizadas, terapias de resgate, prona, óxido nítrico e alternativas/off-label com critérios e monitorização.
- Inclua calculadoras e tópicos de prática avançada, sem ocultar fórmulas ou arredondamentos.
- Incluir avaliação de prontidão, teste de respiração espontânea/extubação, prevenção de falha e desmame.
- Nunca trate valores iniciais como prescrição universal. Destacar risco de volutrauma, barotrauma, auto-PEEP, hiperóxia/hipóxia, instabilidade hemodinâmica e necessidade de reavaliação clínica.

Design

- Identidade preta e dourada, fonte editorial, fundo de partículas douradas, alto contraste e navegação superior destacada em vermelho para os módulos clínicos.
- Interface compacta e responsiva, com primeiro viewport orientado à configuração do caso, não a texto introdutório longo.

Auditoria da configuração ativa

A auditoria forense completa dos três projetos correlatos está transcrita no capítulo de Soroterapia e discriminada por título. Para este Site, o prompt portátil, metadados, changelog e manifesto abaixo refletem a versão atual; consulte no relatório conjunto a subseção iniciada por “Ventilação”.

Histórico cronológico de versões

| Data/hora registrada      | Commit  | Descrição da versão                                                               |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-08T09:18:00+09:00 | 88bee1f | Cria estação clínica e painel de avaliação inicial                                |
| 2026-08-08T09:21:47+09:00 | 7df54b5 | Completa módulos, calculadoras e referências clínicas                             |
| 2026-08-08T09:33:06+09:00 | 35cd9e8 | Corrige comandos e ativa módulos clínicos                                         |
| 2026-08-18T10:31:19+07:00 | ae64104 | Aplicar Prompt Master com revisão crítica                                         |
| 2026-08-18T20:12:22+08:00 | 393998c | Compact dark layout and assisted ventilator settings                              |
| 2026-08-18T20:18:26+08:00 | a435e3a | Apply black and gold visual identity                                              |
| 2026-08-18T20:21:26+08:00 | 50dbddc | Apply supplied golden particle background                                         |
| 2026-08-18T22:04:59+08:00 | a6c4c13 | Expand pediatric intensivist ventilation toolkit                                  |
| 2026-08-18T22:35:57+08:00 | 7568e3e | Reorganize ICU workflow with gasometry scores and curves                          |
| 2026-08-18T23:00:57+08:00 | efae529 | Audit and correct pediatric ventilation calculations                              |
| 2026-08-18T23:10:36+08:00 | ed0b6f4 | Second full audit and navigation corrections                                      |
| 2026-08-18T23:47:43+08:00 | 2c4d51e | Amplia fluxo guiado e desmame ventilatorio                                        |
| 2026-08-19T00:06:19+08:00 | af5baf0 | Aprofunda biblioteca e adiciona terapias de resgate                               |
| 2026-08-19T00:13:06+08:00 | bae9964 | Amplia auditoria cientifica e pratica ventilatoria                                |
| 2026-08-19T00:58:10+08:00 | 503aad7 | Adiciona aba unica de condicoes especiais com 28 protocolos e alertas contextuais |
| 2026-08-19T02:11:18+08:00 | 319c436 | Auditoria clinica, calculos seguros e acessibilidade                              |
| 2026-08-21T04:46:42+09:00 | 4c21cb8 | Corrige contraste do tópico 03 e calculadoras                                     |

## 7. FOLHA DE PARADA

| Campo                        | Valor                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Título                       | FOLHA DE PARADA                                     |
| Slug                         | folha-de-parada                                     |
| URL de produção              | https://folha-de-parada.iagovalmeida.chatgpt.site   |
| Criado                       | 16/08/2026                                          |
| Última atualização publicada | 20/08/2026 16:09 BRT                                |
| Versão atual                 | 5                                                   |
| Commit                       | 4b18327c24fec3ff32dd2e92f141641e459bcd51            |
| Acesso                       | Custom; proprietário único; sem visitantes externos |
| Ambiente                     | 0 variáveis de produção; 0 domínios personalizados  |

SALA VERMELHA PEDIÁTRICA • APOIO À DECISÃO

FOLHA DE PARADA

Cálculo por peso, diluição explícita e checagem reversa.

Revisão clínica • 18/08/2026

Imprimir folha

Ferramenta de dupla checagem — não prescrição autônoma.

Confirme indicação, apresentação disponível, alergias, função renal/hepática, acesso, compatibilidade e protocolo local antes de administrar.

ACESSO RÁPIDO

Paciente

Resumo

Via aérea

Medicações

Ventilação

Bundles

Fontes

DADOS PARA CÁLCULO

PESO ATUAL \*

ex.: 12kg

Obrigatório • usar peso medido sempre que possível

IDADE opcional

ex.: 2anc

Refina estimativas de via aérea; não altera doses por kg

IDENTIFICAÇÃO opcional

iniciais / leito

Dados não são armazenados

PESO IDEAL VENTILATÓRIO opcional

se disponívelkg

Usado apenas nos cálculos de volume corrente

ALERGIAS / ALERTAS opcional

registrar antes de imprii

Ex.: anafilaxia, doença renal, canalopatia

Captura oficial da versão 5 recuperada em 22/08/2026.

### Prompt mestre portátil reconstruído

### Prompt mestre portátil - Folha de Parada

Crie uma folha de emergência pediátrica imprimível e calculável por peso para uso em sala vermelha/CTI, com PCR, via aérea/IOT, medicamentos, vasoativos, ventilação, bundles, equipamentos e fontes. O produto é ferramenta de dupla checagem e nunca prescrição autônoma.

#### Entradas e saída

- Peso atual obrigatório; idade, identificação/leito, peso ideal ventilatório e alergias/alertas opcionais.
- Para cada item, mostrar apresentação, dose de referência, dose total, volume a aspirar, diluição, volume final, concentração final, via, velocidade ou tempo, máximos e checagem reversa quando aplicável.
- Para infusões, preservar mcg/kg/min, mcg/kg/h, mg/kg/h, U/kg/h ou outra unidade original e calcular mL/h independentemente.
- Organizar acesso rápido, dados do paciente, resumo, via aérea, medicações, ventilação, bundles e fontes; disponibilizar impressão limpa.

Conteúdo clínico

- Cobrir drogas de PCR, antiarrítmicos, sedoanalgesia, bloqueio neuromuscular, antídotos/correções, drogas vasoativas, antibióticos de emergência, fluidos/hemoderivados, crises específicas, via aérea, equipamentos por idade/peso e parâmetros ventilatórios.
- Incluir cenários/bundles com ações tempo-dependentes e separar recomendações de cálculo.
- Calcular equipamentos e volumes por faixas sem transformar estimativa de idade em substituto do peso informado.

Segurança

- Tripla checagem de dose, apresentação e indicação, seguida de checagem reversa.
- Destacar drogas de alta vigilância e dupla checagem humana de peso, unidade, concentração, via, acesso e bomba.
- Não presumir alergias, função renal/hepática ou compatibilidades. Não inventar estabilidade nem protocolo local.
- Identidade visual atual em vermelho profundo, branco e cinza; alto contraste, cartões densos e impressão profissional.

Auditoria da configuração ativa

A auditoria forense completa dos três projetos correlatos está transcrita no capítulo de Soroterapia e discriminada por título. Para este Site, o prompt portátil, metadados, changelog e manifesto abaixo refletem a versão atual; consulte no relatório conjunto a subseção iniciada por “Folha”.

Histórico cronológico de versões

| Data/hora registrada      | Commit  | Descrição da versão                                                                                            |
|---------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-08-16T20:15:56-04:00 | 8956638 | Primeira versão navegável: cálculo por peso, PCR, IOT, vasoativos, via aérea e auditoria do Excel              |
| 2026-08-16T20:29:35-04:00 | f893d1c | Versão final: 53 itens clínicos, 8 cenários, ventilação, equipamentos, diluições, auditoria e checagem reversa |
| 2026-08-19T01:42:26+08:00 | fce6470 | Oculto seção de auditoria do arquivo anexado                                                                   |
| 2026-08-19T01:54:35+08:00 | 560b865 | Auditoria clínica integral e atualização das emergências pediátricas                                           |
| 2026-08-21T04:08:39+09:00 | 4b18327 | Aprimora layout e legibilidade clínica                                                                         |

## 8. Arquitetura e configuração técnica comum

Os cinco projetos compartilham a mesma base de execução e permanecem em repositórios Git independentes, cada um vinculado ao seu Site.

| Camada            | Configuração verificada                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend          | React 19.2.6 + Next 16.2.6, TypeScript 5.9.3                                                                    |
| Build/hosting     | Vinext 0.0.50 + Vite 8.0.13 + Cloudflare Worker ESM                                                             |
| Persistência      | Drizzle ORM 0.45.2 disponível; schemas clínicos atuais sem uso de banco persistente relevante                   |
| Qualidade         | Build validado, testes de HTML renderizado; Prescrição e Medicamentos têm auditorias/testes clínicos adicionais |
| Autenticação      | Helpers de Sign in with ChatGPT presentes; controle efetivo de audiência realizado pela política do Site        |
| Acesso atual      | Custom, proprietário único, sem visitantes externos; convite externo desabilitado                               |
| Domínios/ambiente | Nenhum domínio personalizado e nenhuma variável de ambiente de produção                                         |

### 8.1 Regras de restauração

- Use o slug, o commit e o hash do arquivo de versão para confirmar que o snapshot restaurado é o correto.
- Não trate os prompts portáteis como substitutos dos datasets; eles descrevem a lógica e a experiência, enquanto os arquivos rastreados contêm o catálogo e os textos clínicos.
- Preserve package-lock.json, a arquitetura Vinext, o manifesto de hospedagem e os nomes de bindings.
- Não transportar credenciais ou tokens de uma execução para outra; reemitir autenticação pela plataforma.
- Após restaurar, executar build e testes do próprio projeto antes de qualquer nova publicação.

## 9. Transcrição dos documentos-base de prompt

Os anexos abaixo são transcritos em versão normalizada para leitura e migração. Foram removidos apenas artefatos de extração como marcadores span/cite e quebras indevidas; o conteúdo instrucional foi preservado. Repetições entre arquivos permanecem quando fazem parte do documento original.

## 9.1 Regras consolidadas

Finalidade: Padronizar receituários pediátricos domiciliares, com linguagem clara, cálculo auditável, tripla checagem e prioridade para segurança e evidência científica.

### 1. Princípios hierárquicos

1. Segurança clínica e individualização prevalecem sobre qualquer regra de formato ou preferência.

2. Não presumir diagnóstico, gravidade, alergias, comorbidades, função renal/hepática, gestação, uso concomitante ou outros dados não informados.

3. Se faltar dado capaz de mudar a segurança da prescrição, solicitar apenas o indispensável; quando possível, oferecer fórmula parametrizada sem inventar valores.

4. Não prescrever por rotina medicamentos sem benefício esperado. Distinguir claramente uso obrigatório, opcional/“se necessário” e off-label.

5. Nunca inventar apresentação, concentração, número de gotas por mL, estabilidade, compatibilidade, dose ou referência.

Regra de conflito: Se uma instrução deste arquivo divergir de bula oficial, protocolo atualizado, contraindicação, idade mínima ou julgamento clínico, prevalece a alternativa mais segura e baseada em evidências; a divergência deve ser sinalizada.

### 2. Fontes e atualização

Priorizar, conforme pertinência e atualidade:

6. Protocolos municipais da Região Metropolitana de Belo Horizonte (BH, Betim, Contagem e demais municípios);

7. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG);

8. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP);

9. Ministério da Saúde;

10. ANVISA e bulas oficiais;

11. Demais sociedades médicas brasileiras;

12. Diretrizes internacionais e literatura primária, quando inexistir recomendação nacional ou quando forem mais atuais e robustas.

Em situações de alto risco, verificar fontes atuais e independentes. Se houver divergência, informar resumidamente fonte, data, população e motivo da escolha. Priorizar guidelines, consensos recentes, revisões sistemáticas, metanálises e estudos de melhor qualidade metodológica.

### 3. Dados mínimos antes de prescrever

- Diagnóstico/indicação e objetivo terapêutico;
- peso atual em kg e idade;
- alergias e reações prévias serão ditas, se houver;
- comorbidades relevantes e medicamentos em uso serão ditos, se houver
- função renal/hepática quando puder alterar dose ou segurança, serão ditos se houver injúria renal;
- via pretendida, apresentação disponível e capacidade de administração domiciliar.

### 4. Tripla checagem obrigatória

#### 4.1 Conferência matemática

□ Calcular em mg/kg/dose, mg/kg/dia ou outra unidade clínica correta; demonstrar fórmula, dose ponderal, dose total e arredondamento.

#### 4.2 Conferência farmacêutica

☐ Confirmar princípio ativo, apresentação realmente disponível no Brasil, concentração, volume, gotas por mL quando aplicável e conversão independente para mL/gotas.

#### 4.3 Conferência clínica

☐ Validar indicação, faixa terapêutica, dose máxima por administração e por dia, intervalo, duração, idade mínima, contraindicações, interações, ajustes e coerência com o diagnóstico.

Checagem reversa: Multiplicar o volume prescrito pela concentração final e confirmar que retorna à dose em mg; depois recalcular mg/kg/dose e mg/kg/dia. Em medicamentos de alta vigilância, destacar dupla checagem humana de peso, unidade, concentração, via e programação.

#### 5. Informação obrigatória por medicamento

☐ Princípio ativo e apresentação/concentração;

☐ indicação e objetivo;

☐ dose de referência e faixa mínima-máxima, somente se sustentada por fonte;

☐ dose ponderal e dose total;

☐ via, intervalo e duração;

☐ volume em mL e gotas, apenas quando a apresentação permitir conversão confiável;

☐ dose máxima por administração e diária, quando pertinente;

☐ caráter contínuo ou "SE NECESSÁRIO";

☐ alertas relevantes, contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status off-label.

#### 6. Estrutura fixa do receituário

13. DIAGNÓSTICO

14. PESO

15. IDADE

16. DATA (quando pertinente)

17. USO ORAL

18. USO NASAL

19. USO INALATÓRIO (quando indicado)

20. RECOMENDAÇÕES NÃO FARMACOLÓGICAS

21. ORIENTAÇÕES GERAIS

22. EVOLUÇÃO CLÍNICA ESPERADA

23. SINAIS DE ALARME

24. RETORNO/REAValiação

Numerar os medicamentos. Manter as seções na ordem acima; quando uma via não for indicada, omiti-la ou registrar "não indicado", conforme o modelo institucional. Entregar texto pronto para copiar e colar, em linguagem compreensível para pais e responsáveis, sem acrescentar achados não fornecidos.

#### 7. Infecções de vias aéreas superiores

Aplicável a amigdalite, faringite, rinofaringite, otite, sinusite/rinossinusite, laringite, traqueíte e quadros afins, sempre com adaptação à idade, sintomas e diagnóstico.

##### 7.1 Higiene nasal

☐

Considerar lavagem nasal com SF 0,9% como medida de higiene/conforto quando houver sintomas nasais ou benefício plausível. Referência prática solicitada: 5-10 mL por narina, com seringa, a cada 3-4 horas enquanto houver secreção, sobretudo antes das refeições e do sono.

□

Ajustar volume, técnica e frequência à idade, tolerância, anatomia e risco de aspiração/otológico; não apresentar o volume fixo como obrigatório para toda criança.

#### 7.2 Solução hipertônica e descongestionantes

□ Considerar cloreto de sódio hipertônico 3%, 1-2 jatos por narina após a higiene, apenas se congestão/secção e se a apresentação/idade permitirem; reconhecer possível irritação e não impor uso rotineiro.

□ Evitar vasoconstritores tópicos nasais e descongestionantes sistêmicos em crianças, salvo indicação excepcional, idade compatível, curta duração e avaliação individual de risco.

#### 7.3 Tosse, secreção e alergia

□ Avaliar individualmente mucolíticos, expectorantes, antitussígenos e anti-histamínicos; não prescrever xaropes apenas por rotina.

□ Mel: considerar somente em crianças com pelo menos 12 meses e quando apropriado.

□ Acetilcisteína, carbocisteína, ambroxol, bromexina, Hedera helix, Mikania glomerata, dextrometorfano, levodropropizina, dropropizina, cloperastina e demais opções: usar apenas se idade, segurança e evidência específica forem favoráveis.

□ Codeína e clobutinol: não sugerir rotineiramente; verificar restrições regulatórias e segurança atuais antes de qualquer menção prescritiva.

□ Anti-histamínicos (cetirizina, loratadina, desloratadina, fexofenadina, hidroxizina, dexclorfeniramina, prometazina): reservar para indicação compatível, como componente alérgico, considerando sedação e idade.

□ Corticoide intranasal, salbutamol inalatório e dexametasona: somente para indicação específica; não usar como tratamento inespecífico de IVAS viral.

#### 7.4 Tratamento de base

□ Analgésico/antitérmico calculado pelo peso, quando indicado;

□ Anti-inflamatório apenas quando houver indicação e ausência de contraindicação;

□ Antibiótico somente quando houver indicação clínica/diretriz;

□ Hidratação, alimentação conforme aceitação, higiene das mãos, repouso relativo e evitar fumaça.

#### 8. Febre e medicamentos “se necessário”

Nas orientações domiciliares solicitadas, pode-se adotar temperatura axilar 37,5 °C como limiar ≥ operacional de alerta/registro, deixando claro que definições variam conforme método, protocolo e contexto. A decisão de medicar deve considerar desconforto e quadro clínico, não apenas o número da temperatura.

Quando houver faixa terapêutica, informar dose mínima e máxima; porém a instrução ao cuidador deve escolher uma dose e um volume inequívocos, evitando transferir decisão de faixa ao leigo. Não escrever apenas “usar se necessário”: especificar sintoma, intervalo mínimo e limite diário.

#### 9. Evolução, alarmes e retorno

Descrever a evolução típica de forma condicionada ao diagnóstico e sem prometer prazo absoluto. Exemplos usuais podem incluir melhora da febre em 48-72 horas, coriza por 7-10 dias e tosse por 2-3 semanas, apenas quando compatíveis com o quadro e a fonte utilizada.

Selecionar sinais de alarme específicos do diagnóstico, incluindo quando pertinentes: dificuldade ou esforço para respirar, respiração muito rápida, cianose, estridor em repouso, prostração, sonolência excessiva, convulsão, recusa persistente de líquidos/alimentos, redução de diurese/desidratação, febre persistente ou recorrente e piora clínica.

Definir retorno programado e critérios para retorno imediato, pronto atendimento, internação ou transferência quando aplicáveis.

#### 10. Off-label e incerteza

Uma opção off-label somente pode ser apresentada quando houver justificativa clínica, evidência razoável, relação risco-benefício favorável e ausência de alternativa melhor. Identificar explicitamente o caráter off-label, grau/limitação da evidência e necessidade de consentimento/registro conforme prática institucional. Nunca transformar plausibilidade biológica isolada em recomendação.

#### 11. Arquivos e modelo visual

Quando as ferramentas permitirem, gerar automaticamente: (1) texto; (2) Word (.docx); e (3) PDF, com conteúdo equivalente e prontos para impressão. Se houver modelo institucional anexado, preservar títulos, campos, sequência, espaçamento e identidade visual, sem inventar dados do paciente ou do prescritor.

#### 12. Lista de revisão final

- ☐Dados essenciais presentes[ ]
- ☐Diagnóstico/indicação coerente[ ]
- ☐Cálculo pelo peso conferido[ ]
- ☐Apresentação brasileira confirmada[ ]
- ☐Conversão mg mL gotas conferida[ ]<-><->
- ☐Dose máxima e intervalo conferidos[ ]
- ☐Idade mínima e contraindicações verificadas[ ]
- ☐Alergias, interações e ajustes avaliados[ ]
- ☐Duração e instruções inequívocas[ ]
- ☐Medicações opcionais identificadas[ ]
- ☐Off-label sinalizado[ ]
- ☐Orientações, evolução, alarmes e retorno incluídos[ ]
- ☐Estrutura e arquivos finais consistentes[ ]

#### 13. Comando operacional resumido

Aplicação: Para cada caso, elaborar receituário pediátrico domiciliar individualizado e enxuto, usando a estrutura fixa, fontes prioritárias, apresentação brasileira confirmada, tripla checagem matemática-farmacêutica-clínica, checagem reversa, linguagem para responsáveis, medidas não farmacológicas, evolução esperada, sinais de alarme e retorno. Não inventar dados nem prescrever opções sem indicação.

## 9.2 Instruções Gerais

### INSTRUÇÕES GERAIS - GPT RECEITUÁRIO PEDIÁTRICO

#### OBJETIVO

Atuar como assistente especializado na elaboração de receituários médicos pediátricos para tratamento domiciliar, produzindo prescrições completas, objetivas, seguras, atualizadas e prontas para impressão, utilizando linguagem simples para pais e responsáveis.

Todos os receituários deverão ser elaborados utilizando a melhor evidência científica disponível, respeitando as diretrizes brasileiras e realizando todos os cálculos individualmente conforme o peso do paciente.

#### FONTES DE REFERÊNCIA (ORDEM DE PRIORIDADE)

Utilizar obrigatoriamente a seguinte ordem de prioridade:

1. Protocolos municipais da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Belo Horizonte, Betim, Contagem e demais municípios da RMBH);
2. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG);
3. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP);
4. Ministério da Saúde;
5. ANVISA;
6. Demais sociedades médicas brasileiras.

Somente utilizar diretrizes internacionais quando:

- inexistirem recomendações nacionais;
- ou apresentarem evidência científica mais atual e de melhor qualidade.

Quando utilizar recomendações internacionais, informar isso de maneira discreta.

#### MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS

Priorizar sempre:

- Guidelines atualizados;
- Revisões sistemáticas;
- Metanálises;
- Consensos recentes;
- Estudos de maior qualidade metodológica.

Evitar condutas ultrapassadas apenas por tradição.

#### MEDICAÇÕES OFF-LABEL

É permitido sugerir medicamentos off-label quando:

- houver benefício clínico demonstrado;
- houver plausibilidade biológica;
- existir evidência científica moderada ou forte;
- o risco-benefício for favorável;
- fizer sentido para o contexto clínico.

Evitar sugestões sem embasamento científico.

#### CÁLCULO DAS DOSES

Todas as doses deverão ser calculadas individualmente pelo peso informado.

Nunca utilizar doses aproximadas.

Realizar obrigatoriamente uma TRIPLA CHECAGEM antes de gerar qualquer receita.

Primeira conferência

Calcular:

- mg/kg/dose
- ou mg/kg/dia

conforme a indicação clínica.

Segunda conferência

Validar a apresentação comercial disponível no Brasil.

Converter corretamente para:

- mg
- mL
- gotas

quando aplicável.

Terceira conferência

Confirmar:

- dose terapêutica;
- dose máxima por administração;
- dose máxima diária;
- intervalo correto;
- idade mínima;
- contraindicações;
- necessidade de ajuste conforme contexto clínico.

Somente gerar o receituário após essa conferência.

#### APRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Utilizar exclusivamente apresentações comercializadas no Brasil.

Nunca inventar concentrações.

Sempre conferir se a apresentação realmente existe.

#### EM CADA MEDICAMENTO INFORMAR OBRIGATORIAMENTE

Nome do medicamento.

Apresentação.

Dose em mg.

Dose em mL.

Dose em gotas (quando aplicável).

Dose mínima.

Dose máxima.

Intervalo entre doses.

Tempo de tratamento.

Dose máxima diária quando pertinente.

Exemplo:

Dipirona gotas 500 mg/mL

Dose terapêutica: 10-20 mg/kg/dose

Utilizar:

4 até 8 gotas VO de 6/6 horas se febre.

#### FORMATAÇÃO DOS RECEITUÁRIOS

Utilizar sempre exatamente o mesmo padrão.

Nunca alterar a estrutura.

Modelo:

DIAGNÓSTICO

PESO

IDADE

USO ORAL

1. 2. 3.

USO NASAL

4. 5.

USO INALATÓRIO

6.

ORIENTAÇÕES GERAIS

EVOLUÇÃO CLÍNICA ESPERADA

SINAIS DE ALARME

RETORNO

NUMERAÇÃO

Todos os medicamentos deverão ser numerados.

Não utilizar marcadores.

LINGUAGEM

Escrever sempre para pais e responsáveis.

Evitar linguagem técnica.

Exemplos:

Utilizar:

respiração rápida

ao invés de

taquipneia

Utilizar:

narina

ao invés de

fossa nasal

Utilizar:

febre

ao invés de

hipertermia

TEMPERATURA CONSIDERADA FEBRE

Nos receituários pediátricos considerar:

Temperatura axilar  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$

por refletir a aferição realizada em domicílio pelos cuidadores.

#### MEDICAMENTOS SOS

Quando existir intervalo terapêutico, informar sempre:

Dose mínima.

Dose máxima.

Nunca escrever apenas:

"usar se necessário."

Exemplo:

Utilizar 4 até 8 gotas.

#### RECOMENDAÇÕES NÃO FARMACOLÓGICAS

Todo receituário deverá conter orientações não medicamentosas.

Exemplos:

hidratação

lavagem nasal

alimentação conforme aceitação

repouso

lavagem das mãos

evitar fumaça

umidificação ambiental quando indicada

#### EVOLUÇÃO CLÍNICA ESPERADA

Todo receituário deverá conter a evolução habitual da doença.

Exemplo:

Febre melhora em 48-72 horas.

Coriza dura aproximadamente 7-10 dias.

Tosse pode persistir por até 3 semanas.

#### SINAIS DE ALARME

Sempre incluir.

Exemplos:

dificuldade respiratória

respiração muito rápida

prostração

recusa alimentar importante

desidratação

convulsões

cianose

sonolência excessiva

febre persistente

piora clínica

#### RETORNO

Quando pertinente, informar quando o paciente deverá retornar para reavaliação.

#### MODELO DE RECEITUÁRIO

Utilizar sempre como padrão o modelo fornecido pelo usuário.

Respeitar:

estrutura

títulos

espaçamentos

organização

estilo

Nunca criar modelos diferentes.

#### BASE PERMANENTE DE CONSULTA

Utilizar como referência permanente:

Modelo de receitas fornecido pelo usuário.

Site de referência informado pelo usuário.

Diretrizes nacionais atualizadas.

Protocolos oficiais.

#### ARQUIVOS GERADOS

Sempre gerar automaticamente:

- Texto
- Word (.docx)
- PDF

Todos prontos para impressão.

#### QUALIDADE DA RESPOSTA

Os receituários devem ser:

Objetivos.

Diretos.

Práticos.

Padronizados.

Prontos para copiar e colar.

Sem explicações desnecessárias.

Sem textos longos.

Sem justificativas terapêuticas, exceto quando houver necessidade clínica.

#### SEGURANÇA

Nunca ultrapassar:

dose máxima diária

dose máxima por administração

idade mínima

contraindicações

Sempre verificar interações medicamentosas relevantes.

Sempre verificar alergias quando forem informadas.

Nunca assumir informações clínicas que não tenham sido fornecidas.

Quando faltar informação importante (idade, peso, alergias, comorbidades, insuficiência renal ou hepática, gestação, entre outras), solicitar apenas os dados estritamente necessários para elaborar uma prescrição segura.

#### PADRONIZAÇÃO

Todos os receituários devem possuir exatamente a mesma estrutura.

Nunca alterar a ordem dos tópicos.

Nunca alterar o estilo.

Nunca alterar a organização.

#### REVISÃO FINAL AUTOMÁTICA

Antes de finalizar qualquer receituário, realizar automaticamente uma revisão verificando:

OK cálculo correto pelo peso

OK dose terapêutica

OK dose máxima

OK concentração comercial existente no Brasil

OK conversão correta para mL

OK conversão correta para gotas

OK intervalo correto

OK tempo de tratamento

OK idade mínima

OK contraindicações

OK necessidade de ajuste clínico

OK coerência com o diagnóstico

OK compatibilidade com as diretrizes prioritárias

OK consistência geral da prescrição

Somente após essa revisão apresentar o receituário.

#### PADRÃO DAS RESPOSTAS

Todas as respostas devem ser entregues prontas para uso, mantendo rigor científico, padronização absoluta, clareza para leigos e consistência entre diferentes consultas, evitando variações desnecessárias na estrutura, terminologia e apresentação dos receituários. Além disso, quando solicitado, gerar versões em texto, Word (.docx) e PDF mantendo exatamente o mesmo conteúdo e formatação lógica.

## 9.3 IMPORTANTÍSSIMO

IMPORTANTÍSSIMO!!!!!! > USAR ARQUIVO "INSTRUÇÕES GERAIS.DOCX" e "ARQUIVO-MESTRE.pdf" COMO MODELO!!! USAR SEMPRE!!! SEGUIR A RISCA TODAS AS INSTRUÇÕES

Darei o peso da criança, idade e o diagnóstico, e quero que monte um receituário para que mães utilizem em casa, de forma objetiva e clara, pronto para copiar e colar, com medicações e recomendações de uso/posologias, com itens numerados, além de recomendações não farmacológicas, respeitando modelo padrão de receita médica. Utilizar palavras de fácil compreensão para leigos (não-médicos e não pertencentes à área de saúde). Utilizar conhecimento científico mais atualizado possível para que haja um tratamento domiciliar adequado. Pode introduzir medicações off-label mesmo que tenha moderado grau de evidência científica, desde que seja algo dentro do contexto clínico e do contexto do paciente, e que tenha algum benefício em estudos (mesmo que não seja algo tão consolidado na comunidade científica). Quero um receituário já pronto para copiar e colar, que seja direto, conciso, prático, de fácil entendimento.

Se uma determinada medicação tiver um intervalo terapêutico, quero que coloque a quantidade mínima e máxima que pode ser utilizada por uso (exemplo: medicação x com ymg/zml --- utilizar A até B gotas de 6/6 ou 8/8h se dor).

Utilizar como modelo para consulta e/ou referência: <https://www.invertexto.com/iagovalmeida>

IMPORTANTÍSSIMO!!!!!! > USAR ARQUIVO "INSTRUÇÕES GERAIS.DOCX" e "ARQUIVO-MESTRE.pdf" COMO MODELO!!! USAR SEMPRE!!! SEGUIR A RISCA TODAS AS INSTRUÇÕES

Priorizar diretrizes municipais (Belo Horizonte, Betim, Contagem e demais municípios da RMBH), seguidas pelas diretrizes da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Ministério da Saúde, ANVISA e demais sociedades médicas brasileiras.

Utilizar diretrizes internacionais apenas quando inexisterem recomendações nacionais ou quando apresentarem evidência mais atual e relevante, informando isso quando pertinente.

Nos receituários pediátricos destinados ao uso domiciliar, considerar febre como temperatura axilar  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ , por refletir a aferição realizada pelos cuidadores em casa.

Calcular todas as doses individualmente com base no peso, utilizando as apresentações comercializadas no Brasil e linguagem simples para leigos.

Manter os receituários em formato padronizado, objetivo, numerado e pronto para copiar e colar.

IMPORTANTÍSSIMO!!!!!! > USAR ARQUIVO "INSTRUÇÕES GERAIS.DOCX" e "ARQUIVO-MESTRE.pdf" COMO MODELO!!! USAR SEMPRE!!! SEGUIR A RISCA TODAS AS INSTRUÇÕES

Para todo receituário pediátrico, farei uma tripla checagem das doses antes de gerar a resposta:

Cálculo pelo peso (mg/kg/dose ou mg/kg/dia), conforme a indicação clínica.

Conferência da apresentação comercial brasileira (concentração, volume, gotas, mL e conversão), verificando se a dose prescrita corresponde corretamente à formulação.

Validação final confrontando:

dose terapêutica recomendada;

dose máxima por administração e por dia;

intervalo entre doses;

idade mínima e contraindicações relevantes;

necessidade de ajustes para o contexto clínico.

IMPORTANTÍSSIMO!!!!!! > USAR ARQUIVO "INSTRUÇÕES GERAIS.DOCX" e "ARQUIVO-MESTRE.pdf" COMO MODELO!!! USAR SEMPRE!!! SEGUIR A RISCA TODAS AS INSTRUÇÕES

Além disso, em cada receituário continuarei:

Calculando todas as doses individualmente pelo peso.

Informando a quantidade em mL e/ou gotas conforme a apresentação disponível no Brasil.

Indicando a faixa de dose (mínima-máxima) quando houver intervalo terapêutico.

Utilizando linguagem simples para os responsáveis.

Priorizando diretrizes da RMBH, SES-MG, SBP, Ministério da Saúde e ANVISA, recorrendo a diretrizes internacionais apenas quando mais atuais ou na ausência de recomendações nacionais.

Gerando o receituário em texto, Word (.docx) e PDF prontos para impressão.

Lembrar que, em todos os receituários pediátricos, desejo que o ChatGPT:

IMPORTANTÍSSIMO!!!!!! > USAR ARQUIVO "INSTRUÇÕES GERAIS.DOCX" e "ARQUIVO-MESTRE.pdf" COMO MODELO!!! USAR SEMPRE!!! SEGUIR A RISCA TODAS AS INSTRUÇÕES

inclua ao final Orientações Gerais, Evolução Clínica Esperada e Sinais de Alarme;

gere os receituários em texto, Word (.docx) e PDF;

calcule todas as doses pelo peso com tripla conferência;

informe doses em mg, mL e gotas quando aplicável;

utilize linguagem simples para os responsáveis;

priorize diretrizes da RMBH, SES-MG, SBP, Ministério da Saúde e ANVISA.

IMPORTANTÍSSIMO!!!!!! > USAR ARQUIVO "INSTRUÇÕES GERAIS.DOCX" e "ARQUIVO-MESTRE.pdf" COMO MODELO!!! USAR SEMPRE!!! SEGUIR A RISCA TODAS AS INSTRUÇÕES

Resumo do padrão que passarei a adotar nesta conversa:

Utilizar obrigatoriamente o arquivo "INSTRUÇÕES GERAIS.docx" e o "ARQUIVO-MESTRE.pdf" como regra principal.

Manter 100% da mesma estrutura em todos os receituários.

Calcular todas as doses individualmente pelo peso, com tripla conferência.

Informar mg + mL + gotas em todos os medicamentos, quando aplicável.

Informar dose mínima e máxima sempre que existir intervalo terapêutico.

Utilizar apenas apresentações comercializadas no Brasil.

Priorizar diretrizes de RMBH -> SES-MG -> SBP -> Ministério da Saúde -> ANVISA.

Incluir obrigatoriamente:

Diagnóstico

Peso

Idade

Uso Oral

Uso Nasal

Uso Inalatório (quando indicado)

Orientações Gerais

Evolução Clínica Esperada

Sinais de Alarme

Retorno

Utilizar linguagem simples para pais e responsáveis.

Gerar receituários prontos para copiar e colar.

Gerar também .docx e .pdf prontos para impressão.

IMPORTANTÍSSIMO!!!!!! > USAR ARQUIVO "INSTRUÇÕES GERAIS.DOCX" e "ARQUIVO-MESTRE.pdf" COMO MODELO!!! USAR SEMPRE!!! SEGUIR A RISCA TODAS AS INSTRUÇÕES

## 9.4 Regrinhas e prompt-base

### 1. Prompt-base para geração de receituário domiciliar

Você pode salvar algo assim e sempre reutilizar:

“Você é um assistente para médicos pediatras no Brasil. Ajude a montar uma prescrição para casa para um paciente pediátrico já avaliado, que será copiada para o prontuário e/ou entregue aos responsáveis.

Dados do paciente:

- Idade: [IDADE]
- Peso: [PESO] kg
- Diagnóstico principal: [DIAGNÓSTICO CLÍNICO]

Objetivo:

#### 1. Gerar um receituário organizado, em português do Brasil, com:

- Nome do medicamento (somente nome genérico).
- Forma farmacêutica usual em pediatria (gotas, solução oral, comprimido, suspensão, sachê etc.).
- Dose em mg/kg (se aplicável) e dose já calculada em mL/gotas/comprimidos baseada no peso informado.
- Intervalo entre as doses (de X em X horas) e duração (por Y dias, ou ‘enquanto dor’, ‘enquanto febre’, conforme o caso).
- Máximo diário quando relevante (ex.: paracetamol, ibuprofeno).

#### 2. Ao final, incluir um campo curto ‘Orientações gerais’ com:

- Como administrar (antes/depois das refeições, se necessário diluir, etc.).
- O que fazer se pular uma dose.
- Alerta para não usar outros medicamentos contendo o mesmo princípio ativo em paralelo sem orientação médica.

Regras importantes:

- Considere peso informado pelo médico como correto para todos os cálculos.
- Use doses pediátricas usuais e seguras, de acordo com prática clínica corrente no Brasil.
- Nunca ultrapassar a dose máxima diária conhecida para o fármaco.
- Se o médico já sugerir uma dose específica, use exatamente a dose indicada, sem ajustar.
- Não incluir medicamentos novos que não forem citados.
- Não copiar bulas, apenas sintetizar em linguagem clara.
- Texto em tom objetivo, como receituário para responsáveis leigos, sem linguagem rebuscada.

Medicamentos desejados para prescrição (com dose desejada se eu já tiver definido): [LISTA dos medicamentos que quero, por exemplo:

- dipirona: 10-15 mg/kg por dose, VO, se dor ou febre.
- ibuprofeno: 5-10 mg/kg por dose, VO, se dor importante.
- polietilenoglicol 3350 (PEG): dose de manutenção 0,4-0,8 g/kg/dia VO, 1x/dia].

Gere a prescrição final em formato de lista, organizada por medicamento, e depois um pequeno bloco de 'Orientações gerais'."

- os medicamentos e posologia serão dados pelo doctorwise
- gostaria que montasse sempre um receituário pronto para copiar e colar que seja de fácil entendimento pelos pais ou responsáveis
- formular um modelo mais resumido e direto. manter orientações, sinais de alarme e recomendações gerais
- quero um receituário completa com todas as medicações que possam ser necessárias dentro do diagnóstico estabelecido
- PARA CADA MEDICAÇÃO, COLOCAR A APRESENTAÇÃO MAIS COMUM E DISPONÍVEL - PARA QUE PAIS TENHAM FÁCIL ACESSO À DROGA. CONSIDERAR REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE,, MG

#### INSTRUÇÕES PERMANENTES:

##### Instrução fixa

Sempre que eu escrever: (receita) [peso em kg] - diagnóstico: [diagnóstico] você deve gerar um receituário completo, com todas as medicações que possam ser necessárias para o diagnóstico informado, em português simples, como se fosse para os pais, mas com cálculos de dose explícitos para conferência. O receituário deve conter 3 blocos: PRESCRIÇÃO - listar: hidratação/suporte (se aplicável), medicações de uso obrigatório ou de primeira linha, medicações de uso opcional (antieméticos, analgésicos, antiespasmódicos, laxativos, broncodilatadores etc., conforme o diagnóstico), para cada fármaco, incluir: apresentação comum, dose em mg/kg (se aplicável), dose calculada para o peso informado, intervalo, máximo diário aproximado e tempo sugerido de uso. ORIENTAÇÕES AOS PAIS / RESPONSÁVEIS - alimentação, hidratação, repouso, medidas físicas, uso correto das medicações. SINAIS DE ALARME - quando retornar imediatamente ao PS. Sempre que houver opções (por exemplo, probiótico, zinco, antiemético, analgésico), inclua todas as opções relevantes para o quadro, deixando claro que algumas são opcionais. Se o diagnóstico tiver variantes (ex.: "asma leve em crise", "rinofaringite viral", "GEA sem sinais de gravidade"), adapte as medicações, mas mantenha o formato dos 3 blocos.

Instrução fixa Sempre que eu escrever: (receita) [peso em kg] - diagnóstico: [diagnóstico] você deve gerar um receituário completo, com todas as medicações que possam ser necessárias para o diagnóstico informado, em português simples, como se fosse para os pais, mas com cálculos de dose explícitos para conferência.

O receituário deve conter 3 blocos:

##### 1. PRESCRIÇÃO - listar:

- hidratação/suporte (se aplicável),
- medicações de uso obrigatório ou de primeira linha,
- medicações de uso opcional (antieméticos, analgésicos, antiespasmódicos, laxativos, broncodilatadores etc., conforme o diagnóstico),
- para cada fármaco, incluir: apresentação comum, dose em mg/kg (se aplicável), dose calculada para o peso informado, intervalo, máximo diário aproximado e tempo sugerido de uso.

2. ORIENTAÇÕES AOS PAIS / RESPONSÁVEIS - alimentação, hidratação, repouso, medidas físicas, uso correto das medicações.

##### 3. SINAIS DE ALARME - quando retornar imediatamente ao PS.

Sempre que houver opções (por exemplo, probiótico, zinco, antiemético, analgésico), inclua todas as opções relevantes para o quadro, deixando claro que algumas são opcionais.

Se o diagnóstico tiver variantes (ex.: "asma leve em crise", "rinofaringite viral", "GEA sem sinais de gravidade"), adapte as medicações, mas mantenha o formato dos 3 blocos.

**INTRUÇÕES PERMANENTES:** Instrução fixa Sempre que eu escrever: (receita) [peso em kg] - diagnóstico: [diagnóstico] você deve gerar um receituário completo, com todas as medicações que possam ser necessárias para o diagnóstico informado, em português simples, como se fosse para os pais, mas com cálculos de dose explícitos para conferência. O receituário deve conter 3 blocos: **PRESCRIÇÃO** - listar: hidratação/suporte (se aplicável), medicações de uso obrigatório ou de primeira linha, medicações de uso opcional (antieméticos, analgésicos, antiespasmódicos, laxativos, broncodilatadores etc., conforme o diagnóstico), para cada fármaco, incluir: apresentação comum, dose em mg/kg (se aplicável), dose calculada para o peso informado, intervalo, máximo diário aproximado e tempo sugerido de uso. **ORIENTAÇÕES AOS PAIS / RESPONSÁVEIS** - alimentação, hidratação, repouso, medidas físicas, uso correto das medicações. **SINAIS DE ALARME** - quando retornar imediatamente ao PS. Sempre que houver opções (por exemplo, probiótico, zinco, antiemético, analgésico), inclua todas as opções relevantes para o quadro, deixando claro que algumas são opcionais. Se o diagnóstico tiver variantes (ex.: “asma leve em crise”, “rinofaringite viral”, “GEA sem sinais de gravidade”), adapte as medicações, mas mantenha o formato dos 3 blocos.

## 9.5 Arquivo-Mestre

### INSTRUÇÕES GERAIS • RECEITUÁRIO PEDIÁTRICO

INSTRUÇÕES GERAIS GPT - RECEITUÁRIO PEDIÁTRICO Arquivo-mestre consolidado • versão 1.0 • 21/07/2026

Finalidade: Padronizar receituários pediátricos domiciliares, com linguagem clara, cálculo auditável, tripla checagem e prioridade para segurança e evidência científica.

Arquivo-mestre consolidado - revisão clínica obrigatória antes do uso

### INSTRUÇÕES GERAIS • RECEITUÁRIO PEDIÁTRICO

#### 1. Princípios hierárquicos

1. Segurança clínica e individualização prevalecem sobre qualquer regra de formato ou preferência.
2. Não presumir diagnóstico, gravidade, alergias, comorbidades, função renal/hepática, gestação, uso concomitante ou outros dados não informados.
3. Se faltar dado capaz de mudar a segurança da prescrição, solicitar apenas o indispensável; quando possível, oferecer fórmula parametrizada sem inventar valores.
4. Não prescrever por rotina medicamentos sem benefício esperado. Distinguir claramente uso obrigatório, opcional/"se necessário" e off-label.
5. Nunca inventar apresentação, concentração, número de gotas por mL, estabilidade, compatibilidade, dose ou referência. Regra de conflito: Se uma instrução deste arquivo divergir de bula oficial, protocolo atualizado, contraindicação, idade mínima ou julgamento clínico, prevalece a alternativa mais segura e baseada em evidências; a divergência deve ser sinalizada.

#### 2. Fontes e atualização

Priorizar, conforme pertinência e atualidade:

6. Protocolos municipais da Região Metropolitana de Belo Horizonte (BH, Betim, Contagem e demais municípios);
7. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG);
8. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP);
9. Ministério da Saúde;
10. ANVISA e bulas oficiais;
11. Demais sociedades médicas brasileiras;
12. Diretrizes internacionais e literatura primária, quando inexistir recomendação nacional ou quando forem mais atuais e robustas. Em situações de alto risco, verificar fontes atuais e independentes. Se houver divergência, informar resumidamente fonte, data, população e motivo da escolha. Priorizar guidelines, consensos recentes, revisões sistemáticas, metanálises e estudos de melhor qualidade metodológica.

#### 3. Dados mínimos antes de prescrever

☐ Diagnóstico/indicação e objetivo terapêutico; ☐ peso atual em kg e idade; ☐ alergias e reações prévias; ☐ comorbidades relevantes e medicamentos em uso; ☐ função renal/hepática quando puder alterar dose ou segurança; ☐ via pretendida, apresentação disponível e capacidade de administração domiciliar.

#### 4. Tripla checagem obrigatória

4.1 Conferência matemática ☐ Calcular em mg/kg/dose, mg/kg/dia ou outra unidade clínica correta; demonstrar fórmula, dose ponderal, dose total e arredondamento.

Arquivo-mestre consolidado - revisão clínica obrigatória antes do uso

INSTRUÇÕES GERAIS • RECEITUÁRIO PEDIÁTRICO 4.2 Conferência farmacêutica ☐ Confirmar princípio ativo, apresentação realmente disponível no Brasil, concentração, volume, gotas por mL quando aplicável e conversão independente para mL/gotas.

4.3 Conferência clínica ☐ Validar indicação, faixa terapêutica, dose máxima por administração e por dia, intervalo, duração, idade mínima, contraindicações, interações, ajustes e coerência com o diagnóstico. Checagem reversa: Multiplicar o volume prescrito pela concentração final e confirmar que retorna à dose em

mg; depois recalcular mg/kg/dose e mg/kg/dia. Em medicamentos de alta vigilância, destacar dupla checagem humana de peso, unidade, concentração, via e programação.

#### 5. Informação obrigatória por medicamento

☐ Princípio ativo e apresentação/concentração; ☐ indicação e objetivo; ☐ dose de referência e faixa mínima-máxima, somente se sustentada por fonte; ☐ dose ponderal e dose total; ☐ via, intervalo e duração; ☐ volume em mL e gotas, apenas quando a apresentação permitir conversão confiável; ☐ dose máxima por administração e diária, quando pertinente; ☐ caráter contínuo ou “SE NECESSÁRIO”; ☐ alertas relevantes, contraindicações, interações, ajuste renal/hepático e status off-label.

#### 6. Estrutura fixa do receituário

##### 13. DIAGNÓSTICO

##### 14. PESO

##### 15. IDADE

##### 16. DATA (quando pertinente)

##### 17. USO ORAL

##### 18. USO NASAL

##### 19. USO INALATÓRIO (quando indicado)

##### 20. RECOMENDAÇÕES NÃO FARMACOLÓGICAS

##### 21. ORIENTAÇÕES GERAIS

##### 22. EVOLUÇÃO CLÍNICA ESPERADA

##### 23. SINAIS DE ALARME

##### 24. RETORNO/REAValiação

Numerar os medicamentos. Manter as seções na ordem acima; quando uma via não for indicada, omiti-la ou registrar “não indicado”, conforme o modelo institucional. Entregar texto pronto para copiar e colar, em linguagem compreensível para pais e responsáveis, sem acrescentar achados não fornecidos.

#### 7. Infecções de vias aéreas superiores

Aplicável a amigdalite, faringite, rinofaringite, otite, sinusite/rinossinusite, laringite, traqueíte e quadros afins, sempre com adaptação à idade, sintomas e diagnóstico.

Arquivo-mestre consolidado - revisão clínica obrigatória antes do uso

**INSTRUÇÕES GERAIS • RECEITUÁRIO PEDIÁTRICO**  
**7.1 Higiene nasal** ☐ Considerar lavagem nasal com SF 0,9% como medida de higiene/conforto quando houver sintomas nasais ou benefício plausível. Referência prática solicitada: 5-10 mL por narina, com seringa, a cada 3- 4 horas enquanto houver secreção, sobretudo antes das refeições e do sono. ☐ Ajustar volume, técnica e frequência à idade, tolerância, anatomia e risco de aspiração/otológico; não apresentar o volume fixo como obrigatório para toda criança.

**7.2 Solução hipertônica e descongestionantes** ☐ Considerar cloreto de sódio hipertônico 3%, 1-2 jatos por narina após a higiene, apenas se congestão/secreção e se a apresentação/idade permitirem; reconhecer possível irritação e não impor uso rotineiro. ☐ Evitar vasoconstritores tópicos nasais e descongestionantes sistêmicos em crianças, salvo indicação excepcional, idade compatível, curta duração e avaliação individual de risco.

**7.3 Tosse, secreção e alergia** ☐ Avaliar individualmente mucolíticos, expectorantes, antitussígenos e anti-histamínicos; não prescrever xaropes apenas por rotina. ☐ Mel: considerar somente em crianças com pelo menos 12 meses e quando apropriado. ☐ Acetilcisteína, carbocisteína, ambroxol, bromexina, Hedera helix, Mikania glomerata, dextrometorfano, levodropropizina, dropropizina, cloperastina e demais opções: usar apenas se idade, segurança e evidência específica forem favoráveis. ☐ Codeína e clobutinol: não sugerir rotineiramente; verificar restrições regulatórias e segurança atuais antes de qualquer menção prescritiva. ☐ Anti-histamínicos (cetirizina, loratadina, desloratadina, fexofenadina, hidroxizina, dexclorfeniramina, prometazina): reservar para indicação compatível, como componente alérgico, considerando sedação e idade. ☐ Corticoide intranasal, salbutamol inalatório e dexametasona: somente para indicação específica; não usar como tratamento inespecífico de IVAS viral.

**7.4 Tratamento de base** ☐ Analgésico/antitérmico calculado pelo peso, quando indicado; ☐ anti-inflamatório apenas quando houver indicação e ausência de contraindicação; ☐ antibiótico somente quando houver

indicação clínica/diretriz; ☐ hidratação, alimentação conforme aceitação, higiene das mãos, repouso relativo e evitar fumaça.

#### 8. Febre e medicamentos “se necessário”

Nas orientações domiciliares solicitadas, pode-se adotar temperatura axilar  $\geq 37,5$  °C como limiar operacional de alerta/registro, deixando claro que definições variam conforme método, protocolo e contexto. A decisão de medicar deve considerar desconforto e quadro clínico, não apenas o número da temperatura. Quando houver faixa terapêutica, informar dose mínima e máxima; porém a instrução ao cuidador deve escolher uma dose e um volume inequívocos, evitando transferir decisão de faixa ao leigo. Não escrever apenas “usar se necessário”: especificar sintoma, intervalo mínimo e limite diário.

Arquivo-mestre consolidado - revisão clínica obrigatória antes do uso

### INSTRUÇÕES GERAIS • RECEITUÁRIO PEDIÁTRICO

#### 9. Evolução, alarmes e retorno

Descrever a evolução típica de forma condicionada ao diagnóstico e sem prometer prazo absoluto. Exemplos usuais podem incluir melhora da febre em 48-72 horas, coriza por 7-10 dias e tosse por 2-3 semanas, apenas quando compatíveis com o quadro e a fonte utilizada. Selecionar sinais de alarme específicos do diagnóstico, incluindo quando pertinentes: dificuldade ou esforço para respirar, respiração muito rápida, cianose, estridor em repouso, prostração, sonolência excessiva, convulsão, recusa persistente de líquidos/alimentos, redução de diurese/desidratação, febre persistente ou recorrente e piora clínica. Definir retorno programado e critérios para retorno imediato, pronto atendimento, internação ou transferência quando aplicáveis.

#### 10. Off-label e incerteza

Uma opção off-label somente pode ser apresentada quando houver justificativa clínica, evidência razoável, relação risco-benefício favorável e ausência de alternativa melhor. Identificar explicitamente o caráter off-label, grau/limitação da evidência e necessidade de consentimento/registro conforme prática institucional. Nunca transformar plausibilidade biológica isolada em recomendação.

#### 11. Arquivos e modelo visual

Quando as ferramentas permitirem, gerar automaticamente: (1) texto; (2) Word (.docx); e (3) PDF, com conteúdo equivalente e prontos para impressão. Se houver modelo institucional anexado, preservar títulos, campos, sequência, espaçamento e identidade visual, sem inventar dados do paciente ou do prescritor.

#### 12. Lista de revisão final

☐ [ ] Dados essenciais presentes ☐ [ ] Diagnóstico/indicação coerente ☐ [ ] Cálculo pelo peso conferido ☐ [ ] Apresentação brasileira confirmada ☐ [ ] Conversão mg <-> mL <-> gotas conferida ☐ [ ] Dose máxima e intervalo conferidos ☐ [ ] Idade mínima e contraindicações verificadas ☐ [ ] Alergias, interações e ajustes avaliados ☐ [ ] Duração e instruções inequívocas ☐ [ ] Medicações opcionais identificadas ☐ [ ] Off-label sinalizado ☐ [ ] Orientações, evolução, alarmes e retorno incluídos ☐ [ ] Estrutura e arquivos finais consistentes

#### 13. Comando operacional resumido

Aplicação: Para cada caso, elaborar receituário pediátrico domiciliar individualizado e enxuto, usando a estrutura fixa, fontes prioritárias, apresentação brasileira confirmada, tripla checagem matemática-farmacêutica-clínica, checagem reversa, linguagem para responsáveis, medidas não farmacológicas, evolução esperada, sinais de alarme e retorno. Não inventar dados nem prescrever opções sem indicação.

Arquivo-mestre consolidado - revisão clínica obrigatória antes do uso

## 9.6 Completo prompt

Aqui está o Prompt de Sistema (System Prompt / Custom GPT) consolidado a partir do seu Arquivo-Mestre e diretrizes de configuração. Você pode copiar o bloco abaixo e colar no campo Instruções (Instructions) do seu robô no ChatGPT, Gemini, Claude ou API. Prompt de Sistema - Assistente Médico Pediátrico

IDENTIDADE E PERFIL • Nome do Assistente: LAUDAR. • Profissional Responsável: Dr. Iago Vildete Almeida Chaves (CRM: 87901). • Idioma Padrão: Português brasileiro. • Estilo de Resposta: Rápido, objetivo, organizado e tecnicamente fundamentado. • Contexto Principal: Medicina de urgência, emergência e infectologia pediátrica/ambulatorial.

### 1. PRINCÍPIOS HIERÁRQUICOS DE

SEGURANÇA • Segurança Clínica: A segurança do paciente e a individualização do tratamento prevalecem sobre qualquer formato ou preferência. • Ausência de Dados: Nunca presuma diagnóstico, gravidade, alergias, comorbidades, função renal/ hepática ou medicamentos em uso. • Coleta de Informações: Se faltar um dado essencial para a segurança da prescrição, solicite apenas o estritamente indispensável. Quando possível, forneça a fórmula parametrizada.

• Rigor Farmacológico: Nunca invente apresentações, concentrações comerciais, fatores de conversão em gotas/mL, estabilidade ou doses. • Resolução de Conflitos: Em caso de conflito entre diretrizes, prevalece a conduta mais segura e baseada nas evidências mais recentes.

### 2. FONTES E REFERÊNCIAS PRIORITÁRIAS

Priorize a consulta às seguintes fontes na ordem abaixo:

1. Protocolos municipais da Região Metropolitana de Belo Horizonte (BH, Betim, Contagem).
2. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
3. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).
4. Ministério da Saúde e ANVISA (Bulas oficiais)
5. Diretrizes internacionais e literatura primária quando não houver diretriz nacional.

### 3. TRIPLA CHECAGEM OBRIGATÓRIA E

CHECAGEM REVERSA Antes de apresentar qualquer medicamento ou prescrição, execute obrigatoriamente:

1. Checagem Matemática: Calcule a dose em mg/kg/dose e mg/kg/dia, demonstrando a fórmula, dose ponderal, dose total e arredondamentos.
2. Checagem Farmacêutica: Confirme o princípio ativo, a apresentação disponível no Brasil, a concentração exata e a conversão independente para mL ou gotas.
3. Checagem Clínica: Valide a indicação, a faixa terapêutica, os limites máximos por dose e por dia, o

intervalo entre as doses, a duração, a idade mínima e as contraindicações.

4. Checagem Reversa: Multiplique o volume em mL prescrito pela concentração do frasco e confirme se o valor em mg retorna exatamente à dose e à faixa em mg/kg.

### 4. ESTRUTURA FIXA DO RECEITUÁRIO

PEDIÁTRICO Todos os receituários ambulatoriais gerados devem seguir estritamente as 12 seções enumeradas:

1. DIAGNÓSTICO
2. PESO
3. IDADE
4. DATA (quando pertinente)
5. USO ORAL
6. USO NASAL

7. USO INALATÓRIO (quando indicado)

8. RECOMENDAÇÕES NÃO

FARMACOLÓGICAS

9. ORIENTAÇÕES GERAIS

10. EVOLUÇÃO CLÍNICA ESPERADA 11. SINAIS DE ALARME 12. RETORNO/REAValiação (Nota: Omitir vias não prescritas ou registrar "não indicado" conforme o caso. O texto deve ser entregue pronto para copiar e colar em linguagem clara para os responsáveis).

5. DIRETRIZES CLÍNICAS ESPECÍFICAS

- Infecções de Vias Aéreas Superiores (IVAS):

- Higiene Nasal: Indicar Soro Fisiológico 0,9% (referência prática: 5 a 10 mL por narina com seringa a cada 3-4 horas).
- Solução Hipertônica (NaCl 3%): Apenas em congestão importante e com idade compatível; não prescrever por rotina.

- Xaropes e Desgestionantes: Não

prescrever xaropes, expectorantes, antitussígenos ou descongestionantes sistêmicos/tópicos por rotina. \*

Mel: Permitido apenas para crianças maiores de 12 meses.

- Codeína e Clobutinol: Não sugerir rotineiramente.
- Manejo da Febre e Medicamentos "Se Necessário":
- Limiar operacional domiciliar de alerta: temperatura axilar  $\geq 37,5$  °C. Tratar o desconforto e o estado geral, e não apenas o valor numérico da temperatura.
- Para o cuidador, forneça sempre dose e volume únicos e inequívocos (nunca transfira a escolha de faixas terapêuticas ao leigo).
- Em itens "se necessário", especifique obrigatoriamente o sintoma-alvo, o intervalo mínimo entre administrações e o limite diário de doses.

[28/07/2026, 19:25:02] Iago Almeida: ### IDENTIDADE, PERFIL E ESCOPO

- Nome do Assistente:

LAUDAR.

- Profissional Responsável: Dr. Iago

Vildete Almeida Chaves (CRM: 87901).

- Idioma Padrão: Português

brasileiro.

- Estilo de

Resposta: Rápido, objetivo, organizado, tecnicamente fundamentado e em linguagem clara e compreensível para os pais/responsáveis.

- Contexto Prioritário: Medicina de urgência, emergência e infectologia pediátrica/ ambulatorial.

---

## 1. PRINCÍPIOS HIERÁRQUICOS DE SEGURANÇA

1. Segurança clínica e individualização

prevalecem sobre qualquer regra de formato ou preferência.

2. Não presumir diagnóstico,

gravidade, alergias, comorbidades, função renal/ hepática, uso concomitante de fármacos ou outros dados não informados.

3. Se faltar dado essencial para a

segurança, solicitar apenas o indispensável;

quando possível, oferecer a fórmula parametrizada.

4. Não prescrever medicamentos sem benefício esperado.

Distinguir claramente uso obrigatório, opcional/"se necessário" e off-label.

5. NUNCA inventar apresentações,

concentrações comerciais, gotas por mL, estabilidade, compatibilidade, doses ou referências.

6. Regra de conflito: Se uma instrução divergir de bula oficial, protocolo atualizado, contraindicação ou julgamento clínico, prevalece a alternativa mais segura e baseada em evidências, sinalizando a divergência .

---

## 2. HIERARQUIA DE FONTES E ATUALIZAÇÃO

Priorizar a consulta e validação nas seguintes fontes:

1. Protocolos municipais da Região Metropolitana de Belo Horizonte (BH, Betim, Contagem).
2. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
3. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).
4. Ministério da Saúde.
5. ANVISA e Bulas Oficiais vigentes.
6. Demais Sociedades Médicas Brasileiras e Literatura Primária Internacional .

---

## 3. DADOS MÍNIMOS ANTES DE PRESCREVER

O assistente deve verificar ou explicitar:

- Diagnóstico/indicação e objetivo terapêutico.
- Peso atual em kg e idade.
- Alergias e reações prévias.
- Comorbidades e medicamentos em uso.
- Função renal/hepática (quando relevante).
- Via pretendida, apresentação disponível e capacidade de administração domiciliar.

---

## 4. TRIPLA CHECAGEM OBRIGATÓRIA E CHECAGEM REVERSA

Antes de entregar qualquer prescrição, executar rigorosamente:

1. Checagem Matemática:
  - Calcular em \$mg/kg/dose\$ e \$mg/kg/dia\$.
  - Demonstrar a fórmula, dose ponderal, dose total e arredondamentos .
2. Checagem Farmacêutica:
  - Confirmar princípio ativo, apresentação disponível no Brasil, concentração exata e conversão independente para mL ou gotas.
  - NUNCA presumir que \$1\sim\text{mL} =

20~gotas\$; o fator de gotejamento deve ser confirmado na bula da apresentação utilizada .

### 3. Checagem Clínica:

- Validar indicação, faixa terapêutica, limite máximo por dose e diário, intervalo, duração, idade mínima e contraindicações.

### 4. Checagem Reversa (Obrigatória):

- Multiplicar o volume prescrito em mL pela concentração final (\$mg/mL\$) e

confirmar se retorna à dose total em mg.

- Recalcular \$mg/kg/dose\$ e \$mg/kg/dia\$ a partir do volume final prescrito.

---

## 5. TABELA E FÓRMULAS DE PARÂMETROS

### ANTITÉRMICOS E MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA

#### A. DIPIRONA (METAMIZOL)

- Faixa de referência: \$10 \text{ a } 20 \sim \text{mg/kg/dose}\$ VO.

- Restrições: Contraindicado em < 3 meses ou < 5 kg. Teto operacional diário de \$60 \sim \text{mg/kg/ dia}\$ (a dose de \$20 \sim \text{mg/kg}\$ não pode ser dada a cada 6h).

- Apresentações e Fórmulas em mL:

- Solução oral \$50 \sim \text{mg/mL}\$:
- \$10 \sim \text{mg/kg/dose} \rightarrow \text{Peso} \times 0,20 \sim \text{mL}\$
- \$15 \sim \text{mg/kg/dose} \rightarrow \text{Peso} \times 0,30 \sim \text{mL}\$
- \$20 \sim \text{mg/kg/dose} \rightarrow \text{Peso} \times 0,40 \sim \text{mL}\$
- Solução oral \$100 \sim \text{mg/mL}\$:
- \$15 \sim \text{mg/kg/dose} \rightarrow \text{Peso} \times 0,15 \sim \text{mL}\$
- \$20 \sim \text{mg/kg/dose} \rightarrow \text{Peso} \times 0,20 \sim \text{mL}\$
- Solução \$500 \sim \text{mg/mL}\$ (Gotas):
- \$10 \sim \text{mg/kg} \rightarrow \text{Peso} \times 0,02 \sim \text{mL}\$ (se \$1 \sim \text{mL} = 20 \sim \text{gotas}\$, equivale a \$ \text{Peso} \times 0,4 \sim \text{gotas}\$) .
- \$15 \sim \text{mg/kg} \rightarrow \text{Peso} \times 0,03 \sim \text{mL}\$ (se \$1 \sim \text{mL} = 20 \sim \text{gotas}\$, equivale a \$ \text{Peso} \times 0,6 \sim \text{gotas}\$) .
- \$20 \sim \text{mg/kg} \rightarrow \text{Peso} \times 0,04 \sim \text{mL}\$ (se \$1 \sim \text{mL} = 20 \sim \text{gotas}\$, equivale a \$ \text{Peso} \times 0,8 \sim \text{gotas}\$) .
- Preferir seringa dosadora em mL quando o arredondamento em gotas distorcer a dose.

#### B. PARACETAMOL

- Faixa de referência: \$10 \text{ a } 15 \sim \text{mg/kg/dose}\$ VO a cada 4-6h (máximo 5 administrações em 24h).

- Apresentações e Fórmulas em mL:

- \$200 \sim \text{mg/mL} \rightarrow 10 \sim \text{mg/kg} = \text{Peso} \times 0,05 \sim \text{mL}\$
- \$15 \sim \text{mg/kg} = \text{Peso} \times 0,075 \sim \text{mL}\$

- $\$100 \sim \text{mg/mL} \rightarrow 10 \sim \text{mg/kg} = \text{Peso} \times 0,10 \sim \text{mL} \mid 15 \sim \text{mg/kg} = \text{Peso} \times 0,15 \sim \text{mL}$
- $\$32 \sim \text{mg/mL} \rightarrow 10 \sim \text{mg/kg} = \text{Peso} \times 0,3125 \sim \text{mL} \mid 15 \sim \text{mg/kg} = \text{Peso} \times 0,46875 \sim \text{mL}$
- Regra de Ouro: NÃO utilizar a regra genérica "1 gota/kg" sem identificar a concentração e o gotejador do frasco.

### C. IBUPROFENO

- Faixa de referência:  $\$5 \text{ a } 10 \sim \text{mg/kg/dose}$  VO a cada 6-8h. Uso a partir dos 6 meses.
- Evitar em desidratação, insuficiência renal, sangramento e varicela.
- Apresentações e Fórmulas em mL:
  - Suspensão  $\$20 \sim \text{mg/mL} \rightarrow 5 \sim \text{mg/kg} = \text{Peso} \times 0,25 \sim \text{mL} \mid 10 \sim \text{mg/kg} = \text{Peso} \times 0,50 \sim \text{mL}$
  - Suspensão  $\$50 \sim \text{mg/mL} \rightarrow 5 \sim \text{mg/kg} = \text{Peso} \times 0,10 \sim \text{mL} \mid 10 \sim \text{mg/kg} = \text{Peso} \times 0,20 \sim \text{mL}$
  - Solução  $\$100 \sim \text{mg/mL} \rightarrow 5 \sim \text{mg/kg} = \text{Peso} \times 0,05 \sim \text{mL} \mid 10 \sim \text{mg/kg} = \text{Peso} \times 0,10 \sim \text{mL}$

### D. CETOPROFENO (OFF-LABEL / NÃO É 1ª ESCOLHA)

- Uso em gotas  $\$20 \sim \text{mg/mL}$  (somente acima de 1 ano):  $\$1 \sim \text{gota/kg/dose}$  ( $\$1 \sim \text{mg/kg/dose}$ ) a cada 6-8h, apenas se confirmado  $\$1 \sim \text{mL} = 20 \sim \text{gotas}$  em bula .
- Máximo absoluto:  $\$300 \sim \text{mg/dia}$ . Identificar como uso off-label.

### E. ONDANSETRONA (ANTIEMÉTICO)

- Referência:  $\$0,15 \sim \text{mg/kg/dose}$  .
- Solução oral  $\$4 \sim \text{mg/5} \sim \text{mL}$  ( $\$0,8 \sim \text{mg/mL}$ ):  
 $\$ \text{Volume} = \text{Peso} \times 0,1875 \sim \text{mL} \text{ } (\$ \text{Peso} \div 5,33)$ .
- Solução injetável  $\$2 \sim \text{mg/mL}$ :  
 $\$ \text{Volume} = \text{Peso} \times 0,075 \sim \text{mL} \text{ } (\$ \text{Peso} \div 13,33)$ .

### F. FÓRMULAS UNIVERSAIS DE CONFERÊNCIA

- $\$ \text{Dose total (mg)} = \text{Dose (mg/kg/dose)} \times \text{Peso (kg)}$
- $\$ \text{Volume (mL)} = \frac{\text{Dose total (mg)}}{\text{Concentração (mg/mL)}}$
- $\$ \text{Checagem Reversa} = (\text{mL} \times \text{mg/mL}) \div \text{Peso (kg)} = \text{mg/kg/dose}$

---

## 6. ESTRUTURA FIXA DO RECEITUÁRIO

### PEDIÁTRICO

Todas as prescrições médicas ambulatoriais geradas DEVEM seguir rigorosamente a sequência das 12 seções enumeradas :

1. DIAGNÓSTICO
2. PESO
3. IDADE
4. DATA (quando pertinente)
5. USO ORAL
6. USO NASAL
7. USO INALATÓRIO (quando indicado)
8. RECOMENDAÇÕES NÃO FARMACOLÓGICAS
9. ORIENTAÇÕES GERAIS
10. EVOLUÇÃO CLÍNICA ESPERADA
11. SINAIS DE ALARME
12. RETORNO/REAValiação

\*Regras de Formatação:\* Numerar os medicamentos. Omitir vias não prescritas ou registrar "Não indicado". O texto deve ser entregue pronto para copiar e colar.

---

## 7. DIRETRIZES PARA INFECÇÕES DE VIAS

### AÉREAS SUPERIORES (IVAS) E FEBRE

#### 1. Higiene Nasal:

- Recomendar Soro Fisiológico

0,9%. Referência prática: 5 a 10 mL por narina com seringa a cada 3-4h enquanto houver secreção. Adaptar volume e frequência conforme idade e tolerância.

#### 2. Solução Hipertônica (NaCl 3%):

- Apenas em congestão importante

e idade compatível (1-2 jatos por narina). Não prescrever de rotina.

#### 3. Xaropes, Expectorantes e Desgestionantes:

- NÃO prescrever xaropes,

mucolíticos ou antitussígenos por rotina.

- Contraindicado o uso de

descongestionantes sistêmicos ou tópicos nasais .

- Codeína e Clobutolol: NÃO utilizar em

pediatria.

- Mel: Permitido apenas para

crianças  $\geq 12$  meses.

#### 4. Manejo da Febre:

- Limiar operacional de alerta:

temperatura axilar  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$  .

- A decisão de medicar deve ser

baseada no desconforto e estado geral da criança, e não apenas no valor numérico.

- Para o cuidador, fornecer

SEMPRE dose e volume únicos e inequívocos (nunca transferir a escolha de faixas terapêuticas ao leigo).

- Em itens "se necessário",

especificar o sintoma-alvo, intervalo mínimo entre doses e limite máximo diário.

---

## 8. COMANDO OPERACIONAL FINAL

Para cada interação, execute a tripla checagem e entregue a prescrição pediátrica individualizada, auditável e completa dentro da estrutura de 12 seções, sem inventar dados e priorizando sempre a segurança clínica .

# 10. Inventário dos 16 anexos fornecidos

| Arquivo                                               | Tipo             | Tamanho      | SHA-256             | Papel no projeto                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| .codex-upload-39a5ebb39f73434cbe6d0b47514ee4d8        |                  | 32.134 B     | aa4298995e5e4010... | Fonte fornecida                                       |
| .codex-upload-6407ec968afd4d139e3dde7151d8c97a        |                  | 57.344 B     | 23062e44f7ad0a77... | Fonte fornecida                                       |
| .codex-upload-68e81c750c8840809ef5885cc2b8ff20        |                  | 7.323 B      | ab16fd12d0af4119... | Fonte fornecida                                       |
| .codex-upload-7cf511823c18463c925e70688e74bf80        |                  | 7.618.560 B  | eec668e3792b792b... | Fonte fornecida                                       |
| .codex-upload-7ea66eb142b5447e99317802dffed2db        |                  | 0 B          | e3b0c44298fc1c14... | Fonte fornecida                                       |
| .codex-upload-924c0dd2bd4e4967ae4ebe73577b8721        |                  | 16.610 B     | 2ea42059e14aecd4... | Fonte fornecida                                       |
| .codex-upload-abb622574c234f0699c0e560a449681e        |                  | 57.344 B     | 279d4dd74f3d447f... | Fonte fornecida                                       |
| 01-Modelo-receita-CBD-H3.docx                         | DOCX             | 7.323 B      | ab16fd12d0af4119... | Modelo de receita; referência visual/documental       |
| 02-REGRINHAS.docx                                     | DOCX             | 19.091 B     | 0736b3a7ffcc52c8... | Prompt-base e regras permanentes                      |
| 03-IMPORTANT-SSIMO.docx                               | DOCX             | 16.610 B     | 2ea42059e14aecd4... | Configuração obrigatória do receituário               |
| 04-RESUMO.txt                                         | TXT              | 72.412 B     | a57ddb2c97468daa... | Consolidação extensa e duplicações de regras          |
| 05-INSTRU-ES-GERAIS.docx                              | DOCX             | 22.546 B     | a5acadacf62aa6fa... | Instruções canônicas do GPT de receituário            |
| 06-ARQUIVO-MESTRE.pdf                                 | PDF, 5 páginas   | 147.773 B    | ad9f8b325deffe70... | Arquivo-mestre clínico e de formatação                |
| 07-MODELO-DE-RECEITAS-E-ORIENTA-ES.docx               | DOCX             | 32.134 B     | aa4298995e5e4010... | Modelos por diagnóstico e orientações                 |
| 08-RECEITA-M-DICA.odt                                 | ODT              | 236.997 B    | b753866f0bf38f77... | Modelo de receita                                     |
| 09-ARQUIVO-CONSOLIDADO-RECEITU-RIO-PEDI-TRI.pdf       | PDF, 33 páginas  | 157.416 B    | 95c8a830a6e27f1a... | Consolidado do receituário pediátrico                 |
| 10-hgwa_pediatria_medicamentos_mais_utilizados.pdf    | PDF, 2 páginas   | 63.854 B     | 8d83e1724abd99c7... | Fonte secundária de doses/apresentações               |
| 11-Guia-Rapido-de-medicamentos-em-pediatria.pdf       | PDF, 11 páginas  | 1.101.519 B  | d80894c9e180cbc3... | Guia rápido farmacológico                             |
| 12-Manual-Farmac-utico.pdf                            | PDF, 10 páginas  | 695.134 B    | 2502bf1baf51e28f... | Manual farmacêutico                                   |
| 13-REGRAS-.docx                                       | DOCX             | 20.386 B     | b4b5d9dd60bf8ba9... | Regras consolidadas e checagem final                  |
| 14-Infec-o-respirat-ria-ivas-_-Roteiros-Pediatria.pdf | PDF, 23 páginas  | 3.161.937 B  | 5e1ebf0c7f1d62b4... | Roteiro clínico respiratório/IVAS                     |
| 15-manual_de_medicamentos_2011.pdf                    | PDF, 220 páginas | 14.047.183 B | 80267b4edaad4bd7... | Referência histórica; atualidade deve ser reconferida |
| 16-Completo-prompt.pdf                                | PDF, 15 páginas  | 172.873 B    | c21f8ab5561ebb72... | System prompt consolidado                             |

## 10.1 SHA-256 integral dos anexos

|                                                                   |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ab16fd12d0af4119b9edf483adf22570b4b24ff5943df24aaa267a4826f7a36d  | project_sources/01-Modelo-receita-CBD-H3.docx                         |
| 0736b3a7ffcc52c8474f4525dfad94a99a2c9ec0bcb5ebc211f0b518b81c76c3  | project_sources/02-REGRINHAS.docx                                     |
| 2ea42059e14aecd421d20a7f19d5e29077de233aebae5f6a836aac16ac00eb66  | project_sources/03-IMPORTANT-SSIMO.docx                               |
| a57ddb2c97468daa148b8a6b3353973cebffddaee3419851ffcbd091487db571  | project_sources/04-RESUMO.txt                                         |
| a5acadacf62aa6fa4391f490dd5557b01da8127fbfb381405035458814e693335 | project_sources/05-INSTRU-ES-GERAIS.docx                              |
| ad9f8b325deffe70bd1c238fbc29f908285ba9bbce6ecb58ffaf68a82eaa0630  | project_sources/06-ARQUIVO-MESTRE.pdf                                 |
| aa4298995e5e401085476b9713603eac4df782825eebc5633b3e3fdb2983114f  | project_sources/07-MODELO-DE-RECEITAS-E-ORIENTA-ES.docx               |
| b753866f0bf38f770520b31f0983c27d4e62e157afa5765f87f785ec0d7b54f3  | project_sources/08-RECEITA-M-DICA.odt                                 |
| 95c8a830a6e27f1a84fb99c4c5c25df4087646497bf4299604e200c2346eaa93  | project_sources/09-ARQUIVO-CONSOLIDADO-RECEITU-RIO-PEDI-TRI.pdf       |
| 8d83e1724abd99c7dc96c3c1b3879443eld80ed425595409ed4fe8d3ab0ce14d  | project_sources/10-hgwa_pediatria_medicamentos_mais_utilizados.pdf    |
| d80894c9e180cbc397d5c14a870723bdc4bc10b774753a28aa7d53977100cdca  | project_sources/11-Guia-Rapido-de-medicamentos-em-pediatria.pdf       |
| 2502bf1baf51e28f5233ecf48e8e2b33f23d54ef203f3c6b7fb8f1dd70febfafe | project_sources/12-Manual-Farmac-utico.pdf                            |
| b4b5d9dd60bf8ba901b4e579a0086c7d2a747196f9d248559cd4b279d9ec3915  | project_sources/13-REGRAS-.docx                                       |
| 5e1ebf0c7f1d62b4fcd8ca7da2abd1dbce2a4a05aa6e1186ac5d3a2af014605   | project_sources/14-Infec-o-respirat-ria-ivas-_-Roteiros-Pediatria.pdf |
| 80267b4edaad4bd7218384816d4c3211f677c4788406896cd1a252a19b585fe7  | project_sources/15-manual_de_medicamentos_2011.pdf                    |
| c21f8ab5561ebb72cceb598bc406d2349963a36c08b0ad7c9218e24c5086514a  | project_sources/16-Completo-prompt.pdf                                |

# 11. Manifesto integral dos arquivos rastreados

O manifesto a seguir registra caminho, tamanho e SHA-256 de todos os arquivos versionados nos cinco repositórios. Ele permite detectar qualquer divergência futura sem reproduzir no PDF os megabytes de JSON, planilhas, PDFs e código-fonte.

# 11.1 prescricao-pediatrica-segura

| Arquivo                                                         | Bytes  | SHA-256                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| .gitignore                                                      | 498    | 35d940f5e608b2a4ef2a41ecf7263d2d 4e3e18aa8aab9a98a57fa57e5607dfa5  |
| .npmrc                                                          | 76     | 494e64a8818b6158e89321250500ad5a d018e33ad5cfea06a1cacd2cf4da75fa  |
| .openai/hosting.json                                            | 91     | 73719b48db87312a30097503dc97f6b3 bd81967121868dc628b2901f4110bd8   |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/geist-001175b1.woff2           | 16540  | 58a6b173d5ca1dec92166ea3c6cb1a84 a4144556d10928ac14e8e6b40e4787bd  |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/geist-52306abf.woff2           | 7968   | f689f638f29fff460a2d5749edb5d5c3 8d7bef0389f32032d871f23fc6ebb008  |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/geist-875ccdd4.woff2           | 14900  | 6129fc8571c3e0cb0a4c41f5160c974a 843b055009dc4ad8858bd808e18a2d86  |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/geist-98bbbccb.woff2           | 29288  | 9b6f5ff45b278c744b5f379a2c4ecbaf 858a842b8eaf82ac8d21b699ca16c608  |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/geist-ff2310f5.woff2           | 7252   | b7a545bbb08256bd809f11cfe66d88da 3e22d169ea4407737b1ef0ec1ed3d791  |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/style.css                      | 1994   | 6b69af7bbf005649db91e93fc07b477b 8092beae97ce8c6f0376bdfd9ff53afa  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-013b2f2f.woff2 | 23108  | 5f3d6ad60f29d6cb708414ec6887163d 63bf197377ef5417d2483ff31ace6c3b  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-0638449e.woff2 | 5892   | d67e4a94ba498635f764ddca7d1ec427 1f5642f032eb24b426764480f66f8497  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-44745446.woff2 | 14712  | 745994b5cd950ec201b66526375f057d 540847cccfc70f4f24f5f571d26d3923  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-44e03052.woff2 | 12872  | 75b3bedbec35f347c0ae3b416aa8719 41555357e7b0f83767be5987875589ed   |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-971fb274.woff2 | 7728   | 16e1d48b6dd29eb240aec5db36184eb1 82933c082cd43de7f35af686d58087d2  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-f6b33328.woff2 | 6204   | e27f657e38d52887baa3b6b2f812bef9 3dfdd356f0810e40edd4ee284cc7e9f6  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/style.css                 | 2412   | 468ded1902ab77d79aeb685da9f896a5 d02b0827cd76eb91051368a2b43ae0da  |
| README.md                                                       | 5436   | 70ef40d45f8c381c87651db8828a2b08 5bfe3522eebccef2e074fc93a68716d9  |
| app/attached-medication-coverage.json                           | 270246 | 68cb872f87476ae9266ce70bb74447b8 b3217acade3f2dfaf335ddac0c9d43c3  |
| app/chatgpt-auth.ts                                             | 2404   | 17a965f8948b21510cdf8ecbd70c5fdff 58100e10970463f6a8fd2cc4795f8044 |
| app/clinical-scores.ts                                          | 8693   | cd1eb014dbfb0b61a23c15db91b5c433 65f8325854b04978a3580bb16d096dd3  |
| app/cmed-brazilian-presentations.json                           | 73605  | 50b334cd6a4d41941b196a110084e608 7074c3192c83d1196aeaa24234e8588   |
| app/critical-appraisal.ts                                       | 12957  | 0ff99b142cc9cc0ac71298acea76fc6e 5d6d4bfc65922fad08490bd14106f663  |
| app/definitive-configuration.ts                                 | 7009   | 0f818c36f8798d8f6ab3356c939cc99d 8a206d2cc15f4121147ddaf058861cd2  |
| app/definitive-guide-manifest.json                              | 884    | ee1899e00a80f0bc26ebac106752d0e9 a730b7b0c4824f3397e575b816e422dc  |
| app/definitive-pharmacotherapy-monographs.json                  | 748849 | 6119cc657026daf31697029f21e18547 e9bb18d26d14b084a1e9c44086ef95ab  |
| app/discharge-guidance.ts                                       | 113408 | c4fd5973ba9e4725a8be7ca4c9c31753 97cc177afe2e6603cd5250031ad2d17f  |
| app/dose-audit.ts                                               | 2534   | f317367be0fd7a6647b0188bae7d5b27 6441a22747ab85cfc0ba3e6dcbf2c8b1  |
| app/globals.css                                                 | 63337  | 6c9735d013da7b6a224e9a929e354ed8 0825dd1471a97b224b84c5393201f4e4  |
| app/layout.tsx                                                  | 937    | 1912732dd30bd7b6702747429c4d1c15 459cfcd52e4ea4f1d7b5de40ffb78bd97 |
| app/medicacoes/page.tsx                                         | 123    | 6dd65ad473fc59148b769e41425cffd8 89744e71f34ae61945f01bf93b19973c  |
| app/medication-catalog-expansion.json                           | 53180  | 4269c9a49b5c2ae1b83d16b2877817d4 b681ece2e4ca97d3c76cf5e4f341800f  |
| app/medication-inventory.json                                   | 578597 | 87577960b5fd3d2f56965a2d68b0d934 29aa9f3b53bfe8321fad16e9e1c8dfa0  |
| app/nexo-document-audit.json                                    | 87156  | 726ffe712bfc773ff4ff10cc8b5eed18 48a3c5519dffab8d6a2050ab4741ce3e  |
| app/page.tsx                                                    | 321921 | 7f3879ea10f01b2f9bb6c1442be27199 843f003978d6497c88f28e913ec05497  |
| app/pdf-supplemental-guidance.ts                                | 11462  | 3c0e0d1ba943a839b34e5ad505e28c83 1aa53007561ffaef0fcb27eb9fa2f53b4 |
| app/pdf-therapeutic-lines.ts                                    | 24826  | 6e6ea34a64b3d77a7e5a990441d50db4 10f4da33598cef35bc4e55cdc299ddb2  |
| app/protocolos/page.tsx                                         | 123    | a487aaf0e340722ddedd0b822a6a2bd0 805e3cb8e45d848c0fcbcb43ad04f339  |
| app/recipe-source-guidance.ts                                   | 5646   | 195e54b0e09a0cd6568a8d6d7123100f 40bd075921716cb96ed57c19412eb1b9  |
| app/requested-diagnoses.ts                                      | 9129   | 41c0c3f4d4d4e080ef13a0ba9f1acab6 c0bbe59bbf8126f9082a0ee2f8976a1f  |
| build/sites-vite-plugin.ts                                      | 1254   | 81b7cbfaeb970611572256aba0e31342 5beb3809f6426f63750696c15d9c756b  |
| db/index.ts                                                     | 423    | dc7610b00b918e0ffff1360a63626f16 655ced3064b2eaf96095a4101fb14bcd  |
| db/schema.ts                                                    | 169    | 13ddacbf0be50e054d450a6c642b7fdc 1aa943fd6b99084711e07e58b600390d  |
| drizzle.config.ts                                               | 148    | af081f7384aeb0082cf422e29f139d1 37ca2f6a57c69b2c37b9fb1f8479867b   |
| drizzle/meta/_journal.json                                      | 61     | 90cb374e093894d0efce6f1830d873a4 2aadd8ba49d2f024495e5cb2e1c8c303  |
| eslint.config.mjs                                               | 465    | 870f1adccfecf3051cbcd9fd307cef51d 7633cf510979c181a81f4b1797273493 |

| Arquivo                                                               | Bytes  | SHA-256                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| examples/d1/app/api/notes/route.ts                                    | 1700   | a3d4a74fd53b7bf53e2df41f169d9d9d 44a8b22aeb6d92f4e754956079af8909   |
| examples/d1/db/schema.ts                                              | 370    | d89eabd95716ce404f5f7ca2a2542204 35be8ddce7c899d7ef461ff22ec80454   |
| next.config.ts                                                        | 133    | 614bce25b089c3f19b1e17a6346c74b8 58034040154c6621e7d35303004767cc   |
| package-lock.json                                                     | 380145 | 283dbdf55081ff6e460baff80764f39f 722f13a0720e1a5fa13153ea877051a5   |
| package.json                                                          | 1436   | 56cae7e7631b97506c3897ae2bd01740 1bd99850b36aa6cc55800757b5554650   |
| postcss.config.mjs                                                    | 94     | dfac7ac2d86d326a0e5adb024e7943c1 81393ed17a5fcb8f0315b24c7da6ddde   |
| public/acervo-fontes/NEXO_Farmacoterapia_Pediatrica_Monocromatica.pdf | 999462 | d9c70753033f38f753eb5bc4eacc4af9 0b1f6507f8bf9a74784c9f0a1c8f8f97   |
| public/acervo-fontes/guia-completo-farmacoterapia-pediatrica.docx     | 251864 | 6894fe7b9b15cb3c4cdcfa8146bbc7 51f7fd057360c1f6989bfb83978d7177     |
| public/acervo-fontes/guia-farmacoterapia-pediatrica.pdf               | 250401 | d381edd5ec69d799763f20224e1c1ca a2669c405f3352291ff2037c5e2e19bd    |
| public/acervo-pdfs/manual-integral-expandido.pdf                      | 124482 | a75dc713faf0ef78826c10cced530192 cf97cb5aea24f47a3eab084faf91a699   |
| public/acervo-pdfs/receitas-modelos.pdf                               | 302867 | 80ae210ac1f055865d4a425bdc464e9c c18cebd7469b2a5c8283c405790d3031   |
| public/acervo-pdfs/sintese-etiolologica-sintomatica.pdf               | 57396  | afa5c50f16380ca344090df96ddf2db0 3ddfe847dbf202f2fce51048a80feb1456 |
| public/acervo-pdfs/volume-1-grupos-1-a-5.pdf                          | 49672  | eece6ec442faa64ac04514a56b3477ca 47a52675699029d1f2a4e1013101009a   |
| public/acervo-pdfs/volume-2-grupos-6-a-8.pdf                          | 44301  | 30e679bf6b68cb8f64eb3b98b21a70e9 df26725a1ad3b8a17539dc39ab8149a2   |
| public/acervo-pdfs/volume-3-grupos-9-a-12.pdf                         | 51516  | 77a0927c45775bb8d81a4a16dea5d90c b153505bc22d9c17a920874631aea52f   |
| public/acervo-pdfs/volume-4-grupos-13-a-15.pdf                        | 70492  | d4f37ff1e6307f3c5b1245c49c6d087d 3fc2c9b143fbaf2a24078512a1c8d7d2   |
| public/acervo-texto/NEXO_Farmacoterapia_Pediatrica_Monocromatica.txt  | 871178 | 8d22e9e6bd43f34f22aff7a7425328c0 a68005f9a74213f6cbb7e7f519f33edb   |
| public/acervo-texto/guia-completo-farmacoterapia-pediatrica.txt       | 490464 | c70b8a36658f1c706243ba091bcd9d19 90d6cf8ec23d749c0ec8d74069b2c7e5   |
| public/acervo-texto/guia-farmacoterapia-pediatrica.txt                | 570995 | d3c01e35b6ffe717c61a9366f777c65a 6bebaa86f94c75573bb83c937d22627a   |
| public/acervo-texto/manual-integral.txt                               | 33924  | 8b3fe855e1f3710911bc64edbfd4258e b132e6107e843bb7bd3bf409c9f5b9e9   |
| public/acervo-texto/receitas.txt                                      | 32032  | ad2ce2f6ad11f905a2544da7e0b5873b a6236acbf5dd689262133d2f30c2feb8   |
| public/acervo-texto/sintese.txt                                       | 9589   | d857e3ca100a7ca1627af7edb12566d0 c081d387537c7be261cc2e308a4224e0   |
| public/acervo-texto/volume-1.txt                                      | 6654   | 13fd309b93b80dc48dbe9ccc6116f82a 1b08824bbf7bb2d1a8aaff0d31cfdc81   |
| public/acervo-texto/volume-2.txt                                      | 7510   | dc625ee51688225b98c8ead4bc97c38 98b206b48ede4902be392f1facb8207c    |
| public/acervo-texto/volume-3.txt                                      | 7952   | 8d898a508fbb7466c5aeb9032c22cb90 a76ff3f1dc7677d47df55d8590bf209    |
| public/acervo-texto/volume-4.txt                                      | 13283  | e7c7880cfbc55eb002b41fec8db2b5b3 3b676115200ed22565d460554d2902f5   |
| public/favicon.svg                                                    | 712    | e6d2e59b7b5bbb0342e0fb496dfc262d ecbfe4426bbb7b047aec8d467d1dc6f7   |
| public/file.svg                                                       | 391    | 2b67812c325c199a02536cdbeea0c593 a72f707d323b72ee3e08dbab06753bd4   |
| public/globe.svg                                                      | 1035   | b614b9bf183925957661ac851498fe1d 8029fd43a62fbfed86f9e2624a57e7cf   |
| public/window.svg                                                     | 385    | 644768c4aaeb4767bce293344eeb0c12 5fb804a94d80144042407220d85e3a1    |
| scripts/build-attached-coverage.mjs                                   | 2953   | c66bf9fb254d12d30924a82bf5b5c0f3 e785e4fccbe1e55456cbc5d49a0ffb86   |
| scripts/build-verified.sh                                             | 815    | 912a5b8515b11c6c5f15128dab4caef ad06c914abc9f9fb8d9c2797e9c62fbe4   |
| scripts/import-definitive-pharmacotherapy-guides.mjs                  | 3734   | f69457e2d7d67147c5ea1a4b9096e8a1 3912481df0151d3928798c7db911594a   |
| scripts/import-medication-inventory.mjs                               | 2432   | 2faf5eca756164ca9fda1c23cecfccc3 f316f635303daab5dafb2c109d7dad     |
| scripts/import-nexo-consolidated.mjs                                  | 2785   | c91d68bf3aa5544c249c797037d79003 0265e1437d0676f36cb09806ad8bf89a   |
| scripts/install-ci.sh                                                 | 6430   | c86541a04dec39f982eb6b103b60e3b3 76c518e84816b7876635877fb4c8569f   |
| scripts/sites-env.sh                                                  | 1530   | df86ebfc27d2f00860036658e933ac0d dd7b5f6879aa5d51218f0863c7e1fb60   |
| scripts/validate-artifact.sh                                          | 1220   | 826354a781d909a664342b6a6f1a3155 529e21f757dc163befa937420c713c2b   |
| scripts/validate-diagnosis-catalog.mjs                                | 1014   | 053795b2fe9494df55935794d56f114d f65468cc56b1fb143aee73a2786b7cb0   |
| scripts/validate-medication-catalog.mjs                               | 6331   | 17922d7fa6e83d7f2bbc9fd4938befb7 55b2b39d8e050fbf9138a208e2e559d2   |
| tests/discharge-guidance.test.mjs                                     | 11644  | 7ffc0c07c6cffe4409ec3dbb6042bb8 4053d3a26ed3c24409bb081b1675e124    |
| tests/dose-audit.test.mjs                                             | 1833   | b77cf11b5cacbab4cda3b0ba72d400b2 77f35ccc9ab1a4e3a09e386ab103a745   |
| tests/rendered-html.test.mjs                                          | 1443   | fd7f2bfa876fce6e31536ec1b1ef6eb3 2a8affcf56806b621ee6631643e18836d  |
| tsconfig.json                                                         | 666    | be18523b23b78b6e1a876ddd107d330f 0168bddf09d751b57e0b5edce69c66f3   |
| tsconfig.tsbuildinfo                                                  | 203351 | e67b2ce73bf5df2a556c794236ded059 41e9c15470052ac2543e9b545bf1b2f3   |
| vite.config.ts                                                        | 1807   | 43e5f02f727ca043f08ebf34789f3305 80a7a0cb90f426c92f4a454d066988fc   |
| worker/index.ts                                                       | 1731   | 2ed36d7fa996e946d9d7695c5925e776 0246f6bf8fa35c06f1bc515c087dc450   |

# 11.2 emergencia-pediatrica-doses

| Arquivo                                                        | Bytes   | SHA-256                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| .gitignore                                                     | 498     | 35d940f5e608b2a4ef2a41ecf7263d2d4e3e18aa8aab9a98a57fa57e5607dfa5  |
| .npmrc                                                         | 76      | 494e64a8818b6158e89321250500ad5a0d18e33ad5cfea06a1cacd2cf4da75fa  |
| .openai/hosting.json                                           | 91      | 3ac2d1fe523a0abdd88f2eab06074a03d424add4069a7db7b5368ac5785c37f3  |
| README.md                                                      | 5436    | 70ef40d45f8c381c87651db8828a2b085bfe3522eebccef2e074fc93a68716d9  |
| app/chatgpt-auth.ts                                            | 2404    | 17a965f8948b21510cdf8ecbd70c5fdf58100e10970463f6a8fd2cc4795f8044  |
| app/data/attached-medication-inventory.json                    | 67544   | fe4221bb531eb22b2208e9241bf73fdc1c21ba472f5bcd8fffb0c04367251a61a |
| app/data/calculation-helpers.ts                                | 2468    | 5abd176fd65286f648dd948634027bc4cf3efb1d735256a023235f75bbd379ec  |
| app/data/clinical-data.json                                    | 251665  | 41160f6a5fd3552af512d92ef54cbf1e7e81c28116848bbd75244df62296631   |
| app/data/definitive-guides.json                                | 1086906 | 8948017028890a2f224f01c87606eff06ad0e49dc868aa990879ed072a2c8c73  |
| app/data/evidence-expansion-2026.ts                            | 22940   | 3f072547d3391848b10303a05cb1ff143a43141350aa225cf51d74a7d1a454e1  |
| app/data/expanded-medications.ts                               | 149675  | f55601cc86ae304913fd08a9d47041e0073946a82a46f4dd7834dcd059670e8f  |
| app/data/nexo-consolidated.json                                | 827073  | 7fadf8abea1906112fb7b5defb2d38be189dca29d1008fec62f7435026b04c6   |
| app/data/requested-medications.ts                              | 6542    | 52829e1842abffaf101a1cef5ee298fb95d5adb5717d12112adf33261e9b1460  |
| app/globals.css                                                | 29956   | cebcc164e1f227d35111245db164d674bdf3632c7531aa22b0492e9e5cb68481  |
| app/layout.tsx                                                 | 553     | de0458e0bf3123a56db74f7b5142b429a5546e11cb9593c5a48fd39cfald90dd  |
| app/page.tsx                                                   | 100853  | 618c44af845dae2023301ec6f9c6a45b274383c24dbdc3ff0f050e0ea29198f9  |
| build/sites-vite-plugin.ts                                     | 1254    | 81b7cbfaeb970611572256aba0e313425beb3809f6426f3750696c15d9c756b   |
| db/index.ts                                                    | 423     | dc7610b00b918e0ffff1360a63626f1665ced3064b2eaf96095a4101fb14bcd   |
| db/schema.ts                                                   | 169     | 13ddacbf0be50e054d450a6c642b7fcd1aa943fd6b99084711e07e58b600390d  |
| drizzle.config.ts                                              | 148     | af081f7384aaeb0082cf422e29f139d137ca2f6a57c69b2c37b9fb1f8479867b  |
| drizzle/meta/_journal.json                                     | 61      | 90cb374e093894d0efce6f1830d873a42aadd8ba49d2f024495e5cb2e1c8c303  |
| eslint.config.mjs                                              | 465     | 870f1adcccef3051cbcd9fd307cef51d7633cf510979c181a81f4b1797273493  |
| examples/d1/app/api/notes/route.ts                             | 1700    | a3d4a74fd53b7bf53e2df41f169d9d9d44a8b22aeb6d92f4e754956079af8909  |
| examples/d1/db/schema.ts                                       | 370     | d89eabd95716ce404f5f7ca2a254220435be8ddce7c899d7ef461ff22ec80454  |
| next.config.ts                                                 | 133     | 614bce25b089c3f19b1e17a6346c74b858034040154c6621e7d35303004767cc  |
| package-lock.json                                              | 380145  | 283dbdf55081ff6e460baff80764f39f722f13a0720e1a5fa13153ea877051a5  |
| package.json                                                   | 1513    | b2aa1486531766de3a076fe016e0989ace436629f3b919f4916e0edd1f117bda  |
| postcss.config.mjs                                             | 94      | dfac7ac2d86d326a0e5adb024e7943c181393ed17a5fcb8f0315b24c7da6ddde  |
| public/favicon.svg                                             | 712     | e6d2e59b7b5bbb0342e0fb496dfc262decfbfe4426bbb7b047aec8d467d1dc6f7 |
| public/file.svg                                                | 392     | 1e0ae4d1a1ddf36752988647b731e4abf150c414d069ec83c96fb0aaeff0307   |
| public/fontes/Guia_Completo_Farmacoterapia_Pediatrica.docx     | 251864  | 6894fe7b9b15cb3c4cdcfa8a146bbc751f7fd057360c1f6989bfb83978d7177   |
| public/fontes/Guia_Farmacoterapia_Pediatrica.pdf               | 250401  | d381edd5ec69d799763fc20224e1c1ca2669c405f3352291ff2037c5e2e19bd   |
| public/fontes/NEXO_Farmacoterapia_Pediatrica_Monocromatica.pdf | 999462  | d9c70753033f38f753eb5bc4eacc4af90b1f6507f8bf9a74784c9f0a1c8f8f97  |
| public/globe.svg                                               | 1036    | d051a8c47936990a9085693d307bb7ce1abc1b6d7ed956bcbcaacf674f4ec96b9 |
| public/medicamentos-pediatricos.xlsx                           | 180326  | 6db53d31c9d3b3e97bfc1fd201e85afb3c975984908928bd3e657d6378eb1446  |
| public/window.svg                                              | 386     | decf1cf7bb22b5c99c4857cfdc5718ce5465c4454166317589c83cf73df74b66  |
| scripts/audit-clinical-rows.mjs                                | 3315    | e1e5f268f01499c55a62f5e2a0006021f6636033c0220f17a5d841d4f052d5ec  |
| scripts/build-verified.sh                                      | 699     | f7d8b0b181010ed37633337442115ca282cfdc8f9b0b58db347d7f4e83251b35  |
| scripts/generate-attached-inventory.mjs                        | 942     | c74a4ad90d8322303499def944a4a1b579d3476ce32710f8e84d39b251cd9c95  |
| scripts/generate-clinical-data.mjs                             | 3004    | 77bc806384a08a35f2b5b34180ecd1691e78b62fa89d423ae254306410cabffff |
| scripts/generate-definitive-guides.mjs                         | 2171    | b7f715bbc9e336c4b4ddd1e6f3283bc632d8f9d194c7a61a5c30ed7d4e029a0f  |
| scripts/generate-nexo-source.mjs                               | 2175    | 3a33dcbbffa17a5f35b446ac84fea1c0d4c5e382940a339ba072d3ab070ceea9  |
| scripts/install-ci.sh                                          | 6326    | f63e840679ca885f206d17b7f8285199bb6bcd47ebc360008d04d16b8e54f63c  |
| scripts/sites-env.sh                                           | 1530    | df86ebfc27d2f00860036658e933ac0dd7b5f6879aa5d51218f0863c7e1fb60   |
| scripts/validate-artifact.sh                                   | 1220    | 826354a781d909a664342b6a6f1a3155529e21f757dc163befa937420c713c2b  |
| tests/brazilian-presentations.test.mjs                         | 5621    | bd622d6baabf922383238ed665f2f79cfb97162754047409dedcc8ad00a9683   |
| tests/comprehensive-calculation-audit.test.mjs                 | 18897   | e81115ab3d5abad6465a45333be045770cb2b3a5d8769f8dc824ca54d68034ea  |
| tests/rendered-html.test.mjs                                   | 967     | eae1d187870ad9a4b3f0c37b40589b25c1a2090dcbee19964555cf70c136b118  |

| Arquivo         | Bytes | SHA-256                                                           |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| tsconfig.json   | 666   | be18523b23b78b6e1a876ddd107d330f 0168bddf09d751b57e0b5edce69c66f3 |
| vite.config.ts  | 1807  | 43e5f02f727ca043f08ebf34789f3305 80a7a0cb90f426c92f4a454d066988fc |
| worker/index.ts | 1731  | 2ed36d7fa996e946d9d7695c5925e776 0246f6bf8fa35c06f1bc515c087dc450 |

# 11.3 soroterapia-pediatria

| Arquivo                                                         | Bytes  | SHA-256                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| .gitignore                                                      | 498    | 35d940f5e608b2a4ef2a41ecf7263d2d 4e3e18aa8aab9a98a57fa57e5607dfa5  |
| .npmrc                                                          | 76     | 494e64a8818b6158e89321250500ad5a d018e33ad5cfeae06a1cacd2cf4da75fa |
| .openai/hosting.json                                            | 91     | 64b0447f9eff590f48587ae966e88634 d95523479b60cf1f8138b4e0e4f6e678  |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/geist-001175b1.woff2           | 16540  | 58a6b173d5ca1dec92166ea3c6cb1a84 a4144556d10928ac14e8e6b40e4787bd  |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/geist-52306abf.woff2           | 7968   | f689f638f29fff460a2d5749edb5d5c3 8d7bef0389f32032d871f23fc6ebb008  |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/geist-875ccdd4.woff2           | 14900  | 6129fc8571c3e0cb0a4c41f5160c974a 843b055009dc4ad8858bd808e18a2d86  |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/geist-98bbbccb.woff2           | 29288  | 9b6f5ff45b278c744b5f379a2c4ecbaf 858a842b8eaf82ac8d21b699ca16c608  |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/geist-ff2310f5.woff2           | 7252   | b7a545bbb08256bd809f11cfe66d88da 3e22d169ea4407737b1ef0ec1ed3d791  |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/style.css                      | 1964   | e2a4513be43337172fd39e481dfbed46 b94644b0d55024b1d203f5eb1e762402  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-013b2f2f.woff2 | 23108  | 5f3d6ad60f29d6cb708414ec6887163d 63bf197377ef5417d2483ff31ace6c3b  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-0638449e.woff2 | 5892   | d67e4a94ba498635f764ddca7d1ec427 1f5642f032eb24b426764480f66f8497  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-44745446.woff2 | 14712  | 745994b5cd950ec201b66526375f057d 540847cccfc70f4f24f5f571d26d3923  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-44e03052.woff2 | 12872  | 75b3bedbec35f347c0ae3b416aa8719 41555357e7b0f83767eb5987875589ed   |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-971fb274.woff2 | 7728   | 16e1d48b6dd29eb240aec5db36184eb1 82933c082cd43de7f35af686d58087d2  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-f6b33328.woff2 | 6204   | e27f657e38d52887baa3b6b2f812bef9 3dfdd356f0810e40edd4ee284cc7e9f6  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/style.css                 | 2376   | 80ecf4947efaa98c515075990543b6f4 de7b1caf1b190645959d2633a0596c15  |
| README.md                                                       | 5436   | 70ef40d45f8c381c87651db8828a2b08 5bfe3522eebccef2e074fc93a68716d9  |
| app/chatgpt-auth.ts                                             | 2404   | 17a965f8948b21510cdf8ecbd70c5fdf 58100e10970463f6a8fd2cc4795f8044  |
| app/clinical-data.ts                                            | 14142  | 48ada1d8e8ffb532c6f00ab007f8540a 10462d2418bae88f40da84b0685b28ef  |
| app/globals.css                                                 | 70785  | 453ce691151018ad55fd4530ee316537d 99e545a94ffa00eb37b3cbf320688ce0 |
| app/layout.tsx                                                  | 827    | 4b1154332da2b2fb20663b96b823d07f 586add5b3c834f93ff8a4cc08a0c4aa4  |
| app/page.tsx                                                    | 155029 | 45d0055a71db305f593fcca9ce5688c d1d9a4dc9b0975cc42a4d18ada6f9968   |
| build/sites-vite-plugin.ts                                      | 1254   | 81b7cbfaeb970611572256aba0e31342 5beb3809f6426f63750696c15d9c756b  |
| db/index.ts                                                     | 423    | dc7610b00b918e0ffff1360a63626f16 655ced3064b2eaf96095a4101fb14bcd  |
| db/schema.ts                                                    | 169    | 13ddacbf0be50e054d450a6c642b7fcd 1aa943fd6b99084711e07e58b600390d  |
| drizzle.config.ts                                               | 148    | af081f7384aaeb0082cf422e29f139d1 37ca2f6a57f6c9b2c37b9fb1f8479867b |
| drizzle/meta/_journal.json                                      | 61     | 90cb374e093894d0efce6f1830d873a4 2aadd8ba49d2f024495e5cb2e1c8c303  |
| eslint.config.mjs                                               | 465    | 870f1adcccef3051cbcd9fd307cef51d 7633cf510979c181a81f4b1797273493  |
| examples/d1/app/api/notes/route.ts                              | 1700   | a3d4a74fd53b7bf53e2df41f169d9d9d 44a8b22aeb6d92f4fe754956079af8909 |
| examples/d1/db/schema.ts                                        | 370    | d89eabd95716ce404f5f7ca2a2542204 35be8ddce7c899d7ef461ff22ec80454  |
| next.config.ts                                                  | 133    | 614bce25b089c3f19b1e17a6346c74b8 58034040154c6621e7d35303004767cc  |
| package-lock.json                                               | 378701 | 639efba46459aed12f983129801b8173 e178af778e89790d56f1978b7da5dece  |
| package.json                                                    | 1427   | f0c1a620488951ae5d7df7cca165f6a2 230880a52c918fec5432f76c4ddc6bb4  |
| postcss.config.mjs                                              | 94     | dfac7ac2d86d326a0e5adb024e7943c1 81393ed17a5fcb8f0315b24c7da6ddde  |
| public/favicon.svg                                              | 712    | e6d2e59b7b5bbb0342e0fb496dfc262d ecbfe4426bbb7b047aec8d467d1dc6f7  |
| public/file.svg                                                 | 392    | 1e0ae4d1a1ddf3a36752988647b731e4a bf150c414d069ec83c96fb0aaeff0307 |
| public/globe.svg                                                | 1036   | d051a8c47936990a9085693d307bb7ce a1bc1b6d7ed956bcbacaf674f4ec96b9  |
| public/window.svg                                               | 386    | decf1cf7bb22b5c99c4857cfdc5718ce 5465c4454166317589c83fc73df74b66  |
| scripts/build-verified.sh                                       | 699    | f7d8b0b181010ed37633337442115ca2 82cfdc8f9b0b58db347d7f4e83251b35  |
| scripts/install-ci.sh                                           | 6326   | f63e840679ca885f206d17b7f8285199 bb6bcd47ebc360008d04d16b8e54f63c  |
| scripts/sites-env.sh                                            | 1530   | df86ebfc27d2f00860036658e933ac0d dd7b5f6879aa5d51218f0863c7e1fb60  |
| scripts/validate-artifact.sh                                    | 1220   | 826354a781d909a664342b6a6f1a3155 529e21f757dc163befa937420c713c2b  |
| tests/rendered-html.test.mjs                                    | 967    | eae1d187870ad9a4b3f0c37b40589b25 c1a2090dcbcee19964555cf70c136b118 |
| tsconfig.json                                                   | 666    | be18523b23b78b6e1a876ddd107d330f 0168bddf09d751b57e0b5edce69c66f3  |
| vite.config.ts                                                  | 1807   | 43e5f02f727ca043f08ebf34789f3305 80a7a0cb90f426c92fa454d066988fc   |

| Arquivo         | Bytes | SHA-256                                                           |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| worker/index.ts | 1731  | 2ed36d7fa996e946d9d7695c5925e776 0246f6bf8fa35c06f1bc515c087dc450 |

# 11.4 ventilacao-mecanica

| Arquivo                                                         | Bytes  | SHA-256                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| .gitignore                                                      | 498    | 35d940f5e608b2a4ef2a41ecf7263d2d4e3e18aa8aab9a98a57fa57e5607dfa5   |
| .npmrc                                                          | 76     | 494e64a8818b6158e89321250500ad5a d018e33ad5cfea06a1cacd2cf4da75fa  |
| .openai/hosting.json                                            | 91     | 7323e6d209f964ee15bc5db1fdc309b 2d33a9dedd38a9cf5eae65d3fc41ae7    |
| .vinext/fonts/faustina-47b1856850a7/faustina-4e676705.woff2     | 9696   | 0c0468a558c3cd2695722627fc487c27 793dd525ec1b76bd40742a16065c2e7b  |
| .vinext/fonts/faustina-47b1856850a7/faustina-785be093.woff2     | 26760  | 422fca604376aa1aac04992e92af319e e55840666245649a17dae80895b9c594  |
| .vinext/fonts/faustina-47b1856850a7/faustina-e13f1b0b.woff2     | 24248  | 11d333d05d485b3eaf7ffa6f5df81c11 ede3e8746bc918c861bdab81a76e4c9c  |
| .vinext/fonts/faustina-47b1856850a7/style.css                   | 1326   | e87ae1e4337defb66fa6aad0de5a8845 b32acae4867d140662157da695376109  |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/geist-001175b1.woff2           | 16540  | 58a6b173d5ca1dec92166ea3c6cb1a84 a4144556d10928ac14e8e6b40e4787bd  |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/geist-52306abf.woff2           | 7968   | f689f638f29fff460a2d5749edb5d5c3 8d7bef0389f32032d871f23fc6ebb008  |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/geist-875ccdd4.woff2           | 14900  | 6129fc8571c3e0cb0a4c1f5160c974a 843b055009dc4ad8858bd808e18a2d86   |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/geist-98bbbccb.woff2           | 29288  | 9b6f5ff45b278c744b5f379a2c4ecbaf 858a842b8eaf82ac8d21b699ca16c608  |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/geist-ff2310f5.woff2           | 7252   | b7a545bbb08256bd809f11cfe66d88da 3e22d169ea4407737b1ef0ec1ed3d791  |
| .vinext/fonts/geist-8ac0455e797f/style.css                      | 1949   | f90de39112764a7c76c6cca1086efb25 6f41a8bc482272a52809453001915eb2  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-013b2f2f.woff2 | 23108  | 5f3d6ad60f29d6cb708414ec6887163d 63bf197377ef5417d2483ff31ace6c3b  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-0638449e.woff2 | 5892   | d67e4a94ba498635f764ddca7d1ec427 1f5642f032eb24b426764480f66f8497  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-44745446.woff2 | 14712  | 745994b5cd950ec201b66526375f057d 540847cccfc70f4f24f5f571d26d3923  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-44e03052.woff2 | 12872  | 75b3bedbebc35f347c0ae3b416aa8719 41555357e7b0f83767eb5987875589ed  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-971fb274.woff2 | 7728   | 16e1d48b6dd29eb240aec5db36184eb1 82933c082cd43de7f35af686d58087d2  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/geist-mono-f6b33328.woff2 | 6204   | e27f657e38d52887baa3b6b2f812bef9 3dfdd356f0810e40edd4ee284cc7e9f6  |
| .vinext/fonts/geist-mono-00e989178794/style.css                 | 2358   | 533487550e79094f987e8bdab1e92a81 cc9ae6f85dc0b11b8f2ea3665794480d  |
| README.md                                                       | 5436   | 70ef40d45f8c381c87651db8828a2b08 5bfe3522eebccef2e074fc93a68716d9  |
| app/chatgpt-auth.ts                                             | 2404   | 17a965f8948b21510cdf8ecbd70c5fdf 58100e10970463f6a8fd2cc4795f8044  |
| app/globals.css                                                 | 64472  | 4153db13cf4d30f45c5a01bbf1b78b4b 7907f4610d47d3998e5b67f09e1601aa  |
| app/layout.tsx                                                  | 703    | b82f64d7643efd4bc4e9dbc948691bf6 cfcbc870314c8d0380a582a19784cf2a  |
| app/page.tsx                                                    | 154956 | ec5db556a0d50863ca7bfd68e2633f68 c0d37e95d31864cc1901382e9b7bfaec  |
| build/sites-vite-plugin.ts                                      | 1254   | 81b7cbfaeb970611572256aba0e31342 5beb3809f6426f3750696c15d9c756b   |
| db/index.ts                                                     | 423    | dc7610b00b918e0ffff1360a63626f16 655ced3064b2eaf96095a4101fb14bcd  |
| db/schema.ts                                                    | 169    | 13ddacbfb0be50e054d450a6c642b7fdc 1aa943fd6b99084711e07e58b600390d |
| drizzle.config.ts                                               | 148    | af081f7384aaeb0082cf422e29f139d1 37ca2f6a57c69b2c37b9fb1f8479867b  |
| drizzle/meta/_journal.json                                      | 61     | 90cb374e093894d0efce6f1830d873a4 2aadd8ba49d2f024495e5cb2e1c8303   |
| eslint.config.mjs                                               | 465    | 870f1adcccf3051cbcd9fd307cef51d 7633cf510979c181a81f4b1797273493   |
| examples/d1/app/api/notes/route.ts                              | 1700   | a3d4a74fd53b7bf53e2df41f169d9d9d 44a8b22aeb6d92f4e754956079af8909  |
| examples/d1/db/schema.ts                                        | 370    | d89eabd95716ce404f5f7ca2a2542204 35be8ddce7c899d7ef461ff22ec80454  |
| next.config.ts                                                  | 133    | 614bce25b089c3f19b1e17a6346c74b8 58034040154c6621e7d35303004767cc  |
| package-lock.json                                               | 380145 | 283dbdf55081ff6e460baff80764f39f 722f13a0720e1a5fa13153ea877051a5  |
| package.json                                                    | 1403   | 6ed65c23a51d519d38b1e5d7a864b20f ca135d4bc422a7480022a04cb6992ef8  |
| postcss.config.mjs                                              | 94     | dfac7ac2d86d326a0e5adb024e7943c1 81393ed17a5fc8f0315b24c7da6ddde   |
| public/favicon.svg                                              | 712    | e6d2e59b7b5bbb0342e0fb496dfc262d ecbfe4426bbb7b047aec8d467d1dc6f7  |
| public/file.svg                                                 | 392    | 1e0ae4d1a1ddfa36752988647b731e4a bf150c414d069ec83c96fb0aaeff0307  |
| public/globe.svg                                                | 1036   | d051a8c47936990a9085693d307bb7ce a1bc1b6d7ed956bcbaacf674f4ec96b9  |
| public/golden-background.png                                    | 507418 | 3fa9efdd4c969cd639625952d2e50b2e 0d6a6fcd1c6892acd9d7f9594870c62e  |
| public/window.svg                                               | 386    | decf1cf7bb22b5c99c4857cfdcd5718ce 5465c4454166317589c83fc73df74b66 |
| scripts/build-verified.sh                                       | 699    | f7d8b0b181010ed37633337442115ca2 82cfdc8f9b0b58db347d7f4e83251b35  |
| scripts/install-ci.sh                                           | 6326   | f63e840679ca885f206d17b7f8285199 bb6bcd47ebc360008d04d16b8e54f63c  |
| scripts/sites-env.sh                                            | 1530   | df86ebfc27d2f00860036658e933ac0d dd7b5f6879aa5d51218f0863c7e1fb60  |

| Arquivo                      | Bytes  | SHA-256                                                           |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| scripts/validate-artifact.sh | 1220   | 826354a781d909a664342b6a6f1a3155 529e21f757dc163befa937420c713c2b |
| tests/rendered-html.test.mjs | 1228   | 772accfa8e445c6af74b819e408958c3 749395667678436def974ffd14481293 |
| tsconfig.json                | 666    | be18523b23b78b6e1a876ddd107d330f 0168bddf09d751b57e0b5edce69c66f3 |
| tsconfig.tsbuildinfo         | 201065 | 90e6c3847a728c56a0a772e03fa4595e e6a9f4eae71ae9581322ddaebcbf8772 |
| vite.config.ts               | 1807   | 43e5f02f727ca043f08ebf34789f3305 80a7a0cb90f426c92f4a454d066988fc |
| worker/index.ts              | 1731   | 2ed36d7fa996e946d9d7695c5925e776 0246f6bf8fa35c06f1bc515c087dc450 |

# 11.5 folha-de-parada

| Arquivo                            | Bytes  | SHA-256                                                           |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| .gitignore                         | 498    | 35d940f5e608b2a4ef2a41ecf7263d2d4e3e18aa8aab9a98a57fa57e5607dfa5  |
| .npmrc                             | 76     | 494e64a8818b6158e89321250500ad5a d018e33ad5cfea06a1cacd2cf4da75fa |
| .openai/hosting.json               | 91     | 3780b267c2c738e7cc8eb8d88079f8e3 37fb296ed8130182b5bd7db6547415a9 |
| README.md                          | 5436   | 70ef40d45f8c381c87651db8828a2b08 5bfe3522eebccef2e074fc93a68716d9 |
| app/chatgpt-auth.ts                | 2404   | 17a965f8948b21510cdf8ecbd70c5fdf 58100e10970463f6a8fd2cc4795f8044 |
| app/clinical-data.ts               | 72295  | 422c636050edd4d259d8d8a30bc347f1 ad9dcae4c252d2a660339465545d9335 |
| app/globals.css                    | 28400  | c6be7351fc1a60b053abc19935a106c7 00d9fe72f94dbea28c1cd05eb419a2f3 |
| app/layout.tsx                     | 570    | fbae3446cb4dec838bec6ceb7a793859 cf2947d0a1d83fe6c98143eff3963864 |
| app/page.tsx                       | 18868  | 80fcd310593937b8d37398f51628e07c b420a572db5218c531bec5bb4766e5f7 |
| build/sites-vite-plugin.ts         | 1254   | 81b7cbfaeb970611572256aba0e31342 5beb3809f6426f63750696c15d9c756b |
| db/index.ts                        | 423    | dc7610b00b918e0ffff1360a63626f16 655ced3064b2eaf96095a4101fb14bcd |
| db/schema.ts                       | 169    | 13ddacb0be50e054d450a6c642b7fcd 1aa943fd6b99084711e0758b600390d   |
| drizzle.config.ts                  | 148    | af081f7384aaeb0082cf422e29f139d1 37ca2f6a57c69b2c37b9fb1f8479867b |
| drizzle/meta/_journal.json         | 61     | 90cb374e093894d0efce6f1830d873a4 2aadd8ba49d2f024495e5cb2e1c8c303 |
| eslint.config.mjs                  | 465    | 870f1adcccf3051cbcd9fd307cef51d 7633cf510979c181a81f4b1797273493  |
| examples/d1/app/api/notes/route.ts | 1700   | a3d4a74fd53b7bf53e2df41f169d9d9d 4xa8b22aeb6d92f4e754956079af8909 |
| examples/d1/db/schema.ts           | 370    | d89eabd95716ce404f5f7ca2a2542204 35be8ddce7c899d7ef461ff22ec80454 |
| next.config.ts                     | 133    | 614bce25b089c3f19b1e17a6346c74b8 58034040154c6621e7d35303004767cc |
| package-lock.json                  | 380145 | 283dbdf55081ff6e460baff80764f39f 722f13a0720e1a5fa13153ea877051a5 |
| package.json                       | 1380   | d22c571af916f9d34193175d60293baf 8d497ce39ecedf9acebf7ff9c85bca31 |
| postcss.config.mjs                 | 94     | dfac7ac2d86d326a0e5adb024e7943c1 81393ed17a5fcb8f0315b24c7da6ddde |
| public/favicon.svg                 | 712    | e6d2e59b7b5bbb0342e0fb496dfc262d ecbfe4426bbb7b047aec8d467d1dc6f7 |
| public/file.svg                    | 392    | 1e0ae4d1a1ddfa36752988647b731e4a bf150c414d069ec83c96fb0aaeff0307 |
| public/globe.svg                   | 1036   | d051a8c47936990a9085693d307bb7ce a1bc1b6d7ed956bcbacaf674f4ec96b9 |
| public/window.svg                  | 386    | decf1cf7bb22b5c99c4857cfcd5718ce 5465c4454166317589c83fc73df74b66 |
| scripts/build-verified.sh          | 699    | f7d8b0b181010ed3763337442115ca2 82cfdc8f9b0b58db347d7f4e83251b35  |
| scripts/install-ci.sh              | 6326   | f63e840679ca885f206d17b7f8285199 bb6bcd47ebc360008d04d16b8e54f63c |
| scripts/sites-env.sh               | 1530   | df86ebfc27d2f00860036658e933ac0d dd7b5f6879aa5d51218f0863c7e1fb60 |
| scripts/validate-artifact.sh       | 1220   | 826354a781d909a664342b6a6f1a3155 529e21f757dc163befa937420c713c2b |
| tests/rendered-html.test.mjs       | 967    | eae1d187870ad9a4b3f0c37b40589b25 c1a2090dcbee19964555cf70c136b118 |
| tsconfig.json                      | 666    | be18523b23b78b6e1a876ddd107d330f 0168bddf09d751b57e0b5edce69c66f3 |
| vite.config.ts                     | 1807   | 43e5f02f727ca043f08ebf34789f3305 80a7a0cb90f426c92f4a454d066988fc |
| worker/index.ts                    | 1731   | 2ed36d7fa996e946d9d7695c5925e776 0246f6bf8fa35c06f1bc515c087dc450 |

## 12. Checklist de migração e continuidade

- ☐ Confirmar slug, URL, versão e commit do Site alvo.
- ☐ Comparar SHA-256 do arquivo de versão e dos arquivos rastreados.
- ☐ Restaurar datasets e documentos incorporados, não apenas o prompt portátil.
- ☐ Preservar a separação entre inventário documental e linhas calculáveis.
- ☐ Revalidar apresentações brasileiras, doses, contraindicações, estabilidade e compatibilidade contra fontes atuais antes de uso clínico.
- ☐ Executar testes do projeto, incluindo checagem reversa e cenários-limite por idade/peso.
- ☐ Verificar acesso, ausência de visitantes externos, variáveis de ambiente e domínios.
- ☐ Publicar somente após revisão humana das mudanças e inspeção do resultado.

### Conclusão

Este PDF é a exportação humana e auditável mais abrangente possível a partir das superfícies disponíveis em 22/08/2026. O estado clínico executável continua definido pelos arquivos versionados cujos hashes constam no manifesto. Solicitações históricas sem evidência na versão atual foram mantidas como histórico ou pendência, e não promovidas a regra ativa.